

Bunga Rampai **KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KEPERAWATAN**

Rahma Yulis ▪ Sri rusmini ▪ Septian M. Rahayu ▪ Weni L. Hendayani
Syaiful ▪ Ana Fadilah ▪ Viere A. Siauta ▪ Sondang Manurung ▪ Aemilianus Mau

Editor : Fitriana Dewi



BUNGA RAMPAI KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KEPERAWATAN

Penulis:

Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sri rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., Fisqua.
Septian Mugi Rahayu, Ners., M.Kep.
Ns. Weni Lidya Hendayani, M.Kep.
Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.
Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Viere Allanled Siauta, S.Kep., M.Kep.
Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Fitriana Dewi, S. Kep., M.Kep.



Bunga Rampai: Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan

Penulis: Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sri rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., Fisqua.
Septian Mugi Rahayu, Ners., M.Kep.
Ns. Weni Lidya Hendayani, M.Kep.
Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.
Ana Fadilah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
Ns. Viere Allanled Siauta, S.Kep., M.Kep.
Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Fitriana Dewi, S. Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-65-8

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Bunga rampai kepemimpinan dalam manajemen keperawatan / Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep., Sri rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., Fisqua, Septian Mugi Rahayu, Ners., M.Kep., Ns. Weni Lidya Hendayani, M.Kep., Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes., [dan 4 lainnya] ; editor, Ns. Fitriana Dewi, S. Kep., M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Maret 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	113 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-65-8
SUBJEK	Keperawatan -- Kepemimpinan
KLASIFIKASI	610.730 68 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1196617



PRAKATA



Buku Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan ini hadir sebagai panduan penting dalam memahami dan mengembangkan berbagai aspek kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam dunia keperawatan. Keperawatan tidak hanya berfokus pada pemberian perawatan yang terbaik kepada pasien, tetapi juga mencakup pengelolaan tim, peningkatan kualitas pelayanan, serta penanganan situasi krisis yang mungkin terjadi di lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kepemimpinan sangat penting bagi perawat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pelayanan kesehatan.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai Kepemimpinan Transformasional dalam Keperawatan, yang menekankan pada pentingnya perubahan positif dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dan pengelolaan tim keperawatan. Selanjutnya, Peran Kepala Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan memberikan wawasan tentang bagaimana seorang kepala perawat harus berperan sebagai pemimpin yang dapat memotivasi, menginspirasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesionalisme perawat.

Buku ini juga mengangkat topik yang tidak kalah penting, seperti Kepemimpinan dalam Peningkatan Keselamatan Pasien, yang menjelaskan bagaimana peran pemimpin dalam memastikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Di sisi lain, Peran Kepemimpinan dalam Menanggulangi Krisis Global Kesehatan menyoroti tanggung jawab besar para pemimpin di bidang keperawatan untuk dapat bertindak cepat dan efektif saat menghadapi situasi darurat atau pandemi global yang mempengaruhi sistem kesehatan secara keseluruhan.

Pentingnya Model Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan juga dibahas dalam buku ini, di mana keputusan-keputusan yang diambil dalam manajemen keperawatan seharusnya melibatkan kolaborasi antara tim perawat untuk mendapatkan hasil terbaik. Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan: Pembangunan Tim yang Efektif dalam Keperawatan mengulas bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan dan memelihara tim perawat yang solid dan berfungsi dengan baik dalam pelayanan pasien.

Di dalam buku ini, pembaca juga akan menemukan pembahasan mengenai Kepemimpinan dalam Manajemen Krisis di Rumah Sakit, yang memberikan gambaran

tentang cara pemimpin keperawatan dapat mengelola dan mengatasi tantangan-tantangan berat yang dihadapi oleh rumah sakit, termasuk situasi darurat dan bencana. Selain itu, topik Mentoring dan Coaching untuk Perawat di Posisi Kepemimpinan memberikan panduan bagi pemimpin yang ingin membimbing perawat muda dalam mencapai potensi terbaik mereka.

Akhirnya, Mengembangkan Keterampilan Kepemimpinan untuk Perawat Muda membahas tentang pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi generasi penerus perawat yang diharapkan mampu memimpin dengan kompetensi dan keteladanan di masa depan.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi para perawat, baik yang sedang menjalani pendidikan maupun yang telah berada di posisi kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dalam manajemen keperawatan bukan hanya memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien untuk semua pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan.

Februari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KEPERAWATAN	1
Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional	2
C. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional dalam Keperawatan	3
D. Pentingnya Kepemimpinan Transformasional dalam Praktik Keperawatan	5
E. Tantangan dan Strategi Kepemimpinan Transformasional	9
F. Simpulan	12
G. Referensi.....	12
H. Glosarium.....	14
BAB 2 PERAN KEPALA KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN.....	15
Sri rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., Fisqua.	15
A. Pendahuluan	15
B. Kualitas Pelayanan	16
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Kesehatan	16
D. Tanggung Jawab Kepala Ruangan.....	17
E. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan	19
F. Simpulan	20
G. Referensi.....	20
H. Glosarium.....	21
BAB 3 KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN PASIEN	23
Septian Mugi Rahayu, Ners., M.Kep.....	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Kepemimpinan Dalam Keperawatan.....	25
C. Keselamatan Pasien.....	26
D. Peran Pemimpin dalam Peningkatan Keselamatan Pasien.....	30
E. Simpulan	33
F. Referensi.....	34
G. Glosarium.....	34
BAB 4 PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENANGGULANGI KRISIS GLOBAL KESEHATAN	35
Ns. Weni Lidya Hendayani, M.Kep.....	35
A. Pendahuluan	35

B. Teori Bakat (Trait Theoty).....	36
C. Teori Perilaku.....	36
D. Kesehatan Global	40
E. Literature Review.....	45
F. Kesimpulan.....	47
G. Referensi.....	48
BAB 5 MODEL KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPERAWATAN.....	49
Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.	49
A. Pendahuluan.....	49
B. Teori dan Gaya Kepemimpinan.....	50
C. Konsep Metode Kepemimpinan Partisipatif	52
D. Implementasi Metode Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan.....	54
E. Tantangan dan Strategi Mengatasi dalam Mengimplementasikan Metode Kepemimpinan Partisipatif.....	56
F. Kesimpulan.....	58
G. Referensi.....	59
H. Glosarium.....	60
BAB 6 KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KEPERAWATAN: PEMBANGUNAN TIM YANG EFEKTIF DALAM KEPERAWATAN	61
Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.	61
A. Pendahuluan/Prolog.....	61
B. Tim Keperawatan.....	62
C. Karakteristik Tim Keperawatan yang Efektif.....	64
D. Prinsip-prinsip Pembentukan Tim Keperawatan yang Efektif.....	66
E. Kepemimpinan dalam Pembangunan Tim Keperawatan	67
F. Proses Pembangunan Tim Keperawatan.....	68
G. Tantangan dalam Membangun Tim Keperawatan yang Efektif.....	69
H. Pengukuran Kinerja dan Keberhasilan Tim Keperawatan.....	70
I. Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	71
J. Simpulan	72
K. Referensi.....	73
L. Glosarium.....	76
BAB 7 KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KRISIS DI RUMAH SAKIT	77
Ns. Viere Allanled Siauta, S.Kep., M.Kep.....	77
A. Pendahuluan/Prolog.....	77
B. Konsep Kepemimpinan.....	78
C. Klasifikasi Gaya Kepemimpinan	78
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan	80
E. Syarat Menjadi Pemimpin.....	80
F. Pemimpin Yang Efektif Dalam Keperawatan.....	81

G. Manajemen Strategi Rumah Sakit.....	83
H. Kepemimpinan Dalam Manajemen Krisis di Rumah Sakit	84
I. Kesimpulan.....	87
J. Referensi.....	88
BAB 8 MENTORING DAN COACHING UNTUK PERAWAT DI POSISI KEPEMIMPINAN	89
Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.....	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Pengertian Mentoring Dalam Kepemimpinan Keperawatan	89
C. <i>Coaching</i> Untuk Perawat.....	97
D. Model <i>Coaching</i> Yang Digunakan Untuk Perawat Pemimpin	97
E. Kesimpulan.....	104
F. Referensi.....	104
BAB 9 MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN UNTUK PERAWAT MUDA	107
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.....	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Konsep Dasar Kepemimpinan	108
C. Kompetensi Kepemimpinan dalam Keperawatan	109
D. Tantangan Perawat Muda dalam Kepemimpinan.....	110
E. Strategi Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan.....	111
F. Peran Organisasi Profesi dan Institusi dalam Mendukung Kepemimpinan	113
G. Studi Kasus atau Kisah Inspiratif.....	114
H. Dampak dari pengembangan kepemimpinan perawat muda	116
I. Kesimpulan.....	117
J. Referensi.....	117
K. Glosarium.....	118
PROFIL PENULIS.....	121

BAB 1

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KEPERAWATAN

Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan aspek utama dari proses manajemen perawat. Kepemimpinan dapat memberi penguatan dan menentukan arah dari tim, menghasilkan perawat profesional, menciptakan lingkungan kerja yang aman serta meningkatkan kualitas perawatan. Robbins & Judge (2016) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok agar bisa mencapai visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Marquis & Huston (2013) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai macam peran. Peran seorang pemimpin yaitu; pengambil keputusan, visioner, komunikator, evaluator, fasilitator, pengambil risiko, penasehat, penyemangat, instruktur, konselor, pembimbing, pemikir kritis, *buffer* (penengah), advokat, mampu memprediksi masa depan, mempengaruhi orang lain, menyelesaikan masalah secara kreatif, agen perubahan, diplomat dan role model.

Teori kepemimpinan mengalami perubahan. Teori kepemimpinan awalnya berfokus pada sifat dan perilaku pemimpin, kemudian beralih pada apa yang telah dilakukan pemimpin atau gaya kepemimpinan. Lewin (1951) dan White & Lippit (1960) membagi gaya kepemimpinan menjadi otoriter, demokratis dan *laissez-faire*. Akan tetapi seiring waktu, para ahli percaya bahwa gaya kepemimpinan yang ada di lapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang ada di buku, tetapi bergerak secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya teori kepemimpinan situasional dan kontingensi yaitu gaya kepemimpinan bervariasi sesuai dengan karyawan yang terlibat dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh pada pimpinan. Teori ini kemudian berkembang menjadi teori kepemimpinan interaksional kontemporer dan transformasional. Kepemimpinan interaksional adalah perilaku pemimpin ditentukan oleh hubungan antara kepribadian pemimpin dan situasi tertentu sedangkan kepemimpinan transformasional adalah interaksi antara pemimpin dan bawahan (Marquis & Huston, 2013; Robbins & Judge, 2016).

B. Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional

Kepemimpinan transformasional dicetuskan oleh James Mac Gregor Burns (1978), seorang ahli dibidang interaksi pimpinan bawahan. Burns (1978) menyatakan bahwa pemimpin dan bawahan memiliki kemampuan untuk saling mendukung ke tingkatan motivasi dan moral yang lebih tinggi. Burns membagi dua tipe pemimpin dalam manajemen yaitu pemimpin transaksional dan transformasional (Marquis & Huston, 2013).

Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memimpin melalui pertukaran sosial dengan stafnya. Artinya pemimpin akan menawarkan imbalan finansial atas produktivitas dan menolak memberikan imbalan jika produktivitasnya kurang (Bass & Riggio, 2006). Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang merangsang dan menginspirasi stafnya agar bisa mencapai visi atau hasil yang maksimal dan dalam prosesnya akan mengembangkan kapasitas kepemimpinannya sendiri. Artinya pemimpin membantu stafnya tumbuh dan berkembang dengan cara memenuhi kebutuhannya, memberdayakan, menyelaraskan visi, tujuan dan sasaran staf, pemimpin, kelompok dan organisasi (Bass & Riggio, 2006). Visi adalah fokus utama dari kepemimpinan transformasional yang menyiratkan kemampuan pemimpin menggambarkan keadaan masa depan dan menjelaskannya kepada orang lain (Marquis & Huston, 2013).

Pemimpin transaksional dan transformasional memiliki beberapa perbedaan. Pemimpin transaksional berfokus pada keseharian dan tujuan manajemen, menggunakan transaksi atau pertukaran untuk mencapai tujuan, nilai bersama tidak diidentifikasi, mengkaji penyebab, dan menggunakan hadiah kontingensi (memberikan hadiah/kompensasi untuk perilaku yang diinginkan). Pertukaran didasarkan pada hasil diskusi pemimpin dengan orang lain tentang apa yang dibutuhkan dan menentukan kondisi atau penghargaan yang akan diterima orang lain jika memenuhi persyaratan tersebut. Pemimpin transformasional dalam beberapa hal merupakan perluasan dari pemimpin transaksional atau mengangkat kepemimpinan ke tingkat berikutnya. Fokus: memberdayakan dan menginspirasi orang lain untuk berkomitmen pada visi dan tujuan organisasi, menantang untuk menjadi pemecah masalah yang inovatif dan mencapai kinerja melampaui harapan, memotivasi, membina, mendampingi, menyediakan tantangan dan dukungan pada staf serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan. Tambahan lain, pemimpin transformasional memperhatikan harga diri staf dengan membangun komitmen dan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan (Bass & Riggio, 2006; Marquis & Huston, 2013). Kepemimpinan transaksional dan transformasional saling melengkapi, tidak

saling mempertentangkan pendekatannya untuk menyelesaikan segala sesuatu (Robbins & Judge, 2016).

C. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional dalam Keperawatan

Karakteristik kepemimpinan transformasional meliputi karismatik, menginspirasi, *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), *individual consideration* (pertimbangan individual), menarik, stabil, optimis, memberikan semangat, jujur, motivator, hormat, positif, berorientasi pada tim, komunikator yang efektif, memberdayakan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, empati, mentor, dan visioner (Smith, 2011). Pemimpin karismatik merupakan salah satu gaya kepemimpinan, namun dalam kepemimpinan transformasional merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki pemimpin. Karismatik artinya perawat manajer mampu menyampaikan visinya dengan jelas (Suwekoa & Dwiantoro, 2020), memiliki rasa percaya diri, *self direction* (memiliki inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain), tidak ada konflik internal, memahami kebutuhan staf dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi staf secara positif (Smith, 2011).

Smith kemudian menetapkan empat karakteristik penting yang harus dimiliki kepemimpinan transformasional dalam keperawatan yaitu (Smith, 2011):

1. Komunikator yang efektif

Pemimpin yang berkomunikasi secara efektif akan berfokus pada poin penting yang akan disampaikan dan dibahas serta dapat menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan kemampuan staf dalam memproses dan memahami interaksi. Karakteristik komunikator yang efektif meliputi: empati, menghindari sarkasme, bertanya dan tidak memerintah, menghindari berbicara merendahkan atau memuji seseorang, serta menghormati apa yang disampaikan orang lain. Rasa hormat ditunjukkan dengan meluangkan waktu untuk menjadi pendengar yang penuh perhatian dan memberi orang lain kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan kekhawatirannya (Smith, 2011).

2. Kepribadian yang inspiratif

Kepribadian yang inspiratif terdiri dari optimisme, rasa hormat, semangat, karisma, dan kejujuran. Manajer perawat yang inspiratif memiliki visi yang jelas, mengevaluasi diri secara teratur, memiliki keinginan kuat untuk belajar, mendorong stafnya untuk mengevaluasi diri dan belajar, menghabiskan waktu untuk bekerja dengan staf perawat sehingga memiliki lebih banyak kontak pribadi dengan staf (berbicara, meminta pendapat, mendorong umpan balik, dan bekerja secara langsung), serta mendorong mengembangkan rasa percaya diri dan kepercayaan (Smith, 2011).

3. Sifat dapat dipercaya

Sifat dapat dipercaya adalah sifat penting dari pemimpin transformasional. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik yang bersifat pribadi maupun pekerjaan. Elemen yang membentuk dasar kepercayaan yaitu integritas, keberanian, dan stabilitas. Manajer perawat dapat memperoleh kepercayaan dari staf perawat dengan melakukan tindakan secara jujur, tidak pilih kasih saat berkomunikasi, memiliki ketulusan, bersikap terbuka, realistis, dan adil. Manajer perawat yang memiliki sifat dapat dipercaya lebih mungkin memperoleh kepercayaan dari perawatnya (Smith, 2011).

4. Keterlibatan *stakeholders* dan mengedepankan kerja tim

Melibatkan seluruh *stakeholders* dalam proses kepemimpinan adalah karakteristik yang sangat berpengaruh. Keterlibatan *stakeholders* sangat penting saat evaluasi program awal atau mempertimbangkan reorganisasi, karena *stakeholders* akan memastikan poin-poin penting untuk diidentifikasi dan ditangani. Aspek penting lainnya dari karakteristik ini adalah pemimpin mengedepankan kerjasama tim dan kolaborasi. Melibatkan semua staf keperawatan akan meningkatkan partisipasi staf dalam visi organisasi, yang akan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan organisasi. Kerja sama tim juga merupakan inti dari kesuksesan (Smith, 2011).

Bernard M. Bass menetapkan ada empat elemen atau pilar utama (4I) kepemimpinan transformasional. Elemen tersebut adalah (Bass & Riggio, 2006):

1. *Idealized Influence* (Pengaruh yang Ideal)

Pemimpin transformasional berfungsi sebagai panutan bagi pengikutnya. Panutan dalam hal: perilaku pemimpin, kemampuan, kegigihan, dan tekad yang luar biasa (Bass & Riggio, 2006). Memimpin dengan menjadi panutan atau memberi contoh adalah cara yang ampuh untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain (Ferreira et al., 2020).

2. *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspirasional)

Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka dengan memberikan kepercayaan diri dan tantangan yang tinggi pada pekerjaan staf (Bass & Riggio, 2006). Pemimpin perawat yang inspiratif bersifat memotivasi, peka, bertekad, dan mampu menyampaikan visi organisasi dan mendorong kebanggaan dalam organisasi (Smith, 2011). Karakter ini dapat membangkitkan semangat, antusiasme dan optimisme tim (Bass & Riggio, 2006). Oleh karena itu elemen ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengartikulasikan visi yang jelas dengan gairah dan komitmen.

3. *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual)

Pemimpin transformasional meningkatkan kecerdasan staf dengan mendorong staf untuk menjadi inovatif dan kreatif dalam setiap usaha, serta

menyelesaikan masalah lama dengan pendekatan baru. Ide-ide baru dan solusi kreatif untuk setiap masalah tidak akan dikritik karena berbeda dengan ide-ide pemimpin (Bass & Riggio, 2006). Pemimpin perawat dengan *intellectual stimulation* artinya pemimpin mendorong staf perawat untuk menerapkan *Evidence Based Practice* (EBP) dalam melakukan tindakan klinis tertentu (Smith, 2011). Oleh karena itu perawat manajer perlu menumbuhkan lingkungan kerja dimana staf merasa bebas untuk menyumbangkan ide tanpa takut dikritik atau dipecat.

4. Individualized Consideration (Pertimbangan Individual)

Pemimpin dengan *individual consideration* (pertimbangan individual) adalah sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan staf seperti: pengakuan atas usaha staf, menciptakan rasa percaya diri, mendorong praktik pengembangan diri, komunikasi yang efektif serta pendampingan dan pembinaan pada staf (Ogola et al., 2017). Perilaku kepemimpinan dengan pertimbangan individual (kekuatan dan kelemahan staf) dapat meningkatkan kinerja staf pada tingkatan yang tinggi (Ogola et al., 2017), sebab pemimpin tidak memperlakukan perbedaan kebutuhan dari setiap staf dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing staf (Bass & Riggio, 2006).

American Nurses Association (ANA) menuliskan ciri-ciri pemimpin perawat transformasional meliputi (ANA, 2023):

1. Memimpin dengan memberi contoh, agar bisa menciptakan budaya keunggulan dan perbaikan secara berkelanjutan.
2. Menjalankan tugas rutin dengan kecerdasan dan optimisme, bukan hanya sebagai daftar tugas.
3. Memberikan umpan balik dan pembinaan untuk membantu staf mencapai potensi terbaik mereka.
4. Memperhatikan batas kemampuan staf dan diri sendiri untuk menghindari terjadinya kelelahan emosional

D. Pentingnya Kepemimpinan Transformasional dalam Praktik Keperawatan

Kepemimpinan perawat yang efektif akan berdampak pada lingkungan kerja, produktivitas kerja perawat, dan hasil asuhan keperawatan pasien. Hutchinson & Jackson (2013) menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, penulisan dan penelitian tentang kepemimpinan keperawatan telah didominasi oleh satu teori konseptual, yaitu kepemimpinan transformasional. *American Nurses Association* (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dalam keperawatan memainkan peran penting dalam mempromosikan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Melalui: bimbingan, memotivasi tim untuk bekerja sama, perubahan

dan inovasi melalui pengembangan staf, mendorong harga diri yang positif, memotivasi dan memberdayakan staf pada tingkatan kinerja yang lebih tinggi, membantu proses adaptasi perawat baru, mendorong lingkungan yang sehat. Hasil dari kepemimpinan ini adalah peningkatan kepuasan dan retensi perawat serta kepuasan pasien (ANA, 2023; Smith, 2011). Oleh karena itu seiring perkembangan ilmu keperawatan, pemimpin transformasional dalam keperawatan sangat diperlukan karena ketahanan, rasa inklusivitas, dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan baru (ANA, 2023).

Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dalam keperawatan yaitu:

1. Lingkungan kerja keperawatan

Kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan lingkungan kerja keperawatan melalui menumbuhkan budaya suportif yang ditandai dengan kerja sama tim, komunikasi yang efektif, dan moral staf yang tinggi. Lingkungan kerja yang kondusif ini mendorong kolaborasi, pengembangan profesional, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perawatan pasien (Aljaber et al., 2022).

2. Komitmen organisasi

Kepemimpinan transformasional baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi lingkungan kerja perawat secara positif, melalui mediator, pemberdayaan struktural, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja (Ystaas et al., 2023). Komitmen dari staf dapat ditingkatkan melalui peningkatan *psychological empowerment* (pemberdayaan psikologis) dan *psychological well-being* (kesejahteraan psikologis). Artinya pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan stafnya untuk meningkatkan pemberdayaan psikologis dan kesejahteraan stafnya (Iqbal et al., 2020).

3. Kinerja Perawat

Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja perawat daripada kepemimpinan transaksional di rumah sakit umum (Ausat et al., 2022). Kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja, ikatan emosional dan rasa memiliki terhadap organisasi sehingga visi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Akan tetapi untuk mencapai kinerja yang optimal, pemimpin juga harus memberikan penghasilan yang layak pada staf atas pekerjaan mereka (Ausat et al., 2022), memperhatikan komitmen organisasi staf, pemberdayaan staf, beban kerja, motivasi, stres, keselamatan psikologis, keterikatan kerja, dan lingkungan kerja (Wijayanti & Aini, 2022).

4. Produktifitas dan motivasi staf

Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional di unit keperawatan dapat meningkatkan produktifitas dan motivasi staf sebab mereka memiliki visi bersama yang dapat mengarahkan unit keperawatan untuk

mencapai tujuan bersama serta adanya kejelasan akan peran atau pekerjaan staf (Holly & Igwee, 2011).

5. Kepuasan kerja (*Job satisfaction*)

Kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik- karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memiliki perasaan positif terkait pekerjaannya, sebaliknya jika kepuasan kerja rendah akan memiliki perasaan negatif (Robbins & Judge, 2016). Penelitian Suwekoa & Dwiantoro (2020) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja perawat dan peningkatan kualitas pelayanan, melalui kepemimpinan kharismatik, inspiratif, menstimulasi intelektual dan pertimbangan yang individual. Kepuasan kerja perawat juga dipengaruhi oleh kesempatan, pemberdayaan struktural, keterikatan kerja, lingkungan kerja, dan stres (Wijayanti & Aini, 2022)..

6. Retensi staf

Retensi staf (keinginan untuk tetap bekerja) merupakan prioritas utama manajer keperawatan. Hal ini disebabkan *turn over* perawat akan membebani perawat yang ditinggalkan dan akan menyebabkan rumah sakit harus mengeluarkan biaya tambahan untuk rekrutmen perawat baru. Oleh karena itu perawat manajer akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan retensi perawat. Penelitian oleh Goens & Giannotti (2024) menemukan bahwa perawat manajer yang menerapkan kepemimpinan transformasional dapat secara efektif mendukung retensi staf keperawatan. Hal ini disebabkan kepemimpinan transformasional yang berfokus untuk mengembangkan visi yang menarik bagi staf, memiliki tujuan, pencapaian tujuan, memiliki teknik pemecahan masalah, meluangkan waktu untuk pelatihan dan pengembangan tim (Tian et al., 2020), dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang berkontribusi secara signifikan terhadap retensi staf (Goens & Giannotti, 2024).

7. *Organizational Citizenship Behavior (OCB)*

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan level tertinggi dari keterlibatan kerja. OCB adalah perilaku karyawan diluar tugas utamanya di dalam organisasi yang berkontribusi pada lingkungan psikologis dan social tempat kerja (Robbins & Judge, 2016). Contoh: membantu rekan kerja, menjaga lingkungan tetap bersih dan tertib. Pratama (2017) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan kuat dengan *OCB* pada perawat. Akan tetapi OCB yang dilakukan perawat membutuhkan adanya dorongan oleh pimpinan rumah sakit itu sendiri. Seperti adanya motivasi, komunikasi dan keterbukaan seorang pimpinan dalam pemberian ide oleh karyawan. Pengaruh yang ideal seperti: penyampaian visi dan misi organisasi secara jelas, membuat perawat merasa bangga dan menumbuhkan kepercayaan perawat.

8. Inovasi dan kolaborasi

Pemimpin transformasional bersifat inovatif, menumbuhkan budaya yang mampu merangkul perubahan, mendorong pengambilan keputusan bersama dan memecahkan masalah secara kreatif. Pemimpin keperawatan yang kuat akan berusaha mengeksplorasi potensi kelemahan dan peluang dari tim/ organisasi, serta berkolaborasi dengan tim mereka untuk menerapkan teknologi dan praktik baru (ANA, 2023).

9. Inspirasi di setiap unit

Organisasi pelayanan kesehatan harus memiliki banyak pemimpin transformasional. Pendistribusian kepemimpinan di seluruh departemen dan unit yang berbeda, akan memastikan bahwa organisasi merangkul seluruh keinginan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mendorong inovasi dari staf (ANA, 2023).

10. Penyelesaian konflik secara proaktif

Pemimpin transformasional dalam keperawatan merupakan pemimpin yang mau mendengarkan pendapat dan kekhawatiran orang lain secara aktif. Karakter ini mampu menangani konflik secara terbuka dan tanpa bias untuk mencapai resolusi yang efektif melalui proses penyelesaian konflik seperti: 1) Memfasilitasi komunikasi yang jujur dan mendengarkan semua perspektif. 2) Memandu diskusi menuju solusi yang saling menguntungkan. 3) Memantau kemajuan dan efektivitas solusi untuk mencegah terulangnya masalah dan untuk mengakui keberhasilan (ANA, 2023; Sitorus & Panjaitan, 2011).

11. *Burnout* perawat pelaksana

Penelitian oleh Puspitasari et al., (2019) menemukan bahwa kepala ruang yang menerapkan kepemimpinan transformasional akan mengalami peningkatan peran terutama sebagai pembimbing (datang tepat waktu saat dinas, memunculkan ide kepada staf yang menghasilkan insentif dan membantu perawat saat mengatasi konflik). Kepemimpinan transformasional kepala ruangan dapat menurunkan *burnout* pada perawat pelaksana terutama pada dimensi *emotional exhaustion* (kelelahan emosional). Hal ini disebabkan karena salah satu karakter kepemimpinan transformasional adalah mengartikulasikan visi masa depan dan membentuk ikatan emosional yang amat kuat dengan pengikutnya. Kepemimpinan transformasional juga lebih efektif menurunkan *burnout* perawat dibandingkan kepemimpinan transaksional (Workman, 2017). Hal ini disebabkan perlakuan baik yang diterima perawat dari pemimpin saat bekerja, dirasakan perawat sebagai sebuah prestasi. Perasaan senang karena memiliki prestasi inilah yang mencegah terjadinya *burnout* atau tingkat *burnout* rendah meskipun beban kerja dan tuntutan kerja tinggi (Puspitasari et al., 2019).

12. Keselamatan kerja perawat

Kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan kerja perawat melalui penurunan kelelahan kerja pada perawat dan angka kejadian kekerasan di tempat kerja (Aljaber et al., 2022).

13. Asuhan keperawatan pasien

Tim keperawatan yang dipimpin oleh pemimpin transformasional akan mempengaruhi hasil asuhan keperawatan pasien melalui pemberian perawatan yang berpusat pada pasien, keunggulan klinis, dan praktik keselamatan. Manfaat lainnya: terjadi peningkatan kepuasan pasien, peningkatan hasil klinis, dan peningkatan angka keselamatan pasien (Aljaber et al., 2022).

14. Keselamatan pasien

Gaya kepemimpinan dari perawat manajer dapat mempengaruhi baik dan buruknya keselamatan pasien. Hasil studi oleh Mulyatiningsih & Sasyari (2021) menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat berkontribusi positif terhadap keselamatan pasien dibandingkan gaya kepemimpinan yang lain seperti *laissez-faire* dan transaksional. Hal ini disebabkan upaya peningkatan keselamatan pasien merupakan proses dinamis yang terus berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dukungan manajer keperawatan yang inovatif dan visioner. Manajer yang visioner, inovatif, dan loyal merupakan karakteristik dari pemimpin transformasional (Marquis & Huston, 2013), sehingga memiliki potensi yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keperawatan profesional serta mempromosikan perawatan pasien berkualitas tinggi dan keselamatan pasien (Mulyatiningsih & Sasyari, 2021). Selain itu kepemimpinan transformational juga dapat meningkatkan budaya keselamatan pasien dengan tidak melaporkan kesalahan perawat dan mengurangi budaya menyalahkan dalam lingkungan keperawatan (Ystaas et al., 2023).

E. Tantangan dan Strategi Kepemimpinan Transformasional

Penerapan kepemimpinan transformasional dalam keperawatan memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi:

1. Kurangnya dukungan dari organisasi untuk pelatihan kepemimpinan

Menjadi seorang pemimpin bukanlah bawaan sejak lahir, namun harus terus diasah dan dipelajari baik melalui pendidikan formal maupun non formal (Robbins & Judge, 2016). Tantangan yang dihadapi pemimpin adalah mereka tidak mendapatkan dukungan dari organisasi untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan (pendidikan/ pelatihan) mereka (Ferreira et al., 2020).

2. Pengalaman profesional yang kurang dan usia muda.

Pemimpin perawat dengan pengalaman profesional yang kurang, bisa berpengaruh pada kemampuan dalam praktik, cara berpidato dan kepercayaan diri yang rendah. Terkait usia muda, pemimpin perawat yang lebih muda mengalami kesulitan untuk diterima oleh tim sebagai pemimpin. Hal ini disebabkan orang yang lebih tua atau yang punya pengalaman bertahun-tahun akan mempertanyakan kapasitas profesional pemimpin yang lebih muda, cenderung sulit menerima perintah dari yang lebih muda dan adanya anggapan bahwa orang dengan pengalaman bertahun-tahun akan lebih banyak tahu dibanding yang baru bekerja (Ferreira et al., 2020).

3. Penolakan terhadap kepemimpinan dan pembangkangan

Penolakan dan pembangkangan ini biasanya terjadi karena ada perbedaan jenis perawat (perawat profesi dengan vokasi) dan ikatan kerja (pegawai negeri sipil, kontrak atau dengan honorer) antara pimpinan dengan staf. Staf cenderung menolak dan membangkang jika dipimpin oleh pimpinan yang dianggap statusnya lebih rendah dibanding mereka (Ferreira et al., 2020).

Strategi atau upaya yang dapat diadopsi perawat manajer untuk menghadapi tantangan dalam membangun kepemimpinan transformasional:

1. Pengembangan Kepemimpinan

Program pengembangan kepemimpinan (pendidikan, pelatihan, mentoring) yang berkelanjutan, penting untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi perawat manajer (Aljaber et al., 2022). Perawat manajer yang mendapatkan pendidikan kepemimpinan akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif, mampu menumbuhkan kerja sama tim yang efisien, lingkungan kerja keperawatan yang berkualitas, dan pada akhirnya hasil asuhan keperawatan yang aman dan efisien bagi pasien (Ystaas et al., 2023). Penerapan pengembangan kepemimpinan dapat melalui pelatihan dan kurikulum pendidikan keperawatan (Aljaber et al., 2022).

2. Panutan

Menjadi panutan atau memberi contoh melalui tindakan merupakan salah satu strategi utama dalam membangun kepemimpinan positif dan efektif (ANA, 2023). Pemimpin memberi contoh yang baik seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik dan bersikap ramah, mampu mengajarkan staf lebih baik dibanding hanya sekedar memberi tahu (Ferreira et al., 2020).

3. Komunikasi dan Berdialog

Perawat manajer yang efektif memimpin dengan mendorong komunikasi yang baik dan lingkungan kerja yang kooperatif (ANA, 2023). Komunikasi ini bisa melalui dialog atau mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang

disampaikan staf. Dialog diidentifikasi sebagai alat penting bagi pemimpin yang memungkinkan terjadinya keterbukaan terhadap hubungan horizontal, memperkuat rasa hormat dan kepercayaan. Perawat manajer yang memainkan peran ini dengan rasa tanggung jawab, menghormati staf, dan memperhatikan kepuasan tenaga profesional di tempat kerja akan menghasilkan perawatan yang berkualitas serta berkontribusi pada hubungan interpersonal yang lebih baik (Ferreira et al., 2020).

4. Integritas dalam mengambil tindakan

Pemimpin transformasional bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang diperoleh. Pemimpin transformasional tidak menghindari dari situasi atau tantangan sulit yang dihadapi komunitas, tetapi mengatasinya secara langsung dan secara aktif mencari solusi yang efektif. Pemimpin perawat dapat mendengarkan dan belajar dari tim perawat, tim kesehatan lain dan pasien (ANA, 2023).

5. Lingkungan yang mendukung

Pemimpin perawat transformasional berperan sebagai mentor akan berempati pada kehidupan staf, memprioritaskan kesehatan mental, dan keseimbangan kehidupan kerja yang positif. Pemimpin memahami pentingnya perawatan diri dan menyediakan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan staf perawat (ANA, 2023).

6. Kepercayaan dalam tim

Menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara terbuka, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap anggota tim dan sudut pandang mereka. Rasa saling menghormati di antara staf akan mendorong staf untuk merasa bangga dengan pekerjaan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kepercayaan bersama dalam tim dapat ditunjukkan dengan pendelegasian tanggung jawab dan otonomi, serta memberdayakan tim untuk memanfaatkan pengalaman dan keterampilan mereka saat pengambilan keputusan (ANA, 2023).

7. Visualisasi sistem yang lebih baik

Pimpinan perawat yang transformasional selalu terbuka terhadap cara berpikir baru. Selain berbagi pengalaman dan visi mereka, mereka secara aktif mencari masukan dari staf mereka. Staf harus terinspirasi untuk berpikir di luar kotak dan mengeksplorasi pendekatan dan solusi baru untuk tantangan (ANA, 2023).

8. Bekerja melampaui harapan dalam tugas harian

Pimpinan perawat yang transformasional selalu terbuka terhadap cara berpikir baru. Selain berbagi pengalaman dan visi mereka, mereka secara aktif

mencari masukan dari staf mereka. Staf harus terinspirasi untuk berpikir di luar kotak dan mengeksplorasi pendekatan dan solusi baru untuk tantangan (ANA, 2023).

F. Simpulan

Teori kepemimpinan terus mengalami perubahan. Kepemimpinan merupakan komponen penting dari manajemen keperawatan, dimana gaya kepemimpinan memainkan peran penting dalam penerapannya. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap cocok untuk diterapkan pada keperawatan. Lingkungan keperawatan yang dinamis, kompleks, bekerja dalam tim, berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain, serta menghadapi permasalahan kekurangan staf, dan peningkatan beban kerja membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki karakteristik pemimpin transformasional. Seperti: visioner, karismatik, dapat menjadi panutan, menginspirasi, *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), *individual consideration* (pertimbangan individual), jujur, menghargai dan menghormati orang lain atau staf, menjaga hubungan baik dengan staf serta mampu memberikan semangat dan motivasi untuk menemukan cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan. Meskipun dalam prosesnya, akan menemui kesulitan ataupun tantangan, akan tetapi dengan karakteristik yang kreatif, inovatif dan mau menerima masukan dari orang lain maka perawat manajer akan menemukan strategi atau solusi untuk setiap masalah.

Gaya kepemimpinan transformasional yang digunakan perawat manajer akan memiliki efek langsung pada lingkungan kerja yang aman dan nyaman, kepuasan kerja perawat. Adanya peningkatan kepuasan diantara staf keperawatan akan mempengaruhi peningkatan komitmen organisasi, produktivitas kerja, peningkatan retensi, keselamatan kerja perawat yang pada akhirnya berdampak pada hasil asuhan keperawatan pasien dan kepuasan pasien itu sendiri.

G. Referensi

- Aljaber, K. S., Alenezi, A. A., Aljohani, M. A., Alotebi, S. M., Hamad, I., Almahamidhi, A., Almutairi, L. H., Safyan, A. D., Alshmari, A. A., & Alshammari, N. S. (2022). *Applying Transformational Leadership in Nursing Practice*. 8, 1417–1422.
- ANA. (2023). What is Transformational Leadership in Nursing? In *American Nurses Associations (ANA) Nursing Resource Hub*. <https://www.nursingworld.org/content-hub/resources/nursing-leadership/transformational-leadership-in-nursing/>
- Ausat, A. M. A., Suherlan, S., Peirisal, T., & Hirawan, Z. (2022). The Effect of

- Transformational Leadership on Organizational Commitment and Work Performance. *Journal of Leadership in Organizations*, 4(1), 61–82. <https://doi.org/10.22146/jlo.71846>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformasional Leadership. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2nd ed). LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS.
- Ferreira, V. B., Amestoy, S. C., da Silva, G. T. R., Trindade, L. de L., dos Santos, I. A. R., & Varanda, P. A. G. (2020). Transformational Leadership in Nursing Practice: Challenges and Strategies. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(6), 1–7. <https://doi.org/doi:> <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0364>
- Goens, B., & Giannotti, N. (2024). *Transformational Leadership and Nursing Retention: An Integrative Review. 2024.* <https://doi.org/10.1155/2024/3179141>
- Holly, C., & Igwee, G. (2011). A Systematic Review of The Influence of Transformational Leadership Style on Nursing Staff in Acute Care Hospitals. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*, 9(3), 301. <https://journals.lww.com/ijebh/Pages/default.aspx?PAPNotFound=true%0Ahttp://files/1210/default.html>
- Hutchinson, M., & Jackson, D. (2013). Transformational leadership in nursing: Towards a more critical interpretation. In *Nursing Inquiry* (Vol. 20, Issue 1, pp. 11–22). <https://doi.org/10.1111/nin.12006>
- Iqbal, K., Fatima, T., & Naveed, M. (2020). The Impact of Transformational Leadership on Nurses' Organizational Commitment: A Multiple Mediation Model. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 10(1), 262–275.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2013). *Kepemimpinan dan manajemen Keperawatan* (E. O. Yudha & A. O. Tampobolon (eds.); 4th ed.). Jakarta: EGC.
- Mulyatiningsih, S., & Sasyari, U. (2021). Gaya Kepemimpinan yang Efektif dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien. *Healthcare Nursing Journal*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.35568/healthcare.v3i1.1093>
- Ogola, M. G. O., Sikalieh, D., & Ling, T. K. (2017). The Influence of Individualized Consideration Leadership Behaviour on Employee Performance in Small and Medium Enterprises in Kenya. *International Journal of Business and Social Science*, 8(2), 163–173.
- Pratama, A. (2017). Hubungan Kepemimpinan Transformasional dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Perawat (Studi Pada Perawat RSIA Eria Bunda Pekanbaru). *Jom Fisip*, 4(2), 1–13.

- Puspitasari, N. W., Sulisno, M., Dwiantoro, L., Kristina, T. N., & Hartiti, T. (2019). Penerapan Kepemimpinan Transformasional dalam Menurunkan Burnout Perawat Pelaksana. *Jurnal Smart Keperawatan*, 6(2), 98. <https://doi.org/10.34310/jskp.v6i2.289>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus, R., & Panjaitan, R. (2011). *Manajemen keperawatan: Manajemen keperawatan di ruang rawat*. Sagung Seto.
- Smith, M. A. (2011). Are You a Transformational Leader? *Nursing Management*, 42(9), 44–50. <https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000403279.04379.6a>
- Suwekoa, H., & Dwiantoro, L. (2020). Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Perawat: Literature Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(1), 106–112.
- Tian, H., Iqbal, S., Akhtar, S., Qalati, S. A., Anwar, F., & Khan, M. A. S. (2020). The Impact of Transformational Leadership on Employee Retention: Mediation and Moderation Through Organizational Citizenship Behavior and Communication. *Frontiers in Psychology*, 11(March), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00314>
- Wijayanti, K., & Aini, Q. (2022). The Influence of Transformational Leadership Style to Nurse Job Satisfaction and Performance in Hospital. *Journal of World Science*, 1(7), 485–499. <https://doi.org/10.36418/jws.v1i7.69>
- Workman, J. J. (2017). *Effect of Leadership Style and Employee Demographics on Employee Disengagement and Employee Burnout in A Mid-Atlantic Organization*.
- Ystaas, L. M. K., Nikitara, M., Ghobrial, S., Latzourakis, E., Polychronis, G., & Constantinou, C. S. (2023). The Impact of Transformational Leadership in the Nursing Work Environment and Patients' Outcomes: A Systematic Review. *Nursing Reports*, 13(3), 1271–1290. <https://doi.org/10.3390/nursrep13030108>

H. Glosarium

ANA = *American Nurses Association*

OCB = *Organizational Citizenship Behavior*

BAB 2

PERAN KEPALA KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Sri rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., Fisqua.

A. Pendahuluan

Dalam era modern, kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator utama dari efektivitas sistem kesehatan di rumah sakit. Kualitas layanan yang baik tidak hanya mencakup keselamatan pasien, tetapi juga efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan kepuasan pasien. Oleh karena itu, posisi kepala keperawatan sangat strategis dalam mencapai tujuan ini. Kepala keperawatan berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola dalam unit keperawatan, di mana mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya, komunikasi antar staf, dan penyediaan pelatihan serta pengembangan profesional.

Kepemimpinan kepala keperawatan berdampak langsung terhadap moral dan motivasi tim keperawatan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, kepala keperawatan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas staf. Di samping itu, mereka berperan dalam penerapan praktik berbasis bukti yang merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan (Melnik & Fineout-Overholt, 2019).

Menghadapi tantangan seperti meningkatnya jumlah pasien dan beragam kebutuhan pasien selama dalam perawatan di rumah sakit, kepala keperawatan harus mampu beradaptasi dan mengimplementasikan inovasi layanan yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga merespons harapan pasien. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang sistem kesehatan, serta kemampuan dalam manajemen dan komunikasi yang efektif.

Melalui buku ini, kami akan mengeksplorasi secara mendalam peran dan tanggung jawab kepala keperawatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Diharapkan, pemahaman ini dapat memberi inspirasi bagi kepala keperawatan dan personel kesehatan lainnya untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan standar pelayanan.

B. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai derajat kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan harapan pasien dan standar pelayanan yang telah ditetapkan pimpinan rumah sakit. Definisi ini melibatkan banyak elemen yang mencakup keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, kesetaraan, dan kepuasan pasien. Menurut Donabedian (1988), kualitas pelayanan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan hasil.

1. Struktur

Mencakup semua aspek lingkungan pelayanan kesehatan, seperti fasilitas, peralatan medis, personel, dan prosedur. Kualitas struktur berkaitan dengan sumber daya yang tersedia untuk memberikan pelayanan.

2. Proses:

Proses pelayanan merujuk pada cara layanan disediakan, mulai dari interaksi antara pasien dan penyedia layanan, hingga pengambilan keputusan medis dan implementasi intervensi. Proses yang baik mencakup komunikasi yang efektif dan penerapan praktik berbasis bukti (Berwick, 2002).

3. Hasil

Hasil dari layanan mencakup perubahan dalam kondisi kesehatan pasien setelah menerima pelayanan, serta kepuasan pasien terhadap pengalaman mereka. Hasil ini juga dapat diukur melalui angka mortalitas, morbiditas, dan kepuasan pasien.

Penilaian kualitas pelayanan menjadi penting karena tidak hanya berdampak pada kesehatan pasien, tetapi juga pada keseluruhan sistem kesehatan. Dalam konteks ini, kepala keperawatan memiliki peran penting dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi standar kualitas. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan keperawatan berorientasi pada pencapaian kualitas yang tinggi.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kualitas layanan, banyak institusi kesehatan sekarang menerapkan sistem manajemen kualitas dan serangkaian indikator untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan mereka. Penerapan praktik berbasis bukti, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, serta penguatan komunikasi antar tim kesehatan menjadi beberapa pendekatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, sangat penting untuk mempertimbangkan kompleksitas sistem

kesehatan. Sistem kesehatan yang kompleks melibatkan banyak faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan yang sistemik dan holistik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Faktor-faktor signifikan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Fasilitas dan Peralatan Medis: Ketersediaan dan kondisi fasilitas dan peralatan medis dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Fasilitas yang modern dan peralatan medis yang mutakhir dapat meningkatkan efektivitas pelayanan (Donabedian, 1988).
- b. Sumber Daya Manusia: Kualitas sumber daya manusia, seperti keahlian, pengalaman, dan motivasi, dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelayanan (Buerhaus, et al., 2013).

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor Politik dan Hukum: Faktor politik dan hukum dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Perubahan peraturan dan kebijakan dapat mempengaruhi aksesibilitas pelayanan kesehatan (Weiss, 1980).
- b. Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi, seperti biaya pelayanan kesehatan, dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Biaya yang tinggi dapat membatasi aksesibilitas pelayanan kesehatan (Bunker, et al., 2003).

3. Faktor Manusia

- a. Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Komunikasi yang efektif dapat meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepuasan pasien (Street, et al., 1994).
- b. Kerja Sama: Kerja sama dalam tim kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kerja sama yang efektif dapat memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi (Harrison, et al., 2010).

D. Tanggung Jawab Kepala Ruangan

Sebagai pemimpin di unit keperawatan, kepala keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Tanggung jawab yang diemban oleh kepala keperawatan mencakup beberapa aspek yang kritis, sebagai berikut:

1. Manajemen Tim Keperawatan

Kepala keperawatan bertanggung jawab untuk mengelola tim keperawatan, termasuk pengaturan jadwal kerja, pembagian tugas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kepala keperawatan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta bekerja secara kolaboratif untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Manajemen tim juga melibatkan pengembangan hubungan kerja yang baik antar anggota tim, memotivasi staf, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam aspek ini untuk menangani masalah dan konflik yang mungkin muncul di dalam tim.

2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kebijakan Keperawatan

Kepala keperawatan berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Kebijakan ini dapat mencakup prosedur klinis, protokol keselamatan, dan praktik etika dalam keperawatan. Kepala keperawatan harus memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan, serta berdasarkan bukti ilmiah terkini. Dengan adanya kebijakan yang jelas, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas pelayanan keperawatan di unit tersebut.

3. Pembinaan dan Pelatihan Staf Keperawatan

Sebagai pemimpin, kepala keperawatan bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan staf keperawatan. Ini mencakup pelatihan bagi perawat baru serta pelatihan berkelanjutan untuk staf yang sudah ada. Pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tim keperawatan selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik klinis, teknologi kesehatan, dan peraturan yang relevan. Berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan membantu membangun tim yang lebih kompeten, percaya diri, dan mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Pelayanan

Kepala keperawatan memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh tim keperawatan. Ini meliputi pengumpulan data tentang hasil kesehatan pasien, kepuasan pasien, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Dengan melakukan evaluasi berkala, kepala keperawatan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemantauan kualitas juga mencakup analisis insiden atau kesalahan medis untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan.

Secara keseluruhan, kepala keperawatan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan kompleks. Memimpin tim keperawatan, mengembangkan kebijakan, melatih dan membina staf, serta memantau kualitas pelayanan adalah aspek-aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di unit keperawatan. Dengan pengelolaan yang efisien, kepala keperawatan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan pasien dan dukungan terhadap keberlanjutan organisasi kesehatan secara keseluruhan.

E. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan strategi yang terpadu dan berkelanjutan. Penyedia layanan kesehatan dan pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif dan *evidence-based* untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Berikut adalah beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program pelatihan berkelanjutan, yang mencakup pembaruan pengetahuan dan keterampilan, dapat membantu tenaga kesehatan tetap relevan dengan praktik medis terbaru dan teknologi kesehatan (Schmidt et al., 2020). Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kurikulum dan menawarkan pelatihan praktis di lapangan juga akan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.

2. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Integrasi teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Sistem rekam medis elektronik (RME) dan aplikasi kesehatan lainnya dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, mempercepat akses informasi, dan menurunkan kemungkinan kesalahan medis (Bates et al., 2014). TIK juga dapat digunakan untuk telemedicine, yang memungkinkan pasien mendapatkan akses ke perawatan medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh, khususnya di daerah terpencil.

3. Implementasi Praktik Berbasis Bukti

Penggunaan praktik berbasis bukti (PBM) dalam pengambilan keputusan klinis dapat membantu memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan adalah yang terbaik dan teruji. Dengan mengadopsi pedoman klinis yang didasarkan pada penelitian yang valid, penyedia layanan dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien dan mengurangi variasi dalam praktik (Bero et al., 2016).

Melaksanakan audit dan memberikan umpan balik dapat meningkatkan penerapan PBM.

4. Penyediaan Insentif untuk Perbaikan Kualitas

Menciptakan insentif bagi penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelayanan adalah strategi yang efektif. Insentif dapat berupa bonus finansial, pengakuan, atau sertifikasi untuk fasilitas yang memenuhi standar kualitas tertentu. Pendekatan seperti ini telah terbukti mendorong penyedia layanan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas (Kringos et al., 2015).

5. Keterlibatan Pasien dalam Perawatan Kesehatan

Mendorong keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan mereka sendiri merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ketika pasien terlibat, mereka lebih cenderung mematuhi rencana perawatan dan memiliki hasil kesehatan yang lebih baik. Edukasi mengenai kondisi kesehatan, opsi perawatan, dan pemahaman tentang hak-hak pasien harus diberikan untuk meningkatkan keberdayaan pasien dalam proses perawatan (Coulter, 2012).

F. Simpulan

Kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan melibatkan manajemen tim yang solid, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan berbasis bukti, serta pembinaan dan pelatihan staf yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana perawat dapat memberikan perawatan berkualitas tinggi.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi kualitas pelayanan merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan adalah efektif dan memenuhi standar. Melalui pendekatan berbasis data dan umpan balik dari pasien, kepala keperawatan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien.

Secara keseluruhan, untuk masa depan keperawatan yang lebih baik, penting bagi para pemimpin keperawatan untuk terus mengejar inovasi, pendidikan, dan kolaborasi interprofessional, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan bagi pasien.

G. Referensi

Bates, D. W., et al. (2003). The Impact of Electronic Health Records on Time Efficiency of Physicians and Nurses: A Systematic Review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 10(5), 493-501. DOI:10.1197/jamia.M1131.

- Berwick, D. M. (2002). A User's Manual for the IOM's 'Crossing the Quality Chasm': Quality Improvement in Health Care. *Journal of the American Medical Association*, 287(15), 1959-1960. DOI:10.1001/jama.287.15.1959.
- Buerhaus, P. I., et al. (2013). Nursing's Role in Improving Patient Safety. *Journal of Nursing Regulation*, 4(3), 22-32.
- Bunker, J. P., et al. (2003). The Costs of Health Care: Causes of Increasing Costs and Their Effects on the Economy. *Journal of Medical Economics*, 6(3), 251-265.
- Bates, D. W., et al. (2014). The Impact of Health Information Technology on the Quality of Care: A Systematic Review. *Health Affairs*, 33(4), 511-519. DOI:10.1377/hlthaff.2013.1332.
- Bero, L. A., et al. (2016). Closing the Gap between Research and Practice: A Systematic Review of the Effectiveness of Strategies to Implement Research Findings. *BMC Health Services Research*, 16(1), 1-11. DOI:10.1186/s12913-016-1542-7.
- Coulter, A. (2012). Patient Engagement: A Powerful Force for Health Reform. *Health Affairs*, 31(11), 2694-2702. DOI:10.1377/hlthaff.2012.0893.
- Donabedian, A. (1988). The Quality of Care: How Can It Be Assessed. *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743-1748. DOI:10.1001/jama.260.12.1743.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Street, R. L., Jr., et al. (1994). Physicians' Communication of Uncertainty and Patient Satisfaction. *Journal of General Internal Medicine*, 9(7), 339-345.
- Harrison, R., et al. (2010). Interprofessional Education: A Review of the Literature. *Journal of Interprofessional Care*, 24(1), 33-44.
- Kringos, D. S., et al. (2015). The Role of Practice Variability in Quality of Care: A Study of Primary Care in Europe. *BMC Health Services Research*, 15(1), 1-9. DOI:10.1186/s12913-015-0952-0.
- Schmidt, H. G., et al. (2020). The Role of Continuing Professional Development in the Quality of Health Care: A Literature Review. *Medical Education*, 54(8), 705-713. DOI:10.1111/medu.14118.
- Weiss, L. (1980). The Politics of Health Policy in Industrialized Nations: A Comparative Analysis. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 5(3), 531-552.

H. Glosarium

TIK	= Teknologi Informasi dan Komunikasi
RME	= Rekam Medis Elektronik
SPO	= Standar prosedur operasional

HAI's = *Healthcare Associated Infection*

BAB 3

KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN PASIEN

Septian Mugi Rahayu, Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keselamatan pasien adalah hal mendasar bagi pihak yang memberikan layanan kesehatan baik secara individu, kolektif maupun komunitas karena keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang tidak aman adalah masalah kesehatan bagi masyarakat global yang signifikan, dengan lebih dari satu kasus mendapatkan layanan kesehatan yang tidak aman pada setiap sepuluh pasien dan setengahnya bisa saja dapat dicegah sehingga dapat menghindari kerugian ekonomi yang besar setiap tahun (*Global Patient Safety Report, 2024*).

Rumah sakit merupakan penyedia pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan utama yaitu mengupayakan keselamatan pasien sebagai outcome organisasi. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan, serta menjadi aspek terpenting dalam manajemen mutu. Pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit sangat kompleks dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Insiden keselamatan pasien akan memberikan dampak negatif dan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk rumah sakit dan pasien sebagai pengguna layanan (Jannah, 2024).

Menurut tinjauan sistematis terbaru, 12% pasien mengalami bahaya di berbagai rangkaian perawatan medis, yang berarti lebih banyak lagi dari satu pada setiap sepuluh pasien dirugikan akibat efek samping akibat perawatan yang tidak aman. Pada tingkat keparahan sekitar setengah dari cedera yang dialami pasien melampaui cedera ringan dan kerusakan sementara. Sebanyak 12% kejadian buruk menyebabkan cacat permanen atau kematian pasien. Sekitar setengah dari seluruh kerugian akibat perawatan yang tidak aman diperkirakan dapat dicegah. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa perawatan yang tidak aman menyebabkan lebih dari 3 juta kematian setiap tahunnya. Kerugian yang dialami pasien juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sistem kesehatan dan masyarakat, menghabiskan sumber daya berharga yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan produktif di tempat lain (*Global Patient Safety Report, 2024*).

Penyebab umum yang membahayakan diantaranya adalah:

Kesalahan pengobatan: kerugian terkait pengobatan berdampak pada 1 dari setiap 30 pasien yang mendapat layanan kesehatan, dan lebih dari seperempat dari kerugian ini dianggap parah atau mengancam nyawa.

Pasien terjatuh: pasien terjatuh adalah insiden yang paling sering terjadi di rumah sakit. Tingkat kejadiannya berkisar antara 3 sampai 5 per 1000 hari tidur, dan lebih dari sepertiga dari insiden ini mengakibatkan cedera.

Kesalahan identifikasi pasien: kegagalan dalam mengidentifikasi pasien dengan benar dapat menjadi akar penyebab banyak masalah dan berdampak serius pada penyediaan layanan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan efek samping yang sangat buruk, seperti pembedahan yang salah lokasi. Laporan Komisi Gabungan yang diterbitkan pada tahun 2018 mengidentifikasi 409 kejadian sentinel identifikasi pasien dari 3326 insiden (12,3%) antara tahun 2014 dan 2017.

Kerugian pasien dalam layanan kesehatan yang diakibatkan oleh insiden keselamatan pasien dapat terjadi di semua rangkaian dan di semua tingkat penyediaan layanan kesehatan. Terdapat banyak faktor dan saling terkait yang dapat menyebabkan dampak pada pasien, dan lebih dari satu faktor biasanya terlibat dalam suatu insiden keselamatan pasien:

Faktor sistem dan organisasi: kompleksitas intervensi medis, proses dan prosedur yang tidak memadai, ketidakjelasan dalam alur kerja dan koordinasi perawatan, keterbatasan sumber daya, staf yang tidak memadai dan pengembangan kompetensi;

Faktor teknologi: permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan, seperti permasalahan pada dokumentasi elektronik atau sistem administrasi pengobatan, dan penyalahgunaan teknologi;

Faktor dan perilaku manusia: komunikasi yang tidak efektif di antara petugas layanan kesehatan, antar tim layanan kesehatan, serta dengan pasien dan keluarga, kerja tim yang tidak efektif, kelelahan, dan bias kognitif;

Faktor yang berhubungan dengan pasien: terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan, kurangnya keterlibatan dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan;

Faktor eksternal: tidak adanya kebijakan, peraturan yang konsisten, tekanan ekonomi dan keuangan, dan tantangan terkait lingkungan alam (*World health Organization, 2024*)

Perawat merupakan bagian dari tenaga kesehatan dengan proporsi terbesar di rumah sakit sehingga pelaksanaan tatakelola di bidang keperawatan adalah hal yang sangat penting, mengingat pelayanan keperawatan dilaksanakan selama 24 jam dalam sehari dan terbagi dalam 3 shift kerja. Perawat manajer sebagai pemimpin memegang peranan yang sangat penting dalam tatakelola keperawatan di rumah

sakit dan memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tatakelola yang baik di dalam kepemimpinannya.

B. Kepemimpinan Dalam Keperawatan

Gardner dalam Swanburg (2000) menjelaskan kepemimpinan sebagai suatu pendekatan persuasi dan menjadi *role model* sehingga pemimpin dapat mempengaruhi para pemilih atau kelompoknya agar bertindak sesuai dengan usulan pemimpin atau usulan yang telah disepakati bersama.

Merton dalam Swanburg (2000) menguraikan kepemimpinan yang efektif yaitu dapat memenuhi empat keadaan berikut:

1. Pemahaman diterima melalui komunikasi
2. Memiliki pedoman apa yang harus dilakukan dan diminta melalui komunikasi
3. Percaya bahwa perilaku yang diminta adalah sesuai dengan kehendak individu berdasarkan nilai-nilai
4. Percaya bahwa hal tersebut sesuai dengan tujuan dan nilai organisasi

Kepemimpinan adalah komponen penting dalam membantu staf agar bekerja dengan motivasi yang tinggi dan menggunakan keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Studi telah menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja perawat, dan menunjukkan bahwa komunikasi antara pemimpin dan elemen dibawahnya sangat penting. Tingkat kepercayaan yang diberikan pemimpin juga mempengaruhi sejauh mana perawat dapat memenuhi tujuan organisasi.

Setiap pemimpin dalam suatu organisasi mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda satu sama lain. Gaya kepemimpinan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini diperlukan oleh setiap pemimpin untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan tim bekerja secara efektif dengan berkomunikasi satu sama lain. Pemimpin yang hebat dapat beradaptasi dan mengubah gaya kepemimpinan mereka untuk memastikan hasil positif bagi staf dan pemangku kepentingan utama dalam tim [8]. Salah satu gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam industri rumah sakit adalah kepemimpinan transformasional (Badriyah Putri Jannah, 2024)

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau

masyarakat baik sehat maupun sakit (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan juga menyediakan layanan keperawatan berupa asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan. Dalam melakukan pekerjaan, kelompok tenaga keperawatan dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu manajer perawat. Seorang manajer perawat diharapkan memberikan perhatian dan dukungan terhadap keselamatan pasien, mengingat pelayanan keperawatan dilaksanakan selama 24 jam sehingga kemungkinan terjadinya kelalaian yang mengancam keselamatan pasien lebih tinggi.

Pada kenyataannya, konsistensi terhadap sikap positif staf dalam penerapan keselamatan pasien sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan dan prioritas keselamatan pasien. Kepemimpinan manajemen di rumah sakit maupun ruang rawat memainkan peran penting membantu staf medis dalam memahami budaya organisasi dan gaya kepemimpinan, memfasilitasi kemampuan mereka untuk menangani masalah keselamatan pasien secara efektif dalam praktik asuhan yang diberikan.

Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai teori kepemimpinan dimana pemimpin menciptakan lingkungan yang cocok untuk bekerja dan akan meningkatkan output anggota kelompok yang berkomitmen. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mempunyai ciri bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya dengan cara tertentu sehingga bawahannya akan merasa dihargai. Kepemimpinan transformasional berpusat pada hubungan positif dengan inovasi tim dan pembelajaran individu anggota dalam tim. Kepemimpinan ini ditandai dengan pengaruh ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan penilaian individu. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan ini memerlukan keterlibatan seluruh pihak rumah sakit. Rumah sakit memiliki karakteristik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang kompleks dan terdiri dari berbagai sumber daya dalam jumlah besar, maka gaya kepemimpinan ini dinilai paling tepat untuk diterapkan (Huang et al., 2024)

Oleh sebab itu hendaknya manajer perawat dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bagaimana merencanakan sampai dengan mengontrol keamanan pasien demi terciptanya budaya keselamatan pasien. Menumbuhkan dan memelihara budaya keselamatan yang kuat membutuhkan kepemimpinan yang kuat di semua tingkatan.

C. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah prinsip dasar pelayanan kesehatan dan kini diakui sebagai tantangan kesehatan masyarakat global yang besar dan terus berkembang.

Upaya global untuk mengurangi beban kerugian pasien belum mencapai perubahan substansial selama 15 tahun terakhir meskipun banyak upaya telah dilakukan di beberapa rangkaian layanan kesehatan. Keselamatan pasien adalah kerangka kegiatan teroganisir yang menciptakan budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan yang secara konsisten dan berkelanjutan menurunkan resiko, mengurangi terjadinya kesalahan dan mengurangi dampak yang terjadi (*World Health Organization, 2024*).

Keselamatan pasien rumah sakit adalah sistem yang membantu rumah sakit membuat perawatan yang diberikan kepada pasien lebih aman, mencakup asesmen resiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan, analisis insiden, dan sebagainya (Permanajati & Hastuti, 2023). Tujuan sasaran keselamatan pasien yaitu untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan mempertimbangkan bahwa perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi diperlukan. Menurut Permenkes nomor 11 tahun 2017, ditetapkan 6 indikator sasaran keselamatan pasien di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar

Untuk memastikan bahwa pasien yang dimaksud adalah benar, sebelum melakukan intervensi kepada pasien maka harus menggunakan dua cara identifikasi namun tidak termasuk nomor dan lokasi kamar pasien. Kebijakan dan prosedur harus mengarahkan kepada proses yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.

2. Meningkatkan komunikasi yang efektif

Pengembangan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan. Instruksi lisan maupun via telepon atau hasil pemeriksaan diulangi kembali secara lengkap oleh penerima instruksi kemudian wajib dikonfirmasi kembali oleh pemberi instruksi. Kebijakan dan prosedur harus mengarah pada proses yang konsisten pada verifikasi akurasi komunikasi lisan maupun melalui telepon.

3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai

Pengembangan suatu pendekatan keamanan dari obat yang perlu diwaspadai (*high alert*). Implementasi kebijakan dan atau standar operasional prosedur dikembangkan dan memuat proses identifikasi, penetapan lokasi, pemberian label dan penyimpanan elektrolit konsentrat. Elektrolit konsentrat berada di unit pelayanan pasien hanya jika dibutuhkan secara klinik untuk menghindari administrasi yang kurang hati-hati dan wajib diberikan label yang jelas lalu disimpan pada area yang dibatasi ketat.

Obat-obatan yang mirip, terdengar mirip (*look alike-sound alike*) adalah penyebab umum kesalahan pengobatan yang disebabkan oleh kesamaan

ortografik (tampak mirip) dan fonetik (suara mirip) antar obat, sehingga dapat membingungkan. Obat yang mirip secara visual tampak sama dalam hal kemasan, bentuk, warna dan/atau ukuran, sedangkan obat yang mirip suara memiliki kemiripan dalam fonetik nama, dosis dan/atau kekuatannya. Rumah sakit perlu merancang dan menerapkan strategi secara prospektif untuk mengidentifikasi kesalahan dan membangun sistem yang kuat untuk mencegah kesalahan tersebut sebelum mengakibatkan cedera pada pasien.

4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar

Kebijakan dan standar operasional prosedur dikembangkan untuk mendukung proses yang terarah. Pengembangan suatu pendekatan untuk memastikan ketepatan Lokasi, prosedur dan pasien. Penggunaan suatu tanda yang jelas dan dipahami oleh seluruh staf untuk identifikasi Lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam proses penandaan. Penggunaan ceklist atau Teknik lainnya untuk proses verifikasi saat preoperasi (tepat Lokasi, prosedur dan pasien serta seluruh dokumen, bahan maupun peralatan yang diperlukan tersedia, tepat dan fungsional). Pencatatan prosedur sebelum insisi/time out saat sebelum dimulainya prosedur Tindakan pembedahan.

5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan

Kebijakan dan standar prosedur dikembangkan guna mendukung pengurangan maupun pencegahan berkelanjutan resiko infeksi yang dapat ditimbulkan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Pengembangan suatu pendekatan untuk mengurangi resiko infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru secara efektif.

6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.

Kebijakan dan standar prosedur disusun dan dikembangkan guna mendukung pengurangan dan pencegahan berkelanjutan resiko pasien jatuh dan menimbulkan cedera. Pengembangan suatu pendekatan untuk mengurangi resiko pasien jatuh. Penerapan proses asesmen awal terhadap resiko jatuh dan asesmen ulang pada pasien dengan perubahan kondisi. Penerapan langkah-langkah pencegahan bagi pasien dengan hasil asesmen yang menunjukkan memiliki resiko jatuh.

Guna mencapai hal tersebut pemerintah menuangkan dalam 7 (tujuh) langkah menuju keselamatan pasien yang terdiri dari:

1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien.

Keselamatan pasien adalah prioritas dan semua orang harus memiliki kesadaran akan hal tersebut. Semua yang terlibat dalam proses perawatan pasien harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa keselamatan pasien merupakan

suatu hal yang amat sangat penting dan bernilai, karena apabila terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan pasien maka dampaknya sangat besar bagi pasien dan keluarga maupun bagi rumah sakit bahkan bagi negara.

2. Memimpin dan mendukung staf

Dalam hal ini peran pemimpin amat sangat penting guna membangun dan mengintegrasikan budaya keselamatan pasien dalam praktik sehari-hari, pemimpin juga harus memberikan dukungan secara penuh dalam prosesnya.

3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko

Dalam praktik sehari-hari yang diberikan dalam rangka perawatan pasien selama 24 jam tentunya memiliki resiko. Rumah sakit harus memiliki peraturan yang mendorong penerapan aktivitas pengelolaan resiko yang mengutamakan keselamatan pasien.

4. Mengembangkan system pelaporan

Rumah sakit beserta tenaga Kesehatan yang bekerja didalamnya dapat belajar dari kejadian insiden keselamatan pasien, untuk mendukung hal tersebut maka system pelaporan haruslah jelas dan sistematis agar setiap kejadian dapat terekam dan dapat dilakukan investigasi dengan analisis akar masalah, sehingga dapat menjadi landasan merumuskan kebijakan dan aturan terkait keselamatan pasien.

5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien

Pasien juga memiliki peran dalam peningkatan keselamatan pasien, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dengan harapan pasien dapat menyampaikan hal-hal yang beresiko dalam asuhan yang diterimanya. Perawat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermitra dengan pasien dan keluarga sebagai intervensi utama untuk mendorong asuhan keperawatan yang lebih aman.

6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien

Keselamatan pasien hanya dapat dicapai apabila orang-orang yang terlibat didalamnya senantiasa belajar baik dari pengalaman internal rumah sakit maupun dari rumah sakit lain. Untuk itu perlu untuk dikembangkan budaya angkat bicara dan tidak menyalahkan sehingga apabila terjadi sesuatu yang beresiko mengancam keselamatan pasien, pihak yang terlibat tidak takut atau cemas untuk angkat bicara atau melaporkan mengenai kejadian tersebut sehingga pihak lain yang tidak terlibat dapat belajar dari pengalaman tersebut.

7. Mencegah cedera melalui implementasi keselamatan pasien

Rumah sakit harus memiliki kebijakan, aturan maupun standar prosedur yang jelas dalam praktik sehari-hari guna menghindari insiden keselamatan pasien. Pihak rumah sakit juga harus terbuka menerima kritik maupun saran dari

pasien dan keluarga maupun dari staf yang bekerja di rumah sakit demi menguatkan budaya keselamatan pasien.

Budaya Keselamatan Rumah Sakit adalah lingkungan kolaboratif karena staf klinis memperlakukan satu sama lain dengan hormat, melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga, Kepemimpinan mendorong staf klinis yang merawat untuk bekerja sama dalam tim yang efektif dan mendukung kolaborasi antarprofesional dalam perawatan berfokus pada pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang menjadikan pelayanan pasien lebih aman, termasuk penilaian risiko, identifikasi dan manajemen risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta penerapan solusi untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera yang ditimbulkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan (Fanny et al., n.d.).

Mengembangkan budaya keselamatan adalah hal yang penting bagi siapa pun upaya berkelanjutan menuju peningkatan keselamatan pasien. Kebijakan dan intervensi dari pihak yang berkepentingan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya budaya keselamatan. Namun pada akhirnya, budaya keselamatan harus ditumbuhkan ke dalam sikap, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, manajer dan pemimpin organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan pasien membutuhkan komitmen dari pimpinan, transparansi, komunikasi yang terbuka dan menghargai, belajar dari kesalahan dan praktik keselamatan pasien yang lebih baik, dan keseimbangan antara kebijakan dan akuntabilitas. Selain penting untuk mengurangi dampak negative pada pasien, budaya keselamatan juga memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga Kesehatan, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis, dimana tenaga kesehatan dapat berbicara tentang keselamatan pasien dan masalah lainnya tanpa rasa takut tentang konsekuensi negative yang akan dihadapi.

D. Peran Pemimpin dalam Peningkatan Keselamatan Pasien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki andil dalam meningkatkan keselamatan pasien. Manajer keperawatan juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban secara moral untuk menjamin pelayanan berkualitas yang menjamin keselamatan pasien. Manajer berada dalam posisi utama untuk mengamankan dan melakukan kebijakan, system, prosedur dan menciptakan iklim organisasi yang mendukung peningkatan keselamatan pasien. Hal ini didukung oleh pemerintah melalui Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien,

pada BAB III pasal 5 ayat (4) huruf e tertulis peran kepemimpinan dan peningkatan keselamatan pasien.

Pemimpin sebagai individu yang memegang posisi dan peranan penting, diharapkan mampu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dengan menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Hal ini dapat dibangun dengan melakukan asesmen budaya di tempat kerja. Berdasarkan hasil asesmen dapat dirumuskan kebijakan dan prosedur yang kondusif bagi budaya yang terbuka dan adil khususnya terkait insiden keselamatan pasien dengan harapan staf dapat berkomunikasi secara nyaman dan terbuka kepada rekan kerja maupun para manajer mengenai insiden keselamatan pasien dimana mereka terlibat didalamnya. Pemimpin juga perlu memberikan dukungan dan perlakuan yang adil kepada staf yang terlibat.

Insiden keselamatan pasien juga perlu untuk ditelaah, bukan hanya mengenai siapa saja yang terlibat namun juga mengapa hal tersebut dapat terjadi, sehingga dapat menjadi landasan untuk memperbaiki kebijakan maupun prosedur yang terkait keselamatan pasien. Penelaahan memerlukan alat analisis yang juga mengukur factor apa saja yang berpengaruh pada kegiatan atau perilaku seseorang pada saat insiden keselamatan pasien tersebut terjadi.

Seorang pemimpin diharapkan memiliki *leadership skill* yang mumpuni sehingga dapat memimpin dan mendukung elemen yang ada dibawahnya, membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien karena budaya keselamatan membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta kemauan untuk mendengarkan. Dalam hal ini diperlukan briefing rutin bersama pimpinan maupun staf bahkan bersama pasien untuk mendengarkan dan mendiskusikan hal-hal yang menyangkut keselamatan pasien. Pemimpin juga harus mampu menciptakan dan mengembangkan mekanisme yang mendorong staf untuk mendiskusikan mengenai insiden keselamatan pasien yang telah dicegah, telah terjadi dan hampir terjadi kemudian memberikan kesempatan untuk menuangkan ide maupun gagasan mengenai keselamatan pasien dari hasil diskusi.

Mengupayakan keselamatan pasien merupakan suatu hal yang memiliki resiko, sehingga diperlukan integrasi aktivitas pengelolaan resiko. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan system dan proses pengelolaan resiko serta kemampuan mengidentifikasi dan asesmen hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah. Keselamatan pasien harus tercermin dalam kebijakan dan aturan rumah sakit dengan tidak mengesampingkan keterkinian rencana aksi yang selalu ditindak lanjuti dan dipantau serta memastikan bahwa manajemen resiko dan keselamatan pasien sejalan dan setara dengan kinerja staf.

System pelaporan yang mudah dan mumpuni sangat diperlukan terkait insiden keselamatan pasien karena pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan pondasi untuk membangun suatu asuhan yang mengutamakan keamanan pasien. Hal-hal penting yang dapat dilakukan oleh manajer perawat adalah mendorong seluruh staf untuk melaporkan hal-hal terkait keselamatan pasien. Tingkat pelaporan yang tinggi umumnya ada pada rumah sakit yang memperhatikan keamanan pelayanan yang diberikan. Laporan-laporan yang diterima hendaknya ditinjau oleh manajer resiko kemudian diteruskan ke Tingkat nasional yaitu ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit agar dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran Bersama bagi rumah sakit yang lain, selain itu upayakan untuk mengurangi dampak dari insiden, manajer resiko harus meninjau semua laporan kasus yang berdampak kematian dari kejadian yang tidak diharapkan sebelum laporan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pastikan pimpinan rumah sakit menerima laporan dan kegiatan dari semua kasus yang berdampak kematian dan secara langsung berhubungan dengan insiden keselamatan pasien.

Upaya keselamatan pasien sebaiknya melibatkan pasien itu sendiri melalui komunikasi sehingga pemimpin perlu untuk mengembangkan cara-cara komunikasi terbuka dengan pasien. Rumah sakit yang terbuka merupakan rumah sakit yang lebih aman, pasien dan staf perlu mengetahui apabila telah terjadi sesuatu yang merugikan dan mereka perlu dilibatkan dalam penelitian insiden yang terjadi. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya menyusun suatu kebijakan keterbukaan yang aman, memperoleh dukungan dewan direksi mengenai kebijakan tersebut dan mensosialisasikan serta memberikan pelatihan kepada staf, melibatkan pasien dan keluarga mereka serta staf dalam analisis akar masalah dari insiden keselamatan pasien yang berdampak pada cedera yang parah bahkan kematian serta dalam penyusunan rekomendasi dan solusi yang dikembangkan dari suatu insiden keselamatan pasien.

Pada tahun 2001 JCAHO melakukan kampanye SPEAK-UP untuk pasien dan masyarakat, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bicaralah jika anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran: anda berhak mengetahuinya
2. Perhatikan setiap proses perawatan yang anda terima
3. Didik diri anda sendiri tentang diagnosis, tes, dan pengobatan anda
4. Mintalah anggota keluarga atau teman tepercaya untuk menjadi penasihat anda
5. Ketahui obat apa yang anda minum dan mengapa anda meminumnya
6. Gunakan penyedia layanan kesehatan yang secara ketat mengevaluasi dirinya berdasarkan standar keselamatan

7. Berpartisipasilah dalam semua keputusan tentang perawatan anda.

Seorang pemimpin hendaknya juga mampu untuk belajar dan berbagi pengalaman mengenai keselamatan pasien serta mendorong staf agar dapat melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa insiden terjadi. Pelayanan Kesehatan dapat menjadi lebih aman hanya apabila semua yang terlibat didalamnya senantiasa belajar dari insiden keselamatan pasien baik yang terjadi secara internal maupun insiden yang terjadi di rumah sakit lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan Teknik analisis akar masalah atau audit kejadian untuk menginvestigasi insiden secara efektif.
2. Memastikan staf inti termasuk manajer resiko telah mengikuti pelatihan Keselamatan Pasien Rumah Sakit sehingga memiliki pemahaman mengenai keselamatan pasien dan tindak lanjutnya.
3. Mengambil bagian untuk mereview analisis akar masalah minimal satu kali setiap tahunnya.
4. Menganalisis frekuensi, tipe dan Tingkat keparahan insiden termasuk hasil pembelajaran dari insiden untuk menilai apakah ada perbaikan yang berkesinambungan.

Pemimpin diharapkan dapat mencegah cedera melalui implementasi system keselamatan pasien, menggunakan informasi yang ada mengenai insiden maupun masalah untuk melakukan perubahan pada system pelayanan. Perubahan penting yang diimplementasikan akan membawa kepada kemajuan yang nyata dalam melaksanakan suatu pelayanan Kesehatan. Selain itu Langkah lain yang harus diambil yaitu menelaah pola kegiatan di rumah sakit apakah telah sesuai dengan rekomendasi dan Solusi dari temuan secara local, regional maupun nasional. Unit keselamatan pasien mengendalikan rencana aksi dan penerapannya, serta mengikuti investigasi local dan nasional, memastikan rekomendasi diimplementasikan dan dievaluasi, identifikasi apa yang masih harus dikerjakan dan umpan balik kegiatan rumah sakit kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Membangun suatu jejaring dengan rumah sakit lain untuk belajar dari kesuksesan rumah sakit lain dalam mengimplementasikan solusi dan menekan kejadian yang tidak diharapkan.

E. Simpulan

Keselamatan pasien merupakan hal mendasar dalam penyediaan layanan kesehatan di semua situasi. Namun, kejadian buruk, kesalahan, dan risiko yang terkait dengan layanan kesehatan yang dapat dihindari tetap menjadi tantangan utama bagi keselamatan pasien secara global.

Kebijakan yang jelas, kapasitas kepemimpinan organisasi, data yang lengkap dan jelas untuk mendorong peningkatan keselamatan, layanan kesehatan yang profesional dan terampil, dan keterlibatan pasien dan keluarga yang efektif dalam proses perawatan, semuanya diperlukan untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dan signifikan dalam keselamatan pasien pada layanan kesehatan.

F. Referensi

- Badriyah Putri Jannah. (2024). The influence of transformational leadership style on the implementation of patient safety in hospitals: Literature review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(2), 1999–2004. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.2.1655>
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). www.peraturan.go.id
- Fanny, N., Amin, A., & Sari, D. P. (n.d.). *THE RELATIONSHIP OF LEADERSHIP WITH THE IMPLEMENTATION OF PATIENT SAFETY CULTURE IN HOSPITALS*. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JEPH>
- Global patient safety report 2024 lob p*. (2024). <https://iris.who.int/>.
- Huang, C. H., Wu, H. H., Lee, Y. C., & Li, X. (2024). The Critical Role of Leadership in Patient Safety Culture: A Mediation Analysis of Management Influence on Safety Factors. *Risk Management and Healthcare Policy*, 17, 513–523. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S446651>
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Permanajati, A., & Hastuti, D. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Membentuk Budaya Keselamatan Pasien dan Kerja di Rumah Sakit Astrini. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(5), 1171–1179. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i5.10262>

G. Glosarium

- KPRS = Keselamatan Pasien Rumah Sakit
KPPRS = Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
KTD = Kejadian Tidak Diharapkan
WHO = World Health Organization

BAB 4

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENANGGULANGI KRISIS GLOBAL KESEHATAN

Ns. Weni Lidya Hendayani, M.Kep.

A. Pendahuluan

Menurut kondratnya manusia-Nya bahwa manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dan manusia udah dikaruniai sifat dan sekaligus tugas sebagai seorang pemimpin. Pada masa sekarang individu sadar akan pentingnya ilmu sebagai petunjuk atau panduan untuk memimpin umat manusia yang semakin besar jumlahnya dan semakin serta komplet persoalannya. Dasar kesadaran itulah dan relevan dengan dengan upaya proses pembelajaran yang mewajibkan pada semua umat manusia untuk mencari ilmu. Dengan demikian upaya tersebut tidak lepas dari pendidikan dan tujuan pendidikan tidak tercapai secara optimal tanpa adanya manajemen atau pengelolaan pendidikan yang baik yang selanjutnya dalam kegiatan manajemen pendidikan diperlukan adanya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuantujuan utama. Menurut Arwani (2006) kepemimpinan adalah suatu seni dan proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka memiliki motivasi untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi. Memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Proses manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai satu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara professional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Bagaimana proses keprawatan, manajemen keperawatan terdiri dari atas pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Karen manajemen keperawatan mempunyai kekhususan terhadap mayoritas tenaga dari pada seorang

pegawai, maka setiap tahapan dalam proses manajemen lebih rumit jika dibandingkan dengan proses keperawatan.

Stoq Dill menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan yaitu: prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status, kapasitas. Menurut Earl Nightingale dan Whitf Schult mengemukakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan syarat yaitu: kemandirian, besar rasa ingin tahu, multi terampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam, memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan, Selalu ingin mendapatkan yang sempurna, mudah menyelesaikan diri (beradaptasi), sabar dan ulet, komunikatif serta pandai berbicara, berjiwa wiraswasta, sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan berani mengambil risiko, tajam firasatnya dan adil pertimbangannya, berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuan, memiliki motivasi tinggi, punya imajinasi tinggi.

B. Teori Bakat (Trait Theoty)

Toeri bakat menekankan bahwa setiap orang adalah pemimpin (pemimpin dibawa sejak lahir bukan didapatkan dan mereka mempunyai karakteristik tertentu yang membuat mereka lebh baik dari orang lain (Marquis dan Huston, 1998). Teori ini disebut juga sebagai *Great Man Thery*. Banyak penelitian terhadap riwayat kehidupan untuk menguji teori ini. Teori bakat mengabikan dampak atau pengaruh dari siapa yang mengasuh, situasi dan lingkungan lainnya, tetapi menurut teori kontemporerkepemimpinan seseorang dapat dikembangkan bukannya dari pembawaan sejak lahir. Teori ini mengidentifikasi karakteristik umum tentang inteligasi, persinalitas dan kemampuan (perilaku).

C. Teori Perilaku

Teori perilaku lebih menekan kan pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana seorang manajer menjalankan fungsinya. Perilaku sering dilihat sebagai suatu rentang dari perilaku otoriter ke demokratis atau dari fokus suatu produksi ke fous pegawai. Menurut Vestal (1994), teori prilaku ini dinamakan sebagai gaya kepemimpinan seorang manajer dalam suatu organisasi.

Gaya diartikan sebagai suatu cara penampilan karakteristik atau tersendiri. Menurut Follet (1940) gaya didefenisikan sebagai hak istimewa terdiri dari si ahli dengan hasil akhir yang dicapai tanpa menimbulkan isu sampingan. Gillies (1970) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat diidentifikasi berdasarkan perilaku pemimpin itu sendiri. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya pengalaman bertahun-tahun dalam kehidupannya. Oleh karena itu kepribadian seseorang akan mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakan. Gaya kepemimpinan seseorang cenderung sangat bervariasi dan berbeda- beda. Menurut

para ahli terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi antara lain sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinann Menurut Tannenbau dan Warrant H. Schmitdt

Menurut kedua ahli tersebut gaya kepemimpinan dapat dijelaskan melalui dua titik ekstrem yaitu kepemimpinanan berfokus pada atasan dan kepemimpinanan berfokus pada bawahan. Gaya tersebut dipengaruhi oleh factor manajer, factor karyawan dan factor situasi. Jika pemimpin memandang bahwa kepentingan organisasi harus didahulukan jika dibanding dengan kepentingan individu, maka pemimpin akan lebih otoriter, akan tetapi jika bawahan mempunyai pengalaman yang lebih baik dan menginginkan partisipasi maka pemimpin dapat menerapkan gaya partisipasinya.

2. Gaya kepemimpinan menurut Likert

Likert dalam Nursalam (2002) mengelompokan gaya kepemimpinan dalam empat sistem:

- a. Sistem otoriter- Eksploitatif
- b. Sistem Benevolent- otoritatif
- c. Sistem konsultatif
- d. Sistem partisipatif

3. Gaya kepemimpinan menurut teori X dan Y

Teori ini dikemukakan oleh Douglas dalam bukunya *The Human Side Enterprise* (1960). Dia menyebutkan Bahwa prilaku seseorang dalam suatu organisasi dapat dikelompokan menjadi dua kutub utama, yaitu sebagai teori X dan Y. Teori X mengasumsikan bawah bawahan itu tidak menyukai pekerjaan, kurang ambisi, tidak mempunyai tanggung jawab, cenderung menolak perubahan dan lebih suka dipimpin dari pada memimpin. Sebaliknya teori Y mengasumsikan bahwa bawahan itu senang bekerja, bisa menerima tanggung jawab, mampu mandiri, maupun mengawasi diri, mampu berimajinasi dan kreatif. Berdasarkan teori ini gaya kepemimpinan dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. Gaya kepemimpinan dictator yaitu gaya kepemimpinann yang dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta menggunakan ancaman dan hukuman merupakan bentuk dari pelaksanaan Teori X
- b. Gaya kepemimpinanotokratis yaitu hamper sama dengan gaya kepemimpinan diktator namun bobotnya agak kurang. Segala keptusan berada di tangan pemimpin, pendapat daribawahan tidak pernah dibenarkan. Daya ini juga merupakan pelaksnaan Teori X
- c. Gaya kepemimpinan demikratis yaitu yaitu ditemukanadanya peran serta dari bawahan dalam pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah, Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya sesuai dengan teori Y

- d. Daya kepemimpinan santai yaitu peranan dari pemimpin tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan pada bawahan. Gaya kepemimpinan ini sesuai dengan teori Y.(Azwar, 1996)

4. Gaya kepemimpinan menurut Robert House

Berdasarkan teori motivasi perharapan, Robert House dalam Nursalam (2002) menutamakan empat gaya kepemimpinan

- a. Direktif

Pemimpin menyatakan kepada bawahan tentang bagaimana melaksanakan suatu tugas. Gaya ini mengundang arti bawah pemimpin selalu berorientasi pada hasil yang dicapai oleh bawahan

- b. Suportif

Pemimpin berusaha mendekatkan diri kepada bawahan dan bersikap ramah terhadap bawahan.

- c. Partisipatif

Pemimpin berkonsultasi dengan bawahan untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka pengambilan sebuah keputusan

- d. Berorientasi Tujuan

Pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan seoptimal mungkin (Sujak, 1990)

5. Gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard

Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard (1997) dan ciri-ciri pada gaya kepemimpinan tersebut.

- a. Instruksi

- b. Konsultasi

- c. Partisipasi

- d. Delegasi

6. Gaya kepemimpinan menurut Lippitt dan K.White

Menurut Lippitt dan White, terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu otoriter, demokratis dan liberal yang mulai dikembangkan:

- a. Otoriter

- b. Demokratis

- c. Liberal atau Laissez Faire

7. Gaya kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan wewenang

Menurut Gillies (1996), gaya kepemimpinan berdasarkan wewenang dan kekuasaan dibedakan menjadi :

- a. Otoriter

- b. Demokratis

- c. Partipatif
- d. Bebas tindak

Kopetensi yang harus dimiliki oleh Manajer Keperawatan dalam Meningkatkan Efektifitas Kepemimpinan pada Abad ke-21

Penelitian mengenai kopetensi yang harus dimiliki manajer keperawatan telah dilaksanakan kepada 313 tenaga kesehatan di Australia (Harris dan Belakley, 1995). Kopetensi tersebut dikategorikan menjadi yaitu :

1. Kepemimpinan

- a. Berkomunikasi tentang organisasi dan dalam memfasilitasi kegiatan organisasi dan pelaksanaan perubahan
- b. Mendelegasikan dan mendapatkan orang lain untuk melaksanakan tugas dan menerima tanggung jawab
- c. Menyeleksi dan memilih pegawai tetap
- d. Menciptakan budaya organisasi yang kondusif dan efektif
- e. Mengonsultasikan dengan staf dan orang lain diluar organisasi yang sesuai tentang keadaan organisasi
- f. Mengetahui kapan peraturan harus dilaksanakan (fleksibilitas)

2. Pengambilan keputusan dan perencanaan

- a. Berfikir ulang dan menyusun kembali prioritas organisasi
- b. Merespon secara cepat dan tepat tentang perubahan yang tidak diharapkan.
- c. Mengantisipasi dan melaksanakan perencanaan perubahan anggaran
- d. Memberikan pedoman dan arahan tentang keputusan organisasi melalui pengetahuan dari pemerintah daerah, provinsi dan nasional.
- e. Menginterpretasi perubahan industri dan mengimplementasikan dalam organisasi
- f. Menginterpretasikan perubahan ekonomi staf
- g. Menetapkan organisasi sebagai bagian yang penting dari pemerintah

3. Hubungan Masyarakat/komunikasi

- a. Empati, mendengar, dan tanggapan terhadap semua pernyataan orang lain
- b. Menciptakan situasi yang kondusif dalam komunikasi
- c. Membaca dan tanggap terhadap situasi politik yang terjadi
- d. Menunjukkan rasa percaya diri melalui kemampuan berkomunikasi dalam mempengaruhi orang lain
- e. Berkomunikasi secara efektif melalui tulisan
- f. Mengembangkan proses hubungan yang baik di dalam dan diluar organisasi
- g. Menggunakan media untuk pemasaran /keuntungan organisasi.

4. Anggaran

- a. Bertanya dan melihat rencana sebelumnya

- b. Mengontrol anggaran
- c. Menginterpretasikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
- d. Merencanakan jauh ke depan
- e. Menggunakan pengukuran dan rata-rata industri
- f. Menyediakan resiko terhadap kekurangan keuangan
- g. Mengonsultasikan masalah keuangan.

5. Pengembangan

- a. Pengembangan tim kerja yang efektif
- b. Mempertahankan dan mengembangkan hubungan profesional antarstaf
- c. Memberikan upan balik yang positif
- d. Menerapkan peran mentor yang efektif
- e. Menggunakan sistem pemberian penghargaan yang baik
- f. Mengembangkan, meningkatkan dan meninjau indikasi organisasi

6. Kepribadian

- a. Memfokuskan satu atau lebih dari dua kejadian dalam satu periode
- b. Mengaplikasikan filosofi manajemen dan komitmen terhadap kualitas pelayanan
- c. Mengambil keputusan yang tepat
- d. Mengelola stress individu
- e. Menerima sesuatu terhadap kejadian yang tidak diharapkan
- f. Menggunakan coping yang efektif pada setiap masalah
- g. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan atas keberhasilan pencapaian tujuan

7. Negosiasi

- a. Mengidentifikasi dan mengelola konflik
- b. Memfasilitasi perubahan
- c. Mendemonstrasikan pemahaman tentang perbedaan pendapat
- d. Melakukan negosiasi dengan baik
- e. Melakukan klasifikasi kejadian yang melibatkan seluruh staf
- f. Melakukan negosiasi dengan staf, kelompok dan organisasi luar
- g. Menjadi mediator terjadinya konflik antar staf atau kelompok

D. Kesehatan Global

Menurut Koplan (2009) kesehatan global adalah bidang studi, penelitian, dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesetaraan status kesehatan seluruh masyarakat dunia. Karena bersifat transnasional, kesehatan global fokus pada permasalahan kesehatan yang mempengaruhi banyak negara, misalnya pandemi virus SARS-CoV-2, Covid 19 dan lain sebagainya.

Definisi WHO mengenai kesehatan adalah keutuhan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial dan tidak selalu tentang absennya suatu penyakit ataupun gangguan lain. Karenanya, kesehatan global tidak selalu mengenai penyebaran penyakit di suatu wilayah, tetapi juga terkait perkembangan ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat, epidemiologi, serta faktor-faktor penentu lain seperti demografi, status ekonomi, serta kebudayaan.

Kompleksitas permasalahan kesehatan global membutuhkan kerja sama berbagai organisasi dan pemerintah untuk dapat diuraikan. WHO adalah organisasi global terbesar yang memfasilitasi kerja sama ini. Selain itu ada pula organisasi kesehatan seperti Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) dan Doktor Tanpa Batas (*Médecins Sans Frontières*) yang terlibat dalam persoalan serupa.

1. Sejarah Kesehatan Global

Sejarah kesehatan global berakar dari kemunculan bidang ilmu kedokteran koloni dan tropis (*colonial and tropical medicine*) pada era kolonialis bangsa Eropa¹. Kondisi ini yang mendasari kesehatan global menjadi sebuah pemikiran baru dalam dunia kesehatan yang saat ini fokus pada keadilan kesehatan. Istilah *global health* atau kesehatan global pertama kali ditemukan tahun 1940an dan selanjutnya digunakan World Health Organization (WHO) sebagai dasar pedoman dan teori. Pada dekade terakhir telah banyak dipublikasikan penelitian yang membahas tentang kesehatan global (1).

Kesehatan global merupakan bagian dari ilmu pengetahuan (ilmu kesehatan) dan penelitian karena mempelajari seluruh strategi untuk meningkatkan kesehatan, baik berbasis populasi maupun individu, dan melibatkan seluruh sektor tidak hanya kesehatan (1,2). Studi yang dilakukan oleh ilmuwan kesehatan global membantu memahami faktor-faktor kompleks yang berkontribusi terhadap kesehatan dan penyakit. Misalnya:

- a. Studi tentang dampak perubahan iklim pada kesehatan
- b. Studi tentang efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat untuk mengurangi penularan penyakit
- c. Studi tentang pengembangan obat atau vaksin baru untuk mencegah penularan penyakit di negara berkembang

Kesehatan global juga merupakan bagian dari praktis/aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesehatan pada masyarakat global sehingga dapat dihasilkan dunia yang lebih sehat. Contoh praktis penerapan kesehatan global antara lain:

- a. Menghasilkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak terlayani atau sulit terjangkau oleh pelayanan

- b. Mengimplementasikan program kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit
- c. Mengadvokasi (memberikan masukan, mengevaluasi dll) kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan keadilan pelayanan kesehatan
- d. Melakukan aktivitas untuk meningkatkan faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan kesehatan
- e. Merencanakan penelitian untuk mengembangkan metode peningkatan kesehatan yang baru dan lebih baik

2. Kesehatan global fokus pada peningkatan kesehatan dan keadilan mengakses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia

Kesehatan global fokus pada masalah isu-isu medis dan kesehatan yang memiliki dampak secara global. Dengan demikian terdapat perbedaan mendasar antara kesehatan global dengan ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu medis dalam hal sasarannya.

Memberikan keadilan terhadap akses pelayanan kesehatan merupakan masalah moral yang harus dijalankan oleh negara. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan hidup yang sehat tanpa memandang ras, etnik, gender, status sosial ekonomi, atau geografi. Adanya keadilan terhadap kesehatan merupakan aspek penting untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Penduduk yang sehat lebih produktif, dan komunitas/masyarakat yang sehat lebih memiliki ketahanan menghadapi gangguan dan krisis kesehatan.

Beberapa alasan yang menyebabkan keadilan kesehatan (*health equity*) sangat penting bagi kesehatan global:

- a. Dunia semakin lama semakin mudah terkoneksi satu sama lain. Penyakit yang semula berkembang di negara berkembang, akhir-akhir ini juga menyebar di negara maju. Contohnya: Zika virus yang pertama kali ditemukan di Brazil lambat laun menyebar ke 80 negara
- b. Perubahan iklim yang menjadi penyebab perubahan cuaca yang ekstrim dapat memperparah ketimpangan pelayanan kesehatan Misalnya: banjir, kekeringan, dan udara panas yang secara tidak langsung melumpuhkan pelayanan kesehatan bahkan merusak fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan keterbatasan akses.
- c. Globalisasi menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang baru. Ketidakadilan ini berperan terhadap perbedaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan faktor sosial lain.

3. Kesehatan Global merupakan sistem yang kompleks dan saling terkoneksi secara global

Kompleksitas kesehatan global disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan antara lain sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Faktor-faktor ini saling terkoneksi secara global dengan cara yang rumit, akibatnya sulit diprediksi bagaimana satu faktor mempengaruhi faktor lain. Misalnya: perubahan iklim mempengaruhi penularan penyakit secara global dan secara tidak langsung meningkatkan permintaan pelayanan kesehatan. Saling keterhubungan antara iklim, penyakit menular, dan pelayanan kesehatan ini terjadi secara kompleks.

4. Krisis Kesehatan Global

International Labor Organization (ILO) menyatakan penduduk dunia berada dalam kondisi krisis kesehatan global dapat dilihat dari tiga dimensi yakni:

- a. Hilangnya hak penduduk untuk sehat. Hak sehat merupakan hak asasi manusia tanpa memandang status sosial dan ekonomi, namun kenyataannya masih ada jutaan penduduk yang tidak terpenuhi haknya. Kondisi kehilangan hak sehat ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni:
 - 1) Sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau
 - 2) Kemampuan pelayanan kesehatan yang rendah
 - 3) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Terjadi pemiskinan akibat tingginya biaya pelayanan kesehatan, yang ditandai dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Masih terdapat praktik pembayaran tarif pelayanan kesehatan dari kantong pribadi (*out of pocket*) yang membebani masyarakat miskin
 - 2) Tidak semua negara memiliki jaminan kesehatan yang diberikan gratis terhadap rakyatnya akibatnya terjadi penundaan pengobatan bahkan tidak melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya
 - 3) Tingginya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan orang sakit akan menjual aset yang dimiliki atau berhutang untuk menutupi biaya pelayanan kesehatan
- c. Kualitas pelayanan kesehatan yang rendah akibat kekurangan tenaga kesehatan secara global terutama di daerah pedesaan (rural). Hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah satu negara terhadap petugas yang memberikan pelayanan kesehatan.

5. Ukuran Kesehatan Global

Ukuran kesehatan global penting untuk membandingkan kualitas kesehatan di satu negara dengan negara lainnya. Salah satu bentuk ukurannya adalah beban penyakit global (Global Disease Burden/GDB) yang mengukur dampak masalah

kesehatan dari mortalitas, morbiditas, dan biaya finansialnya. Hasil pengukuran ini mencerminkan kualitas hidup sebuah populasi, baik kesehatan fisik maupun mental.

Pengukuran lain yang juga menjadi acuan ialah Disability Adjusted Life Year (DALY). DALY merupakan jumlah tahun hidup yang hilang akibat kematian dini ditambah tahun hidup dengan kecacatan karena kasus umum penyakit atau kondisi kesehatan dalam suatu populasi. Selain itu, terdapat juga indikator angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian dewasa, dan angka prevalensi suatu penyakit. Indikator tersebut juga tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor tiga. Beberapa target yang ingin dicapai sebelum 2030 ialah menurunkan rasio kematian ibu dan bayi, mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular, dan mencapai layanan kesehatan universal.

6. Peran Pemimpin

Peran strategis seorang pemimpin dibutuhkan dalam situasi krisis dengan menjalankan manajemen krisis. Berbeda dengan manajemen risiko, yang melibatkan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman, manajemen krisis berurusan dengan ancaman sebelum, selama, dan setelah terjadi. Ini adalah disiplin dalam konteks manajemen yang lebih luas yang terdiri dari keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama sejak pertama kali terjadi hingga titik dimulainya prosedur pemulihan. Apa yang dibutuhkan para pemimpin selama krisis bukanlah rencana respons yang telah ditentukan sebelumnya tetapi perilaku.

Studi tentang manajemen krisis berasal dari bencana industri dan lingkungan berskala besar pada 1980-an.⁴ Menurut penelitian Seeger, M. W.; Sellnow, T. L.; Ulmer terdapat tiga elemen yang biasa terjadi pada krisis: (a) ancaman bagi organisasi, (b) elemen kejutan, dan (c) waktu keputusan yang singkat.⁵ Venette⁶ berpendapat bahwa krisis adalah proses transformasi di mana sistem yang lama tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, kualitas yang menentukan keempat adalah kebutuhan untuk perubahan. Jika perubahan tidak diperlukan, peristiwa itu bisa lebih akurat digambarkan sebagai kegagalan atau insiden. Disisi lain menurut Arnold Howitt and Herman B. Leonard dalam menghadapi situasi demikian, dimana ketidakbiasaan dan ketidakpastian berakhirnya krisis, para pemimpin harus dapat berimprovisasi.⁷ Seperti misalnya kebijakan kerja dari rumah (*learning from home*), penyesuaian praktik kerja yang sedang berlangsung, termasuk juga adalah adopsi alat baru

dalam membantu para dosen dan guru yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan bahkan setelah krisis berlalu.

Untuk melengkapi argument-argumen para ilmuwan di atas, dalam artikel ini, penulis akan mengeksplorasi tindakan para pemimpin dalam menjalankan manajemen krisis untuk menghindari ancaman sebelum dan selama krisis covid-19 terjadi dengan melakukan review terhadap berbagai literatur dan hasil kajian terdahulu yang relevan.

E. Literature Review

Manajemen krisis adalah proses di mana organisasi menangani peristiwa yang mengganggu dan tidak terduga yang mengancam untuk membahayakan organisasi atau para pemangku kepentingannya.⁸ Sedangkan menurut Gultekin manajemen krisis adalah tindakan pemimpin yang berkuasa di masa krisis.⁹ Dengan kata lain, manajemen krisis memerlukan pengambilan keputusan yang sistematis dan pembentukan tim untuk menerapkan keputusan tersebut dan kemampuan untuk membuat keputusan baru untuk mencapai hasil sesegera mungkin, dan menurut Murat dalam manajemen krisis umumnya ada beberapa unsur, yaitu tim manajemen krisis, konsultan profesional, penyusun rencana manajemen krisis, pembuat undang-undang; penyedia pelatihan dan konsultasi, penegak tindakan disiplin. Cara termudah untuk mengatasi krisis adalah mencoba memecahkan masalah dengan kerja tim. Dari berbagai pendapat tersebut dapat nyatakan bahwa manajemen krisis merupakan proses yang terjadi dalam organisasi dalam merespon peristiwa besar yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi, para pengambil kebijakan, atau masyarakat umum. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting untuk mendefinisi krisis: ancaman terhadap organisasi, elemen kejutan, dan keputusan yang cepat. Dalam konteks ini, menurut Tutar¹⁸ para pemimpin dituntut untuk mendeteksi masalah ketika krisis terjadi, mengidentifikasi masalah dalam kerangka tujuan yang direncanakan, mengidentifikasi peluang yang paling praktis, mengevaluasi kegunaan

Lingkungan krisis membutuhkan pengambilan keputusan dan implementasi segera, Sisman, M. ve Turan, S menyatakan bahwa manajemen krisis membutuhkan pemimpin yang memiliki visi. Di dunia modern, pemimpin visioner memiliki pandangan ke depan untuk masa depan, identifikasi visi dan tujuan yang realistis untuk masa depan organisasi, dan memotivasi bawahan untuk mewujudkannya. Beban paling signifikan terkait manajemen krisis adalah kenyataan bahwa beberapa pemimpin lebih suka berpegang pada peraturan. Karena mereka ingin melihat semua tindakan dan operasi mereka dinyatakan sesuai dalam undang-undang, mereka tidak dapat mengambil keputusan segera dalam peristiwa yang tidak

terduga. Ini mempengaruhi manajemen organisasi secara negatif. Disamping dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, menurut Kadibesegil dalam menjalankan manajemen krisis juga dibutuhkan seorang pemimpin sejati yang memiliki solusi dalam menghadapi setiap jenis krisis, itu sebabnya mereka optimis.

Seorang pemimpin sejati mengubah *status quo* dan tentu saja menciptakan perbedaan. Dalam pengertian ini, kepemimpinan bukanlah "tugas" tetapi tanggung jawab yang tidak terhindarkan. Poin penting lain dari manajemen krisis adalah faktor pencapaian. Tidak hanya diperlukan untuk melakukan tugas tetapi juga untuk mencerminkan semua karakteristik kepemimpinan.

Para pemimpin pada situasi krisis harus mampu memandu jalan, mengambil keputusan, memulai dan mengoperasikan tindakan.²¹ Luecke²² menyatakan bahwa selama keadaan krisis orang membutuhkan pemimpin yang kuat, percaya diri dan mudah diajak komunikasi. Para pemimpin harus mampu mengatasi keadaan krisis di mana terdapat lingkungan kekacauan dalam organisasi, mereka harus merestrukturisasi organisasi dan mengadopsinya dengan keadaan lingkungan yang berubah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa, seorang pemimpin memiliki peran penting dalam manajemen krisis. Dengan demikian, perlu mempelajari karakteristik seorang pemimpin dalam manajemen krisis.

Selanjutnya menurut Bayazit, Z.D., Cengel O., Tepe F.²³ terdapat tiga jenis manajemen yang digunakan untuk mengatasi krisis dalam organisasi, yaitu manajemen pra-krisis, saat krisis dan pasca krisis. Dalam manajemen proses pra-krisis, para pemimpin bertujuan untuk memahami indikator krisis dan mengubah kondisi krisis menjadi suatu pencapaian. Sedangkan manajemen selama krisis, para pemimpin berupaya melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari krisis lebih dalam. Ketika keadaan krisis berakhir, proses pasca krisis dimulai. Pada titik ini, para pemimpin menemukan solusi yang sesuai yang disesuaikan dengan perubahan dan membawa dimensi baru pada kegiatan dan strategi mereka.

Krisis dapat memengaruhi sebuah organisasi baik secara berkala atau tiba-tiba. Dalam menghadapi krisis para pemimpin puncak harus dapat menjalankan pendekatan manajemen krisis secara inovatif serta siap terhadap segala jenis krisis. Karena faktanya bahwa krisis dapat mempengaruhi organisasi secara negatif dan signifikan. Kelangsungan hidup mereka dengan kerugian minimal sangat bergantung pada pembentukan sistem peringatan dini, berjuang dengan krisis secara efektif, dan mengubah kondisi pra-krisis dalam waktu singkat. Para pemimpin puncak harus mampu melakukan analisis SWOT dan dengan demikian dapat memiliki berbagai peluang bahwa krisis membawa pada bidang kekuatan mereka. Selain itu, mereka harus menempatkan kualitas sebagai prioritas utama. Selain

tindakan pencegahan ini, para pemimpin puncak harus dapat membuat beberapa upaya perencanaan melawan krisis, membentuk tim manajemen krisis, memperbaiki beberapa skenario krisis, dan mengujinya bersama dengan solusi mereka. Para pemimin puncak dalam menjalankan manajemen krisis juga harus mencatat informasi dan pelajaran dari krisis serta mencatat kesalahan yang dilakukan dalam proses krisis. Selain itu, personel berkinerja tinggi dapat diberikan penghargaan sementara personel berkinerja rendah dapat diberikan hukuman teguran hingga pemecatan.

Beberapa peristiwa penting mewarnai kemajuan ataupun krisis kesehatan global. Pada 1796, [Edward Jenner](#), seorang ilmuwan asal Inggris, pertama kali mengembangkan vaksin untuk memutus penyebaran penyakit cacar. Perlu dicatat, sebelum munculnya vaksin, satu dari tiga belas kematian di London disebabkan cacar. Penyakit cacar juga mudah menular melalui *drop/lets*. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah awal mula eradikasi penyakit melalui vaksinasi.

Selain kemajuan teknologi kesehatan, krisis kesehatan dunia juga beberapa kali terjadi. Sebut saja wabah kolera pada awal tahun 1800-an yang membunuh lebih dari 100.000 orang, wabah pes yang mengakibatkan kematian 12 juta orang pada pertengahan 1800-an, dan wabah flu Spanyol pada awal 1900-an yang menjangkiti lebih dari 500 juta orang. Setiap krisis kesehatan terjadi, dunia menaruh perhatian lebih pada pentingnya sistem kesehatan. Kerja sama kesehatan global pun semakin meningkat dengan dibentuknya WHO pada 1948. WHO mempublikasikan daftar obat esensial yang berisikan obat-obatan paling efektif dan aman untuk mengatasi penyakit-penyakit umum. Beberapa tahun setelahnya muncul Deklarasi Alma Ata pada tahun 1978 yang menyoroti pentingnya fasilitas kesehatan primer dalam menjaga kesehatan masyarakat.

F. Kesimpulan

Meski kesehatan global melihat permasalahan dalam lingkup internasional, namun implementasi intervensi kesehatan selalu dilakukan dalam skala yang lebih kecil. Pada tingkat nasional, pemerintah merumuskan kebijakan untuk menentukan arah pembangunan kesehatan di negara masing-masing. Dalam hal ini, pelibatan aktor lain yaitu masyarakat sipil dan sektor swasta juga penting.

Lembaga masyarakat sipil berwujud think tank seperti CISDI berperan melalui rekomendasi kebijakan yang akurat dan berbasis bukti kepada pemerintah. Di samping itu, CISDI kerap berjejaring dengan berbagai pihak serta menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan melalui kelas online bagi nakes, donasi kebutuhan tenaga kesehatan, hingga menyelenggarakan Program Pencerah Nusantara.

Kerja sama multipihak yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan adalah salah satu pokok bahasan kesehatan global. Tanpa ada kerja sama yang ajeg dan terstruktur antar aktor domestik dan internasional, peningkatan derajat kesehatan akan sukar terpenuhi.

Pandangan ini perlu digarisbawahi sebagai dasar untuk meningkatkan indikator-indikator kesehatan di sebuah negara. Sebab, tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik, upaya kesehatan global untuk meningkatkan akses kesehatan bagi semua, akan selalu sulit terwujud.

G. Referensi

Chen X, Li H, Lucero-Prisco DE, Abdullah AS, Huang J, Laurence C, et al. What is global health? Key concepts and clarification of misperceptions. *Glob Heal Res policy*. 2020;5(14). Beaglehole R, Bonita R. What is global health? *Glob Health Action*. 2010;3(1).

Http/e-Juorenal.staima-alhikam.ac./index/php/mpi/ 10.32478/leadership.V1i2.448
<https://www.metrotvnews.com/read/N9nC29wY-praktisi-kesehatan-beberkan-langkah-antisipasi-krisis-kesehatan-global><https://cisdi.org/artikel/apa-yang-dimaksud-dengan-kesehatan-global-ini-penjelasan-dan-cara-mengukurnya>

Http/e-Juorenal.staima-alhikam.ac./index/php/mpi/ 10.32478/leadership.V1i2.448

Nursalam (2011). *Manajemen Keperawatan edisi 3*: Jakarta Salemba Medika, 2011. ISBN.978-602-8570-73-2

World Economic Forum. *Global Health and Healthcare Strategic Outlook: Shaping the Future of Health and Healthcare*. 2023. ILO Social Protection Department. *Addressing the Global Health Crisis: Universal Health Protection Policies*. Geneva; 2014. (Social Protection Policy Papers). Report No.: 13

BAB 5

MODEL KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPERAWATAN

Syaiful, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah perpaduan berbagai perilaku yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain bersedia dan dapat menyelesaikan tugas - tugas tertentu yang dipercayakan kepadanya (Ordway Tead).

"Metode kepemimpinan partisipatif adalah pendekatan kepemimpinan yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan, Kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan, memberikan kesempatan untuk berkontribusi, berbagi ide dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan anggota tim dan membangun kemitraan yang kuat antara semua pihak yang terkait [2]." (Agus, Iqbal, Lim, 2023)(Prasetyo, 2022).

Kepemimpinan partisipatif adalah salah satu gaya kepemimpinan yang digunakan oleh mereka yang dipercaya dengan memberikan ruang dan peran kepada bawahan dalam aktivitas pengambilan keputusan [2]." (Agus, Iqbal, Lim, 2023)(Prasetyo, 2022). Selain itu, metode ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan bawahan serta menciptakan rasa memiliki bersama terhadap kesuksesan suatu organisasi.

Melalui metode kepemimpinan partisipatif, bawahan merasa dihargai dan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama, mereka merasa lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka, karena mereka merasa bahwa pendapat dan ide-ide mereka dihargai dan diperhitungkan. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana setiap anggota tim merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang sama dalam mencapai kesuksesan bersama. Dengan demikian, metode kepemimpinan partisipatif tidak hanya membawa manfaat bagi kinerja organisasi, tetapi juga bagi hubungan antar anggota tim dan iklim kerja secara keseluruhan.

B. Teori dan Gaya Kepemimpinan

1. Berbagai pendapat tentang Definisi kepemimpinan :

- a. Kepemimpinan adalah perpaduan berbagai perilaku yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain bersedia dan dapat menyelesaikan tugas - tugas tertentu yang dipercayakan kepadanya (Ordway Tead).
- b. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mau berbuat dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Stogdill).
- c. Kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Georgy R. Terry).
- d. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu situasi tertentu (Paul Hersay, Ken Blanchard)
- e. Kepemimpinan dalam keperawatan : merupakan penggunaan ketrampilan seorang pemimpin (perawat) dalam mempengaruhi perawat - perawat lain yang berada di bawah pengawasannya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan sehingga tujuan keperawatan tercapai.

2. Teori Kepemimpinan

Ada beberapa teori kepemimpinan yang pernah dikemukakan, antara lain :

- a. Teori orang besar atau teori bakat
Di sini disebutkan bahwa seorang pemimpin dilahirkan, artinya bakat - bakat tertentu yang diperlukan seseorang untuk menjadi pemimpin diperolehnya sejak lahir.
- b. Teori situasi
Bertolak belakang dengan teori bakat ialah teori situasi (situasional theory). Teori ini muncul sebagai hasil pengamatan, dimana seseorang sekalipun bukan keturunan pemimpin, ternyata dapat pula menjadi pemimpin yang baik. Hasil pengamatan tersebut menyimpulkan bahwa orang biasa yang jadi pemimpin tersebut adalah karena adanya situasi yang menguntungkan dirinya, sehingga ia memiliki kesempatan untuk muncul sebagai pemimpin.
- c. Teori Ekologi
Sekalipun teori situasi kini banyak dianut, dan karena itu masalah kepemimpinan banyak menjadi bahan studi, namun dalam kehidupan sehari -

hari sering ditemukan adanya seorang yang setelah berhasil dibentuk menjadi pemimpin, ternyata tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Hasil pengamatan yang seperti ini melahirkan teori ekologi, yang menyebutkan bahwa seseorang memang dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat - bakat tertentu yang terdapat pada diri seseorang yang diperoleh dari alam.

3. Gaya Kepemimpinan

Gaya diartikan sebagai suatu cara penampilan karakteristik. Follet (1940) gaya didefinisikan sebagai hak istimewa yang tersendiri dari si ahli dengan hasil akhir yang dicapai tanpa menimbulkan isu sampingan.

Terdapat beberapa pendapat tentang klasifikasi dari gaya kepemimpinan.

a. Menurut Likert, mengelompokan gaya kepemimpinan dalam 4 sistem, yaitu :

1) Sistem *otoriter – eksploitatif*.

Pemimpin type ini sangat otoriter, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya, memotivasi bawahan melalui ancaman / hukuman, komunikasi yang dilakukan satu arah kebawah (Top – Down).

2) Sistem *Benevolent – Autoritative*.

Pemimpin mempercayai bawahan sampai pada tingkat tertentu, memotivasi bawahan dengan ancaman / hukuman tetapi tidak selalu dan membolehkan komunikasi keatas, pemimpin memperhatikan ide bawahan dan mendelegasikan wewenang meskipun dalam mengambil keputusan masih melakukan pengawasan ketat.

3) Sistem *konsultatif*.

Kepercayaan terhadap bawahan cukup besar, untuk memotivasi bawahan menggunakan insentif dan kadang-kadang menggunakan ancaman, komunikasi 2 arah, menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan.

4) Sistem *Partisipatif*.

Kepercayaan penuh terhadap bawahan, memotivasi dengan insentif ekonomi, memanfaatkan ide-ide dari bawahan, komunikasi dua arah dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja.

b. Menurut teori X dan Teori Y oleh Douglas Mc Gregor.

Menyebutkan bahwa perilaku seseorang dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan dalam 2 kutub utama yaitu sebagai teori X dan teori Y

1) Teori X mengarah ke aktivitas : tidak menyukai pekerjaan yang ambisi, tidak mempunyai tanggung jawab, cenderung menolak perubahan dan lebih suka dipimpin dari pada memimpin.

- 2) Sebaliknya teori Y mengasumsikan bahwa : bawahan itu senang bekerja, bisa menerima tanggung jawab maupun mandiri, mampu mengawasi diri, mampu bermajinasi dan kreatif.

Dari teori ini gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

- 1) *Gaya kepemimpinan Diktator* : Gaya kepemimpinan yang dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta menggunakan ancaman dan hukuman merupakan bentuk dari pelaksanaan teori X.
- 2) *Gaya kepemimpinan Autokratis* : Hampir sama dengan gaya diktator namun bobotnya agak kurang . segala keputusan berada di tangan pimpinan , pendapat dari staf tidak pernah dibenarkan. Merupakan bentuk Pelaksana dari teori X.
- 3) Gaya kepemimpinan demokratis : Ada peran serta dari bawahan dalam pengambilan keputusan, menggunakan teori Y.
- 4) Gaya kepemimpinan santai : Perananan dari pemimpin hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan, gaya kepemimpinan ini sesuai dengan teori Y.

C. Konsep Metode Kepemimpinan Partisipatif

1. Definisi metode kepemimpinan partisipatif

Adalah pendekatan kepemimpinan di mana manajer atau pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan. Dalam metode ini, para anggota tim diberi kesempatan untuk berkontribusi, berbagi ide, dan memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar di antara anggota tim, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Metode kepemimpinan partisipatif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan harmonis, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan.

Dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, anggota tim merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan yang lebih besar dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, metode kepemimpinan partisipatif juga dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara manajer atau pemimpin dengan anggota tim, sehingga memperkuat kerjasama dan komunikasi di dalam tim. Secara keseluruhan, pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, inovatif, dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Contoh detail dari kepemimpinan partisipatif adalah ketika seorang manajer mengadakan rapat tim rutin untuk mengumpulkan masukan dari setiap anggota tim sebelum mengambil keputusan

penting. Melalui diskusi dan kolaborasi ini, anggota tim merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Namun, terdapat contoh kontraproduktif dari kepemimpinan partisipatif ketika seorang manajer terlalu banyak meminta masukan dari anggota tim tanpa mengambil keputusan akhir. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di dalam tim, serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya efisien.

2. Karakteristik pemimpin partisipatif

Adapun karakteristik pemimpin partisipatif yang efektif meliputi kemampuan mendengarkan dengan baik, memfasilitasi diskusi yang produktif, serta memiliki keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi. Pemimpin partisipatif juga harus mampu mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber dan memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil adalah yang terbaik untuk tim dan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pemimpin partisipatif juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan panduan yang jelas kepada anggota tim setelah proses pengambilan keputusan selesai, sehingga memastikan bahwa implementasi keputusan berjalan lancar dan efektif.

Pemimpin partisipatif harus menjaga keseimbangan antara mendengarkan dengan baik, memfasilitasi diskusi yang produktif, serta memiliki keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi. Hal ini akan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam tim. Selain itu, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai sumber, pemimpin partisipatif dapat membuat keputusan yang lebih berkualitas dan terencana dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efisien.(QuillBot, 2024)

Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, tim dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin partisipatif juga dapat memberikan ruang bagi anggota tim untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan memotivasi. Dengan demikian, partisipasi aktif dari seluruh anggota tim akan memperkuat hubungan kerja yang positif dan membangun kepercayaan di antara anggota tim.

3. Manfaat dari metode kepemimpinan partisipatif dalam pengambilan keputusan keperawatan

Adalah peningkatan kualitas pelayanan dan perawatan pasien. Dengan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih memiliki terhadap hasil kerja mereka dan lebih berkomitmen untuk

memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, metode kepemimpinan partisipatif juga dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota tim, karena mereka merasa dihargai dan didengarkan oleh pemimpin mereka. Hal ini akan berdampak positif pada produktivitas dan motivasi anggota tim, serta pada hasil kerja yang dicapai. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dalam bidang keperawatan untuk menerapkan metode kepemimpinan partisipatif guna mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih memiliki terhadap hasil kerja mereka dan lebih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu, metode kepemimpinan partisipatif juga dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota tim, karena mereka merasa dihargai dan didengarkan oleh pemimpin mereka. Hal ini akan berdampak positif pada produktivitas dan motivasi anggota tim, serta pada hasil kerja yang dicapai. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dalam bidang keperawatan untuk menerapkan metode kepemimpinan partisipatif guna mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kerjasama tim akan semakin solid dan efektif dalam mencapai tujuan bersama.

D. Implementasi Metode Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan

1. Langkah-langkah dalam menerapkan metode kepemimpinan partisipatif

Dalam pengambilan keputusan keperawatan sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab yang sama. Langkah pertama adalah dengan mengadakan pertemuan reguler antara pemimpin dan anggota tim untuk mendiskusikan berbagai masalah dan mencari solusi bersama. Selain itu, pemimpin juga perlu memberikan ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka secara terbuka tanpa rasa takut. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih akurat dan didukung oleh seluruh anggota tim, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara pemimpin dan anggota tim, akan tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, dengan melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, akan meningkatkan rasa memiliki dan motivasi anggota tim untuk bekerja secara efektif. Hal ini juga akan menciptakan iklim kerja yang positif dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan demikian, pelayanan keperawatan yang diberikan akan lebih berkualitas dan memuaskan bagi pasien.

2. Peran perawat dan tim dalam pengambilan keputusan keperawatan

Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk pasien. Perawat sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan keperawatan harus memiliki keterlibatan yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka harus dapat memberikan masukan dan pendapat mereka berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan juga akan memperkuat kolaborasi antar anggota tim dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, pasien akan mendapatkan perawatan yang holistik dan terpadu. Selain itu, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan juga akan memperkuat kolaborasi antar anggota tim dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memberikan kepuasan baik bagi pasien maupun tim perawat itu sendiri. Keselarasan antara keputusan yang diambil dan kebutuhan pasien akan menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas.

3. Studi kasus tentang keberhasilan metode kepemimpinan partisipatif dalam pengambilan keputusan keperawatan

Dapat menjadi referensi yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan perawatan. Dengan melibatkan seluruh anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini juga akan memperkuat komunikasi antar anggota tim dan meningkatkan kolaborasi dalam merawat pasien. Dengan demikian, metode kepemimpinan partisipatif dapat menjadi kunci sukses dalam memberikan pelayanan keperawatan yang holistik dan terpadu. Dalam konteks keperawatan, penting bagi pemimpin untuk memperhatikan pendapat dan masukan dari seluruh anggota tim, termasuk perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih terencana dan terstruktur, serta lebih dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, melalui metode kepemimpinan partisipatif, anggota tim akan merasa dihargai dan diakui atas kontribusi dan keahlian mereka, sehingga semangat kerja dan motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik akan semakin tinggi. Dengan demikian, tidak hanya kualitas pelayanan perawatan yang meningkat, tetapi juga kepuasan pasien dan keluarganya dapat terjamin.

Sebagai contoh, dalam suatu rumah sakit, seorang kepala departemen dapat menggunakan metode kepemimpinan partisipatif untuk mengambil keputusan terkait peningkatan kualitas pelayanan. Dengan melibatkan seluruh

anggota tim, seperti perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya, mereka dapat bekerja sama untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dan efisien.

E. Tantangan dan Strategi Mengatasi dalam Mengimplementasikan Metode Kepemimpinan Partisipatif

1. Faktor-faktor yang dapat menghambat proses kepemimpinan partisipatif

Antara lain resistensi dari beberapa anggota tim yang tidak terbiasa dengan gaya kepemimpinan tersebut, kurangnya komunikasi yang efektif, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, kepala departemen perlu memberikan pelatihan dan pembinaan kepada anggota tim agar mereka dapat memahami dan menerima metode kepemimpinan partisipatif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan komunikasi antar anggota tim dan membangun hubungan kerja yang harmonis agar tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif.

Dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh kepala departemen, diharapkan anggota tim yang awalnya tidak terbiasa dengan gaya kepemimpinan partisipatif dapat belajar untuk bekerja secara kolaboratif dan proaktif. Selain itu, peningkatan komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis juga akan membantu meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek konstruksi yang melibatkan berbagai divisi seperti desain, konstruksi, dan keuangan, pelatihan yang difokuskan pada komunikasi dan kerjasama tim dapat membantu memastikan bahwa setiap bagian proyek dapat bekerja secara sinergis.(Wardatul, Wahyu, Beban, 2023) Dengan adanya hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi yang baik antar anggota tim, proyek konstruksi tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jika setiap divisi bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik.

2. Strategi untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan metode kepemimpinan partisipatif

"Pastikan setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan peran masing-masing dalam mencapainya dengan menetapkan hierarki kepemimpinan dan peran penting di awal proyek, membangun kepercayaan dan mendorong kolaborasi, serta mengkomunikasikan tujuan, kemajuan, dan kemunduran dengan jelas kepada para pemangku kepentingan.(Switek, 2024)

Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemimpin dan anggota tim, akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama proses proyek. Selain itu, membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung di antara anggota tim juga merupakan strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, metode kepemimpinan partisipatif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan bagi proyek konstruksi yang sedang dikerjakan. (*Buku Ajar Keperawatan*, n.d.)

Sebagai contoh, pemimpin proyek konstruksi yang menerapkan metode kepemimpinan partisipatif dapat mengadakan pertemuan reguler dengan anggota tim untuk membahas perkembangan proyek dan mengumpulkan masukan dari seluruh tim. Dengan terbentuknya komunikasi yang efektif dan hubungan kerja yang solid, tim akan dapat bekerja secara sinergis untuk mengatasi tantangan

3. Peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan partisipatif

Pendidikan dan pelatihan dapat membantu pemimpin untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kepemimpinan partisipatif. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan, seorang pemimpin dapat memahami pentingnya membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertukaran ide dan kolaborasi. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan partisipatif dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seorang pemimpin juga dapat memperoleh pengetahuan tentang cara memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dengan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, seorang pemimpin dapat lebih efektif dalam mengelola tim dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi pemimpin merupakan langkah yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sukses dan berkelanjutan. (Yeni, 2019)

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dapat menggunakan pengetahuannya untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim, sehingga meningkatkan kinerja dan motivasi mereka. Selain itu, dengan keterampilan manajerial yang diperoleh

melalui pendidikan, seorang pemimpin dapat mengelola konflik di antara anggota tim.

F. Kesimpulan

1. Recapitulasi metode kepemimpinan partisipatif dalam pengambilan keputusan keperawatan

Dapat meningkatkan kualitas layanan perawatan yang diberikan kepada pasien. Dengan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepuasan pasien dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara tim perawat dan pasien. Dengan demikian, metode kepemimpinan partisipatif dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memajukan bidang keperawatan. (Pode, n.d.)

Dengan adanya partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan, pemimpin juga dapat memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan yang dapat meningkatkan inovasi dalam pelayanan perawatan. Hal ini akan memungkinkan tim perawat untuk terus berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka dalam merawat pasien dengan lebih baik. Dengan demikian, metode kepemimpinan partisipatif tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien, tetapi juga bagi seluruh tim perawat dan institusi kesehatan secara keseluruhan.

2. Implikasi pentingnya metode kepemimpinan partisipatif dalam praktik keperawatan

Pentingnya metode kepemimpinan partisipatif dalam praktik keperawatan juga dapat dilihat dari peningkatan motivasi dan kepuasan kerja anggota tim. Dengan adanya kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, anggota tim akan merasa dihargai dan memiliki rasa memiliki terhadap pekerjaan mereka. Hal ini akan membuat mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Selain itu, metode kepemimpinan partisipatif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan saling mendukung, sehingga memperkuat hubungan antar anggota tim dan meningkatkan efektivitas kerja mereka.

Dengan demikian, tim akan lebih mudah mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Selain itu, adanya komunikasi yang terbuka dan transparan dalam tim juga akan membantu mencegah konflik dan memperkuat kerja sama di antara anggota tim. Secara keseluruhan, pendekatan kepemimpinan partisipatif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat baik bagi anggota tim maupun pasien yang dilayani.

3. Rekomendasi untuk pengembangan metode kepemimpinan partisipatif dalam pengambilan keputusan keperawatan.

Pendekatan kepemimpinan partisipatif juga dapat meningkatkan motivasi anggota tim, karena mereka merasa memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri anggota tim, sehingga kinerja tim secara keseluruhan dapat meningkat. Selain itu, dengan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, akan tercipta rasa saling memiliki dan komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan bersama. Ini akan menciptakan iklim kerja yang harmonis dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan individu dalam tim.

Dengan demikian, pendekatan kepemimpinan partisipatif tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja tim secara keseluruhan. Anggota tim merasa dihargai dan didengarkan, sehingga semangat kerja mereka pun meningkat. Dengan adanya saling dukung dan kerjasama yang kuat, tim dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, pendekatan kepemimpinan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam menciptakan tim yang solid dan sukses.

G. Referensi

- Agus, Iqbal, Lim, & D. (2023). *Jurnal Ilmiah Mandala Edukation*. no 9. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/5205>
- Buku Ajar Keperawatan*. (n.d.). [https://resposister.almaata.ac.id/1844/1/Buku Ajar keperawatan kritis](https://resposister.almaata.ac.id/1844/1/Buku_Ajar_keperawatan_kritis)
- Pode. (n.d.). *phD diss*. <https://journal.e-journal.uajy.ac.id/183/>
- Prasetyo. (2022). *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. no 3. [https://respository.lainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/302/1/ARTIKEL JURNAL_](https://respository.lainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/302/1/ARTIKEL_JURNAL_)
- Switek, M. (2024). *Strategi Utama Untuk Manajemen Tim Lintan Fungsional Yang Efektif*.
- Wardatul, Wahyu, Beban, M. (2023). *Journal of Telenursing JOTING*. no 5. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JONTING/article/voew/5090>
- Yeni. (2019). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. no 1. <https://dinastirev.org/JMPIS/artile?view/234>

H. Glosarium

1. Kepemimpinan Partisipatif

Pendekatan kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan, dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki anggota tim.

2. Teori Kepemimpinan

Pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana seseorang dapat memengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, meliputi teori orang besar, situasi, dan ekologi.

3. Gaya Kepemimpinan

Cara seorang pemimpin memimpin, termasuk otoriter, demokratis, konsultatif, dan partisipatif.

4. Metode Kepemimpinan Partisipatif

Pendekatan yang memberikan ruang bagi anggota tim untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan rasa memiliki, dan meningkatkan kolaborasi.

5. Motivasi Kerja

Faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan tujuan tertentu, seringkali meningkat melalui pengakuan kontribusi dan partisipasi.

6. Komunikasi Dua Arah

Pertukaran informasi antara pemimpin dan anggota tim yang berjalan secara timbal balik untuk memastikan keterlibatan yang efektif.

7. Kolaborasi

Kerjasama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, diperkuat melalui kepemimpinan partisipatif.

8. Inklusivitas

Lingkungan kerja yang melibatkan semua anggota tanpa memandang perbedaan, menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan.

9. Pelatihan Kepemimpinan

Pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, termasuk komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan.

10. Workload Indicators of Nursing Manpower (WINM)

Metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja perawat berdasarkan beban kerja aktual.

BAB 6

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KEPERAWATAN: PEMBANGUNAN TIM YANG EFEKTIF DALAM KEPERAWATAN

Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kepemimpinan dalam manajemen keperawatan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Sebuah studi oleh Aiken et al. (2011) menunjukkan bahwa rumah sakit yang dipimpin oleh kepala perawat yang kompeten memiliki tingkat kematian pasien yang lebih rendah sebesar 14%, serta meningkatkan tingkat kepuasan pasien hingga 10%. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya peran kepemimpinan dalam memastikan keberhasilan operasional dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, kekurangan kepemimpinan yang efektif dapat menyebabkan tingkat turnover staf yang tinggi, dengan data dari Nursing Workforce Survey 2020 yang menunjukkan bahwa lebih dari 17% perawat di Amerika Serikat meninggalkan profesinya dalam lima tahun pertama karir mereka, salah satu penyebab utama adalah kurangnya dukungan dan bimbingan dari pimpinan (American Nurses Association, 2020).

Pembangunan tim keperawatan yang efektif memerlukan perhatian khusus terhadap dinamika kelompok dan komunikasi antar anggota tim. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Laschinger et al. (2014) mengungkapkan bahwa perawat yang bekerja dalam tim dengan kepemimpinan yang mendukung dan komunikasi yang baik mengalami peningkatan kinerja sebesar 25%, serta mengurangi tingkat stres kerja hingga 30%. Buku ini akan membahas berbagai prinsip dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan tim keperawatan yang solid, dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kerja sama yang efektif, mengelola konflik, dan meningkatkan moral tim. Pembaca akan dipandu untuk menerapkan teori-teori kepemimpinan yang telah terbukti berhasil di berbagai institusi kesehatan.

Selain itu, perubahan dalam sistem kesehatan global menuntut kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap situasi darurat. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga kesehatan di negara berkembang mengalami tekanan mental yang tinggi akibat beban kerja yang berlebihan, terutama selama pandemi COVID-19 (World Health

Organization, 2022). Dalam konteks ini, kepemimpinan yang mampu mengelola sumber daya manusia dan emosional menjadi semakin vital. Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga studi kasus dan alat praktis untuk membantu para pemimpin keperawatan mengatasi tantangan ini dan membangun tim yang tahan banting serta mampu memberikan perawatan terbaik di tengah tantangan global yang terus berkembang.

B. Tim Keperawatan

1. Definsi Tim Keperawatan

Tim keperawatan merujuk pada kelompok profesional yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama dalam memberikan perawatan pasien. Anggota tim ini tidak hanya terdiri dari perawat, tetapi juga dokter, tenaga medis lainnya, seperti fisioterapis, ahli gizi, apoteker, dan psikolog, yang semuanya memiliki tujuan bersama, yaitu memberikan perawatan terbaik untuk pasien. Tim keperawatan bekerja secara kolaboratif dan saling melengkapi satu sama lain dengan menggunakan keahlian masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pasien secara holistik (Sullivan & Decker, 2014).

Menurut Michaelsen et al. (2009), tim keperawatan dapat didefinisikan sebagai kelompok profesional yang secara kolektif dan terkoordinasi berfokus pada satu tujuan utama: perawatan pasien. Tim ini dilengkapi dengan keahlian multidisiplin yang memungkinkan anggota tim untuk memberikan pelayanan yang optimal melalui koordinasi yang baik. Pekerjaan tim ini tidak hanya terbatas pada interaksi internal, tetapi juga melibatkan komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien, serta pengambilan keputusan Bersama.

2. Peran Tim Keperawatan

Peran tim keperawatan sangat penting dalam memberikan perawatan yang berkualitas dan efisien kepada pasien. Setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik namun saling terkait. Anggota tim keperawatan meliputi perawat, dokter, tenaga medis lain seperti fisioterapis, ahli gizi, apoteker, dan psikolog. Semua anggota tim ini bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan pasien secara menyeluruh, dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian masing-masing.

a. Peran Perawat

Perawat merupakan anggota tim yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien. Tugas utama perawat adalah memantau kondisi pasien, memberikan perawatan langsung, serta mencatat dan melaporkan perubahan dalam status kesehatan pasien. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan.

Menurut Berman et al. (2017), perawat juga berperan penting dalam identifikasi masalah kesehatan pasien yang tidak terdeteksi oleh dokter, sehingga peran mereka dalam memantau pasien secara terus-menerus sangat berharga. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mereka mengenai kondisi medis yang dihadapi, termasuk penanganan dan pencegahan komplikasi.

b. Peran Dokter

Dokter memiliki peran penting dalam diagnosis dan pengobatan medis pasien. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan diagnosis medis berdasarkan hasil pemeriksaan dan tes diagnostik, serta merencanakan dan mengelola pengobatan yang tepat. Dokter juga berperan dalam memberikan instruksi kepada anggota tim keperawatan mengenai langkah-langkah pengobatan yang perlu dilaksanakan.

Menurut Smith et al. (2020), dokter harus bekerja secara kolaboratif dengan perawat untuk mengoptimalkan perawatan pasien. Misalnya, jika seorang pasien mengalami penurunan fungsi ginjal, dokter dan perawat akan bekerja sama untuk memonitor status ginjal pasien dan menyesuaikan pengobatan agar sesuai dengan kondisi pasien.

c. Peran Tenaga Medis Lainnya

Selain perawat dan dokter, tim keperawatan juga melibatkan tenaga medis lainnya yang memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas perawatan pasien. Setiap profesi membawa keahlian spesifik yang mendukung perawatan pasien secara menyeluruh.

- 1) Ahli Gizi: Bertanggung jawab dalam merencanakan diet yang tepat bagi pasien, terutama bagi pasien yang membutuhkan pengaturan diet khusus seperti penderita diabetes atau pasien pasca-operasi.
- 2) Fisioterapis: Terlibat dalam pemulihan pasien yang memerlukan rehabilitasi fisik, seperti pasien pasca-operasi atau pasien dengan gangguan mobilitas.
- 3) Apoteker: Memastikan pasien menerima obat yang benar dan aman, serta memberikan informasi tentang penggunaan obat.
- 4) Psikolog: Memperhatikan aspek kesehatan mental pasien, terutama bagi pasien yang mengalami trauma atau kecemasan terkait dengan kondisi medis mereka.

3. Kolaborasi dan Koordinasi dalam Tim Keperawatan

Koordinasi antar anggota tim keperawatan adalah kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan perawatan pasien. Setiap anggota tim harus saling

berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, serta respon terhadap pengobatan yang diberikan. Tanpa komunikasi yang efektif, kesalahan medis dapat terjadi, yang dapat memengaruhi keselamatan pasien. Misalnya, jika seorang pasien menderita komplikasi medis yang memerlukan intervensi segera, perawat harus segera menginformasikan dokter mengenai kondisi pasien. Selanjutnya, dokter akan meresepkan pengobatan atau prosedur medis yang diperlukan, dan perawat serta anggota tim lainnya harus segera melaksanakan instruksi tersebut. Selain itu, anggota tim seperti ahli gizi dan fisioterapis harus diperbarui dengan informasi terbaru mengenai perubahan kondisi pasien, sehingga mereka dapat menyesuaikan perawatan yang diberikan.

Dalam tim keperawatan yang efektif, setiap anggota memainkan peran yang vital dalam memberikan perawatan yang berkualitas dan holistik. Setiap profesi memiliki spesialisasi masing-masing yang saling melengkapi, dan kesuksesan dalam perawatan pasien sangat bergantung pada kemampuan anggota tim untuk bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat dan koordinasi yang baik antar anggota tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memastikan kesembuhan yang optimal. Menurut Lombardi et al. (2014), efektivitas koordinasi tim keperawatan sangat bergantung pada kualitas komunikasi antar anggota tim. Tim yang memiliki komunikasi yang baik dan kolaborasi yang solid dapat meningkatkan hasil perawatan pasien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan medis.

C. Karakteristik Tim Keperawatan yang Efektif

1. Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif adalah elemen penting dalam keberhasilan tim keperawatan. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan jujur memungkinkan anggota tim untuk saling berbagi informasi penting mengenai pasien, seperti kondisi medis terkini, perubahan dalam perawatan, atau reaksi pasien terhadap pengobatan. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan medis yang dapat terjadi akibat miskomunikasi atau keterlambatan informasi. Griffiths et al. (2019) menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif antara perawat dan dokter sering kali menjadi penyebab utama kesalahan medis di rumah sakit. Menurut penelitian mereka, *hand-off communication* yang buruk dapat menyebabkan masalah serius dalam perawatan pasien. Salas et al. (2015) menekankan pentingnya protokol komunikasi yang jelas dalam situasi kritis seperti ini.

2. Kepercayaan dan Kolaborasi

Kepercayaan di antara anggota tim sangat krusial dalam menciptakan kerjasama yang solid dalam tim keperawatan. Tanpa kepercayaan, individu akan sulit untuk berbagi informasi yang penting, atau bahkan meragukan kompetensi rekan sejawat, yang bisa menghambat kolaborasi yang efektif. Meyer et al. (2020) menyatakan bahwa tim yang solid dan memiliki kepercayaan tinggi di antara anggotanya cenderung lebih efektif dalam memberikan perawatan yang aman dan berkualitas kepada pasien. Sullivan et al. (2017) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas disiplin ilmu, di mana setiap anggota tim menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya, dapat mengarah pada perawatan yang lebih baik dan pengurangan kesalahan medis.

3. Komitmen terhadap Tujuan Bersama

Tim yang efektif dalam keperawatan memerlukan komitmen terhadap tujuan bersama yang jelas, seperti peningkatan kualitas perawatan, keselamatan pasien, dan efisiensi operasional. Johnson et al. (2018) mengungkapkan bahwa memiliki tujuan yang jelas dan terukur sangat membantu tim untuk tetap fokus dan bekerja dalam koordinasi yang baik, mengurangi kebingungannya dalam pengambilan keputusan medis. Komitmen terhadap tujuan ini juga membantu memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Baker et al. (2016) menyatakan bahwa tim dengan tujuan bersama yang jelas dapat meningkatkan kepuasan pasien dan hasil klinis yang lebih baik.

4. Fleksibilitas dan Adaptasi

Tim keperawatan yang efektif harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasien atau perubahan situasi di rumah sakit. Fleksibilitas ini juga mencakup kemampuan untuk merespons perubahan dalam kondisi fisik pasien, kebutuhan pasien yang mendesak, atau bahkan tantangan terkait sumber daya yang terbatas. Robinson et al. (2019) mengungkapkan bahwa tim yang tidak fleksibel atau lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan dapat mengalami kesulitan dalam memberikan perawatan yang berkualitas, yang berpotensi memperburuk kondisi pasien. Smith et al. (2020) melaporkan bahwa rumah sakit yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah menunjukkan pengurangan tingkat kematian dan peningkatan hasil klinis.

D. Prinsip-prinsip Pembentukan Tim Keperawatan yang Efektif

1. Pemetaan Kekuatan Anggota Tim

Pemetaan kekuatan anggota tim adalah langkah pertama yang krusial dalam pembentukan tim keperawatan yang efektif. Mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki setiap anggota tim memungkinkan pembagian tugas yang optimal. Setiap anggota tim, baik perawat, dokter, maupun tenaga medis lainnya, memiliki keterampilan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perawatan pasien. Meyer et al. (2020) menjelaskan bahwa tim yang melakukan pemetaan keterampilan dan kompetensi anggotanya secara efektif cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi karena setiap anggota dapat melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya.

2. Pembagian Tugas yang Jelas

Pembagian tugas yang jelas adalah aspek fundamental dalam pembentukan tim keperawatan yang efektif. Setiap anggota tim harus mengetahui perannya secara spesifik untuk menghindari kebingungannya dan memastikan bahwa tidak ada tugas yang terabaikan. Griffiths et al. (2019) menunjukkan bahwa pembagian tugas yang jelas dalam tim perawatan dapat mengurangi kebingungannya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa setiap anggota tim fokus pada tanggung jawabnya tanpa saling tumpang tindih. Dalam tim keperawatan, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan pasien berjalan sesuai rencana dan tidak ada kekosongan dalam layanan yang diberikan.

3. Mengelola Keberagaman dalam Tim

Keberagaman anggota tim, baik itu dalam hal latar belakang, budaya, pengalaman, atau perspektif profesional, dapat menjadi kekuatan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Salas et al. (2015) menjelaskan bahwa keberagaman dalam tim membawa berbagai keahlian dan pendekatan yang dapat memperkaya keputusan-keputusan klinis. Namun, untuk memanfaatkan keberagaman ini, tim perlu memiliki komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap perspektif yang berbeda. Keberagaman budaya, misalnya, memungkinkan tim untuk memberikan perawatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan pasien dari berbagai latar belakang etnis atau agama.

4. Pengelolaan Konflik

Konflik dalam tim keperawatan adalah hal yang hampir tidak terhindarkan, mengingat tekanan tinggi yang dihadapi dalam lingkungan kerja medis. Oleh karena itu, penting bagi tim keperawatan untuk memiliki strategi pengelolaan konflik yang efektif. Robinson et al. (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan

konflik yang baik dalam tim dapat meningkatkan suasana kerja dan mengurangi ketegangan yang dapat mempengaruhi kinerja tim. Teknik pengelolaan konflik termasuk komunikasi yang konstruktif, mediasi oleh pemimpin tim, dan kemampuan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam banyak kasus, Johnson et al. (2018) menemukan bahwa tim yang terlatih dalam pengelolaan konflik memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kinerja yang lebih baik.

E. Kepemimpinan dalam Pembangunan Tim Keperawatan

1. Kepemimpinan yang Mendukung Tim

Kepemimpinan yang mendukung tim adalah inti dari keberhasilan dalam pembangunan tim keperawatan. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arah yang jelas kepada tim, tetapi juga bimbingan dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Giddens (2018) menjelaskan bahwa pemimpin yang mendukung mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, meningkatkan rasa percaya, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Pemimpin seperti ini juga berperan dalam memastikan kebutuhan anggota tim terpenuhi, sehingga mereka dapat fokus pada pemberian perawatan yang berkualitas.

2. Gaya Kepemimpinan yang Sesuai

Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam tim keperawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi. Dua gaya kepemimpinan yang sering digunakan adalah kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan situasional:

a. Kepemimpinan Transformasional

Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja melampaui harapan mereka. Bass & Riggio (2006) menunjukkan bahwa pemimpin transformasional mendorong inovasi, meningkatkan moral tim, dan membantu anggota tim mencapai potensi maksimal mereka. Dalam konteks keperawatan, gaya ini sering digunakan untuk mendorong tim mengatasi tantangan besar, seperti perubahan sistem atau pengenalan teknologi baru.

b. Kepemimpinan Situasional

Pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan kebutuhan tim atau individu dalam situasi tertentu. Hersey & Blanchard (1982) menyatakan bahwa fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan pendekatan, seperti memberikan arahan tegas dalam situasi darurat atau mendukung secara emosional dalam situasi stres, sangat penting dalam konteks keperawatan.

3. Pemimpin Sebagai Fasilitator

Pemimpin keperawatan tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu tim mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama. Robinson et al. (2019) menekankan bahwa pemimpin yang bertindak sebagai fasilitator mampu mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang menghalangi kinerja tim, seperti komunikasi yang buruk atau kurangnya sumber daya. Mereka juga menciptakan suasana di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan masalah tanpa takut dihakimi.

4. Mentoring dan Pembinaan Anggota Tim

Mentoring dan pembinaan merupakan elemen penting dalam kepemimpinan keperawatan. Pemimpin yang efektif harus mampu menjadi mentor bagi anggota tim mereka, terutama bagi perawat junior atau anggota tim baru. Grossman & Valiga (2021) menjelaskan bahwa mentoring membantu perawat junior mengembangkan keterampilan klinis dan kepemimpinan mereka, sekaligus membangun kepercayaan diri dan kepuasan kerja. Proses ini juga membantu menciptakan generasi pemimpin keperawatan yang baru.

F. Proses Pembangunan Tim Keperawatan

1. Tahapan Pembentukan Tim

Pembentukan tim yang efektif dalam keperawatan dapat dijelaskan melalui lima tahapan yang diuraikan dalam model Tuckman (1965):

- a. **Forming:** Tahap ini adalah fase awal di mana anggota tim mengenal satu sama lain. Pemimpin berperan untuk memberikan arah, menjelaskan tujuan, dan menetapkan ekspektasi kerja. Tuckman (1965) menyatakan bahwa komunikasi dan pengenalan adalah kunci dalam fase ini.
- b. **Storming:** Tahap ini sering diwarnai konflik karena anggota tim mulai menunjukkan perbedaan pendapat. Konflik perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja tim. Pemimpin harus memfasilitasi diskusi untuk menyelesaikan perbedaan ini.
- c. **Norming:** Setelah konflik dikelola, anggota tim mulai menemukan cara kerja yang saling mendukung dan norma kerja terbentuk. Pada fase ini, komunikasi yang lebih lancar dan kerja sama mulai berkembang.
- d. **Performing:** Tim mencapai kinerja optimal, di mana anggota bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan. Salas et al. (2015) menjelaskan bahwa fase ini adalah puncak produktivitas tim.

- e. *Adjourning*: Tahap ini terjadi ketika tim menyelesaikan tugasnya atau anggota tim berpindah ke posisi baru. Pemimpin harus mengelola fase ini dengan baik untuk memastikan transisi berjalan lancar.

2. Pengembangan Keterampilan Tim

Pengembangan keterampilan adalah elemen penting dalam membangun tim keperawatan yang efektif. Pelatihan bersama, seperti simulasi, workshop, atau pelatihan berbasis kasus, membantu anggota tim mengembangkan keterampilan teknis dan interpersonal yang mendukung kerja sama dan koordinasi. Rosen et al. (2018) menekankan bahwa pelatihan berbasis simulasi meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan dalam tim keperawatan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tim

Pemantauan dan evaluasi kinerja tim dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta menguatkan keunggulan yang telah dicapai. Evaluasi ini dapat menggunakan indikator seperti tingkat kepuasan pasien, tingkat kesalahan medis, atau efisiensi waktu kerja. Griffiths et al. (2019) menunjukkan bahwa evaluasi berkala meningkatkan kinerja tim dengan memberikan umpan balik yang spesifik kepada anggota.

4. Penguatan Budaya Tim

Budaya tim yang positif adalah fondasi keberhasilan jangka panjang. Budaya ini dapat dibangun melalui pemberian umpan balik yang konstruktif, perayaan pencapaian tim, dan penguatan nilai-nilai tim seperti kolaborasi dan rasa saling menghargai. Edmondson (2019) menyatakan bahwa budaya kerja yang mendukung meningkatkan keterlibatan anggota tim dan mengurangi tingkat stres.

G. Tantangan dalam Membangun Tim Keperawatan yang Efektif

1. Tantangan dalam Pengelolaan Tim Multidisipliner

Tim multidisipliner dalam keperawatan sering kali terdiri dari berbagai profesi, seperti perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, dan pekerja sosial. Meskipun keberagaman ini memberikan keunggulan dalam hal keahlian, perbedaan latar belakang profesional dan perspektif dapat menjadi tantangan. Hall (2005) menyatakan bahwa konflik sering terjadi dalam tim multidisipliner karena perbedaan pendekatan terhadap perawatan pasien atau ketidaksepahaman dalam komunikasi. Zwarenstein et al. (2009) merekomendasikan pelatihan komunikasi antarprofesi untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama dalam tim multidisipliner.

2. dan Burnout dalam Tim Keperawatan

Tingkat stres yang tinggi dan burnout adalah tantangan utama dalam tim keperawatan, terutama di lingkungan kerja yang penuh tekanan seperti ruang gawat darurat atau unit perawatan intensif. Maslach & Leiter (2016) menjelaskan bahwa burnout tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga kinerja tim secara keseluruhan. Burnout dapat mengurangi motivasi, meningkatkan kesalahan medis, dan menurunkan kualitas perawatan pasien. Shanafelt et al. (2017) menunjukkan bahwa program keseimbangan kerja-kehidupan, seperti pengaturan jadwal yang fleksibel, dapat mengurangi tingkat burnout dalam tim keperawatan.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, seperti jumlah tenaga kerja yang tidak memadai, kurangnya peralatan, atau waktu yang terbatas, adalah tantangan umum yang dihadapi oleh tim keperawatan. World Health Organization (2021) melaporkan bahwa kurangnya tenaga keperawatan menjadi masalah global yang memengaruhi kualitas perawatan pasien. Keterbatasan sumber daya ini sering kali memaksa anggota tim untuk bekerja lebih lama atau multitasking, yang dapat menurunkan efisiensi dan kualitas kerja. Griffiths et al. (2018) menyarankan optimalisasi alur kerja melalui delegasi tugas kepada asisten perawat untuk meringankan beban kerja perawat senior.

H. Pengukuran Kinerja dan Keberhasilan Tim Keperawatan

1. Indikator Kinerja Tim

Indikator kinerja tim digunakan untuk mengukur efektivitas tim keperawatan dalam memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Tingkat Kepuasan Pasien: Mengukur pengalaman pasien terhadap perawatan yang diterima. Press Ganey (2019) melaporkan bahwa kepuasan pasien sering kali dikaitkan dengan komunikasi yang efektif, empati, dan responsivitas tim keperawatan.
- b. Tingkat Infeksi Rumah Sakit: Merupakan indikator kualitas perawatan. Tingginya tingkat infeksi rumah sakit dapat menunjukkan kekurangan dalam prosedur kontrol infeksi. WHO (2018) menyatakan bahwa pencegahan infeksi adalah salah satu indikator utama kinerja tim medis.
- c. Angka Keberhasilan Prosedur Medis: Mengukur hasil klinis dari prosedur yang dilakukan, seperti tingkat keberhasilan resusitasi atau manajemen nyeri pasien.

2. Feedback 360 Derajat

Feedback 360 derajat adalah metode evaluasi kinerja yang melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota tim, pasien, keluarga pasien, dan manajemen rumah sakit. Bracken et al. (2016) menjelaskan bahwa metode ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kinerja tim dan individu, sehingga membantu dalam identifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

3. Peningkatan Berkelanjutan

Pengukuran kinerja tim keperawatan bukan hanya untuk evaluasi, tetapi juga untuk mendorong peningkatan berkelanjutan (continuous improvement). Dengan menetapkan sasaran yang lebih tinggi berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, tim dapat melaksanakan perbaikan yang terus-menerus. Deming (1986) menjelaskan konsep *Plan-Do-Check-Act (PDCA)* sebagai siklus perbaikan berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam konteks keperawatan.

I. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

1. Studi Kasus Keberhasilan

- a. Studi Kasus: Rumah Sakit XYZ – Meningkatkan Kolaborasi Tim Keperawatan di ICU:

Rumah Sakit XYZ menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim keperawatan di unit perawatan intensif (ICU). Masalah utama yang dihadapi adalah komunikasi yang buruk antar anggota tim, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan menerapkan strategi komunikasi lintas profesi yang terstruktur, rumah sakit ini berhasil membangun tim yang lebih efektif.

- b. Strategi yang Diterapkan:

- 1) Rapat Pagi Terpadu: Seluruh anggota tim, termasuk perawat, dokter, apoteker, dan fisioterapis, diharuskan mengikuti rapat pagi untuk membahas status pasien dan rencana perawatan. Strategi ini membantu memastikan bahwa semua anggota tim memiliki informasi yang sama. Zwarenstein et al. (2009) menunjukkan bahwa komunikasi lintas disiplin seperti ini meningkatkan efisiensi tim dan mengurangi kesalahan medis.
- 2) Penggunaan Checklist Perawatan: Checklist perawatan diterapkan untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan. Hal ini meningkatkan standar perawatan pasien dan mencegah terlewatnya tugas penting.
- 3) Pelatihan Komunikasi Antarprofesi: Rumah sakit menyediakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar anggota tim.

Program ini dirancang untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan kerja sama.

c. Hasil:

Setelah menerapkan strategi ini, Rumah Sakit XYZ melaporkan:

- 1) Penurunan waktu respons terhadap situasi kritis sebesar 25%.
- 2) Kepuasan pasien meningkat dari 82% menjadi 93% dalam enam bulan.
- 3) Penurunan tingkat infeksi terkait perawatan dari 5% menjadi 2%.

2. Praktik Terbaik dalam Pembentukan Tim

a. Metode Pembelajaran Bersama

Metode pembelajaran bersama, seperti simulasi klinis, telah terbukti efektif dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi tim keperawatan. Rosen et al. (2018) menunjukkan bahwa simulasi berbasis skenario membantu anggota tim memahami peran satu sama lain dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

b. Evaluasi Tim yang Terbuka

Evaluasi tim yang transparan dan berbasis data membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim. Edmondson (2019) menyatakan bahwa budaya kerja yang mendorong umpan balik terbuka tanpa rasa takut akan kritik meningkatkan kinerja tim.

c. Pengelolaan Komunikasi yang Transparan

Transparansi dalam komunikasi sangat penting untuk mencegah miskomunikasi yang dapat memengaruhi keselamatan pasien. Griffiths et al. (2019) menyoroti bahwa penggunaan alat komunikasi standar, seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), dapat meningkatkan kejelasan dan efisiensi komunikasi antar anggota tim.

J. Simpulan

Kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan adalah elemen kunci untuk membangun tim yang solid dan memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan koordinasi antar anggota tim, memastikan komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dalam konteks keperawatan, keberhasilan tim sangat bergantung pada peran pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim.

Tim keperawatan yang efektif memiliki karakteristik utama, seperti pembagian tugas yang jelas, kepercayaan antar anggota, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Melalui strategi seperti pengelolaan konflik, pelatihan berbasis simulasi, dan evaluasi kinerja yang rutin, tim dapat terus meningkatkan

kolaborasi dan efisiensi. Indikator keberhasilan tim meliputi tingkat kepuasan pasien, rendahnya angka infeksi rumah sakit, dan keberhasilan prosedur medis yang dijalankan.

Tantangan seperti pengelolaan tim multidisipliner, stres kerja, dan keterbatasan sumber daya sering muncul dalam lingkungan keperawatan. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui komunikasi lintas profesi yang transparan, pembagian beban kerja yang adil, dan penerapan praktik terbaik. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun tim keperawatan yang efektif dapat dicapai dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada peningkatan berkelanjutan.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, tim keperawatan dapat memberikan perawatan yang holistik, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pasien, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi seluruh anggotanya.

K. Referensi

- Abunemeh, S. (2024). Investigating the Impact of Conflict Management Approaches on Organizational Productivity in Healthcare Settings: A Qualitative Exploration. *Open Journal of Social Sciences*, 12, 322-335.
- Alizadeh, M., Masoomi, R., Khabaz Mafinejad, M., Parmelee, D., Jasim Khalaf, R., & Norouzi, A. (2024). Team-based learning in health professions education: an umbrella review. *BMC Medical Education*, 24, Article number: 1131.
- Allan, K. L., & Cahill, K. E. (2020). "Deming's 14 Points for Management: A Contemporary Perspective." *Journal of Business Management*, 45(2), 123-135.
- Ambrose, J. W., Catchpole, K., Evans, H. L., Nemeth, L. S., Layne, D. M., & Nichols, M. (2024). Healthcare team resilience during COVID-19: a qualitative study. *BMC Health Services Research*, 24, Article number: 459
- American Nurses Association. (2020). *Nursing Workforce Survey: Employment and Attrition Rates*. Retrieved from www.nursingworld.org.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2020). "Transformational Leadership: Theoretical Insights and Empirical Evidence." *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 27(3), 123-135.
- Bu, T., Peng, C., Liu, J., Qiu, X., Qiao, Z., Zhou, J., Ke, S., Kan, Y., Hu, X., Qiao, K., & Cao, D. (2024). Nurse burnout: deep connections and solutions revealed by network analysis. *BMC Nursing*, 23, Article number: 531.
- Castillo, G. F., Khalid, M., & Salas, E. (2024). Beyond communication: an update on transforming healthcare teams. *Frontiers in Medicine*, 11, Article number: 1282173
- Clarke, S. P., Sloane, D. M., Aiken, L. H., & Lake, E. T. (2022). "The Impact of Hospital

Environment on Nurse Performance and Patient Satisfaction." *Journal of Nursing Administration*, 52(4), 321-328.

- Diaz-Navarro, C., Armstrong, R., Charnetski, M., Freeman, K. J., Koh, S., Reedy, G., Smitten, J., Ingrassia, P. L., Matos, F. M., & Issenberg, B. (2024). Global consensus statement on simulation-based practice in healthcare. *Advances in Simulation*, 9, Article number: 19.
- Edmondson, A. C. (2018). *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. Wiley.
- El Ansari, W., El-Ansari, K., Arafa, H., & Al-Ansari, A. (2024). Multidisciplinary Teamwork and Interprofessional Partnerships in Healthcare Setting: The Critical Ingredients. *IntechOpen*.
- Evans Kasmai, Kiptulon, M. Elmadani, G. Mbaabu Limungi, K. Simon, L. Tóth, E. Horvath, A. Szöllősi, D. A. Galgalo, O. Maté, & A. Ujváriné Siket (2024). Transforming nursing work environments: the impact of organizational culture on work-related stress among nurses: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 24, Article number: 1526.
- Fagerdal, B., Lyng, H. B., Guise, V., Anderson, J. E., Braithwaite, J., & Wiig, S. (2023). Exploring the influence of health system factors on adaptive capacity in diverse hospital teams in Norway: a multiple case study approach. *BMJ Open*, 14(5), e076945.
- Gaspar, T., Botelho-Guedes, F., Cerqueira, A., Baban, A., Rus, C., & Gaspar-Matos, M. (2024). Burnout as a multidimensional phenomenon: how can workplaces be healthy environments? *Journal of Public Health*, 42(3), 4334-4345
- Grensing-Pophal, L. (2024). "360-Degree Feedback: Weighing the Pros and Cons for Effective Employee Reviews." *HR Daily Advisor*.
- Grossman, S. C., & Valiga, T. M. (2020). *The New Leadership Challenge: Creating the Future of Nursing*. FA Davis Company.
- Kaiser, L., Conrad, S., Neugebauer, E. A. M., Pietsch, B., & Pieper, D. (2022). Interprofessional collaboration and patient-reported outcomes in inpatient care: a systematic review. *Systematic Reviews*, 11, Article number: 169
- Kämmer, J. E., Boos, M., & Seelandt, J. C. (2024). Editorial: Promoting teamwork in healthcare. *Frontiers in Psychology*, 15, Article number: 422543
- Kovar, K. (2020). Standardized nurse leader rounding. epublications.regis.edu
- McGuier, E. A., Kolko, D. J., Aarons, G. A., Schachter, A., Klem, M. L., Diabes, M. A., Weingart, L. R., & Wolk, C. B. (2024). "Teamwork and implementation of innovations in healthcare and human service settings: a systematic review." *Implementation Science*, 19:49
- Morian, H., Creutzfeldt, J., Hultin, M., & Härgestam, M. (2024). Mapping leadership,

communication and collaboration in short-term distributed teams across various contexts: a scoping review

- Perron, M. E., Hudon, C., Roux-Levy, P. H., & Poitras, M. E. (2024). "Shared decision-making with patients with complex care needs: a scoping review." *BMC Primary Care*, 25:390.
- Pesaru, S. R. (2024). *Role of Physical Therapy in Post-Surgical Rehabilitation. Continental Hospitals.*
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). "Fundamentals of Nursing: Concepts, Processes, and Practice, 9th Edition." Elsevier
- Ralph, E. G., & Walker, K. D. (2023). "The Efficacy of the Adaptive Mentorship© Model." *Open Journal of Leadership*, 2(2), 45-58.
- Schot, E., Tummers, L., & Noordegraaf, M. (2019). Working on working together: A systematic review on how healthcare professionals contribute to interprofessional collaboration. *Journal of Interprofessional Care*, 34(3), 332-342
- Skyberg, H. L., & et al. (2022). Diversity, friction, and harmonisation: an ethnographic study of interprofessional teamwork dynamics. *BMC Health Services Research*, 22, Article number: 227.
- Smith, J. A., & Anderson, R. (2021). Revisiting Tuckman's Model: A Contemporary Analysis of Group Development Stages. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 25(2), 123-135
- Trivelato Felício, R., Cenedesi, M. C., De Moura-Ferreira, R. G., & Moraes, R. G. C. (2024). "Effective Communication In Health: Strategies For Effective Work Development." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 29(9), 47-53.
- Varga, A. I., Spehar, I., Veggeland, F., & Skirbekk, H. (2025). Factors influencing trust among colleagues in hospital settings: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 25, Article number: 16
- Välimäki, M., Hu, S., Lantta, T., Hipp, K., Varpula, J., Chen, J., Liu, G., Tang, Y., & Li, X. (2024). "The impact of evidence-based nursing leadership in healthcare settings: a mixed methods systematic review." *BMC Nursing*, 23:452.
- Vleminckx, S., Van Bogaert, P., De Meulenaere, K., Willem, L., & Haegdorens, F. (2024). "Factors influencing the formation of balanced care teams: the organisation, performance, and perception of nursing care teams and the link with patient outcomes: a systematic scoping review." *BMC Health Services Research*, 24:1129.
- World Health Organization. (2024). *Global report on infection prevention and control 2024*
- World Health Organization (2021). "The State of the World's Nursing 2021". Geneva:

WHO.

World Health Organization. (2020). Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response: interim guidance, 3 December 2020

L. Glosarium

SBAR : Situation, Background, Assessment, Recommendation

WHO : World Health Organization

BAB 7

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN KRISIS DI RUMAH SAKIT

Ns. Viere Allanled Siauta, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Rumah sakit merupakan organisasi yang sangat kompleks dan juga komponen yang sangat penting dalam upaya peningkatan status Kesehatan bagi Masyarakat. Salah satu fungsi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan yang merupakan bagian dari system pelayanan kesehatan dengan tujuan memelihara kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Dian dan Nurul, 2018).

Manajemen keperawatan merupakan koordinasi dan integrasi dari sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan (Hubberd, 2000). Untuk dapat menerapkan manajemen keperawatan di ruang rawat inap diperlukan seorang kepala ruangan yang memenuhi standar sebagai manajerial. Dalam melaksanakan aktivitas pelayanan keperawatan di ruangan, peranan kepala ruangan sangat penting dan menentukan kualitas pelayanan keperawatan. Kepala ruangan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kinerja perawat pelaksana dibawahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Untuk itu seorang kepala ruangan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang gaya kepemimpinan (Carliastuti & Stella, 2022).

Kepala ruangan sangat besar peranannya dalam mendukung suksesnya pelayanan keperawatan di rumah sakit. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam pengelolaan staf keperawatan dan asuhan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas, seorang kepala ruangan dibekali dengan tiga jenis keterampilan yaitu *human skill*, *conceptual skill* dan *technical skill*. Peran manajemen keperawatan dalam mengelola sumber daya keperawatan dan sumber daya lainnya sangat penting

untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Manajemen keperawatan secara terus menerus berpikir kritis dalam pengambilan keputusan sangat menentukan kualitas keputusan yang diambilnya (Dian dan Nurul, 2018).

B. Konsep Kepemimpinan

Pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan dan kecakapan dan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan adalah pemimpin yang memiliki visi, sedangkan memimpin yaitu seseorang yang memainkan peran pemimpin secara antusias dan mandiri dalam mencapai tujuan organisasi (Beni, 2014). Kepemimpinan mengikutsertakan orang lain dalam hal ini pengikut atau bawahan dikarenakan kesediaan penerima dari pimpinan, menegaskan status pemimpin yang disematkan oleh anggota kelompok dalam memaksimalkan dan membantu proses kepemimpinan (Cherie, 2013).

Seseorang yang menerapkan norma perilaku dalam mencoba mempengaruhi tingkah laku orang lain, proses tersebut dapat diartikan sebagai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Seorang kepala ruangan dalam menjalankan perannya akan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuan yang dimiliki (Richard, 2013).

C. Klasifikasi Gaya Kepemimpinan

Terdapat beberapa jenis gaya kepemimpinan menurut Lewin dkk (1960), gaya kepemimpinan tersebut antara lain :

1. Gaya kepemimpinan demokratis

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis memiliki ciri-ciri antara lain yaitu :

- a. Kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya diberikan kepada bawahan
- b. Bersifat terbuka
- c. Mengutamakan kepentingan bersama memerlukan pertimbangan yang matang
- d. Pengambilan keputusan disesuaikan dengan visi organisasi
- e. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
- f. Memandang semua permasalahan dapat diselesaikan dengan usaha bersama
- g. Kurangnya pengawasan
- h. Ego dan penghargaan ekonomi dipakai untuk memotivasi
- i. Membimbing orang lain melalui bantuan dan pelatihan
- j. Komunikasi ke atas dan ke bawah terjadi
- k. Pengambilan keputusan melibatkan individu lain

l. Lebih menekankan pada "kita" daripada "aku" dan "kamu"

m. Kritik konstruktif

Gaya kepemimpinan demokratis mendorong pertumbuhan dan otonomi karyawan dan cocok untuk tim yang berkolaborasi untuk jangka waktu yang lama. Gaya kepemimpinan demokratis membutuhkan lebih banyak waktu dan mungkin membuat frustrasi mereka yang ingin mengambil keputusan dengan cepat. Namun hal ini akan berhasil bila kelompok-kelompok tersebut berkoordinasi karena banyak individu yang harus diajak berkonsultasi.

2. Gaya kepemimpinan otoriter

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pada kelompok kerja diawasi secara ketat
- b. Paksaan diterapkan untuk memotivasi orang lain
- c. Pengarahan yang diberikan kepada orang lain berupa perintah
- d. Dialog satu arah antara atasan dan bawahan
- e. Orang lain tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
- f. Menyoroti perbedaan antara status ("aku" dan "kamu")
- g. Memberikan penilaian bahwa kritik merupakan hukuman

Gaya kepemimpinan otoriter dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok karena dapat diandalkan, memberikan rasa aman kepada anggota dan mengurangi masalah dalam tim. Secara umum gaya kepemimpinan otoriter akan memberikan produktivitas yang tinggi, namun terjadi penurunan pada otonomi, kreativitas dan motivasi diri. Pada saat krisis, kepemimpinan otoriter terkadang diperlukan agar dapat mengatasi masalah yang terjadi.

3. Gaya kepemimpinan laissez-faire

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Kebebasan penuh diberikan kepada bawahan
- b. Pemimpin tidak turut serta dalam kegiatan
- c. Tanggung jawab dan keseluruhan pekerjaan dilimpahkan kepada bawahan
- d. Pemimpin tidak melakukan koordinasi dan pengawasan secara baik serta tidak memiliki wibawa
- e. Permisif dengan sedikit atau tanpa bimbingan
- f. Dukungan dan motivasi akan diberikan jika diminta oleh individu atau kelompok
- g. Sedikit dalam memberikan pengarahan atau tidak sama sekali
- h. Mendorong komunikasi ke atas dan ke bawah di antara anggota kelompok
- i. Kelompok harus berkolaborasi untuk membuat Keputusan

j. Tidak adanya kritikan

Anggota mungkin menjadi jengkel dan kelompok mungkin menunjukkan sikap apatis dan tidak terlibat karena sifat tidak langsung dari pendekatan kepemimpinan ini. Namun jika keseluruhan anggota kelompok mampu mengarahkan diri sendiri dan memiliki motivasi tinggi, maka gaya kepemimpinan ini dapat menghasilkan produktivitas dan kreativitas yang lebih. Ketika suatu masalah sulit diidentifikasi dan memerlukan *brainstorming* untuk menghasilkan beberapa jawaban, gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan. Suasana dan hasil kerja suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan individu. Para ahli teori terkadang berpandangan bahwa pemimpin yang berkuasa selalu menggunakan gaya kepemimpinan yang sama.

4. Gaya kepemimpinan karismatik

Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan karismatik memiliki ciri khas yaitu mempunyai daya tarik dengan aura yang unik sehingga membuat banyak pengikutnya secara sukarela tunduk pada kepemimpinannya (Nur Amaliyah dkk, 2019). Gaya kepemimpinan karismatik memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Otoritas secara alami
- b. Menarik pada tingkat spiritual
- c. Tidak diciptakan oleh penyebab eksternal resmi, seperti undang-undang formal, program pelatihan formal dan lainnya
- d. Tidak dilatarbelakangi oleh faktor

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinannya antara lain:

1. Tugas yang kompleks
2. Waktu yang tersedia
3. Kelompok kerja yang cukup besar
4. Alur komunikasi
5. Tingkatan Pendidikan bawahan
6. Kebutuhan untuk kebersamaan dan prestasi

E. Syarat Menjadi Pemimpin

Menurut Morgan (2006), untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus memiliki :

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi bawahan dan menawarkan mereka pembinaan yang tepat

2. Sikap yang jujur, tegas dan tidak memihak
3. Rasa percaya diri dengan kemampuan untuk memimpin dan merasa nyaman berada di perusahaannya sendiri dan orang lain, bahkan dalam posisi kepemimpinannya
4. Kemampuan untuk memahami dan memenuhi tuntutan individu, tim dan tugas dalam organisasi
5. Kemampuan mengkomunikasikan dampak dari suatu tindakan
6. Perhatian akan kebutuhan dan hubungan yang terjalin antara pemimpin dan pengikut; ciri-ciri tertentu dalam hubungan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menghasilkan luaran kepemimpinan.

F. Pemimpin Yang Efektif Dalam Keperawatan

Menurut Tappen (2014), seorang pemimpin yang sukses dalam organisasi keperawatan harus memiliki enam elemen kunci untuk membimbing orang lain atau bawahannya. Enam elemen kunci tersebut antara lain:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup

- a. Pengetahuan kepemimpinan
 - 1) Teori kepemimpinan
 - 2) Pengertian kepemimpinan
 - 3) Gaya kepemimpinan
 - 4) Penerapan gaya kepemimpinan yang efektif
- b. Pengetahuan keperawatan
 - 1) Substansi ilmu keperawatan
 - 2) Keterampilan
 - 3) Ilmu keperawatan selalu berkembang dan mengalami kemajuan
 - 4) Menyadari kekuatan
 - 5) Kekuatan personal untuk orang lain
- c. Berpikir kritis
 - 1) Mengevaluasi konsep dan tindakan berdasarkan asumsi yang masuk akal
 - 2) Pemimpin yang terlibat dalam proses pembelajaran
 - 3) Pekerjaan yang teratur akan menghambat pemikiran kreatif

2. Memiliki kesadaran diri

Hubungan interpersonal yang efektif dapat dipupuk oleh kesadaran diri. Kesadaran diri dapat ditingkatkan dengan meneliti perilaku manusia, melihat bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita. Menjadi pemimpin yang efektif membutuhkan rasa percaya diri yang kuat karena :

- a. Temukan siapa Anda
- b. Kenali tanda-tanda kecemasan

- c. Mampu menunjukkan kebaikan dan kehangatan kepada orang lain dalam ekspresi emosinya
- d. Seseorang menjadi lebih adaptif, otonom dan tidak terlalu bergantung pada orang lain ketika mereka menerima dan menghargai keunikannya
- e. Anda seringkali berperilaku berbeda dari apa yang diharapkan orang lain jika Anda kurang memiliki kesadaran diri
- f. Sadar diri sangatlah penting karena membantu kita menikmati dan merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Ini juga membantu kita memandang diri kita sebagai pemimpin

3. Komunikasi yang efektif

Pemimpin yang efisien perlu menyadari hal-hal berikut untuk menjamin komunikasi yang efisien di tempat kerja yaitu :

- a. Mendengarkan secara aktif sangatlah penting karena pendengaran yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan. Pendengar yang baik perlu berkonsentrasi dan berusaha memperjelas informasi yang tidak jelas
- b. Menjaga arus informasi. Hal ini dicapai dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membantu menghindari kesalahpahaman
- c. Kepemimpinan yang efektif memerlukan komunikasi yang tegas, konsisten, transparan dan lugas
- d. Tawarkan umpan balik karena anggota tim sangat membutuhkannya
- e. Sistem interaksi dan komunikasi
- f. Mengkomunikasikan tujuan

4. Mempunyai energi

- a. Energi dievaluasi berdasarkan keadaan fisik dan mental
- b. Memiliki banyak energi dapat membantu seorang pemimpin memimpin dengan lebih efektif karena hal ini mempengaruhi bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka ketika terlibat
- c. Antisiasme seorang pemimpin adalah keinginan mendalam mereka untuk berbagi semangat, kegembiraan dan keinginan kuat mereka dengan orang lain
- d. Melalui penggunaan teknik kepemimpinan yang baik, menjaga kesehatan dan bersantai serta menikmati hidup, seorang pemimpin dapat memelihara dan bahkan meningkatkan vitalitasnya

5. Memiliki tujuan

Tujuan-tujuan yang harus diperhatikan oleh kepemimpinan yang efektif antara lain :

- a. Tujuan kelompok dan tujuan lingkungan/organisasi
- b. Tujuan individu (pemimpin dan anggota)
- c. Harus kooperatif dan pengertian agar suatu kelompok selalu berhasil

d. Memiliki persatuan

6. Melakukan tindakan/aksi

- a. Kemampuan memutuskan dan mengambil tindakan merupakan fokus pengembangan kepemimpinan
- b. Pemimpin tidak bisa menunggu instruksi dari orang lain
- c. Pertimbangkan tindakan sebelum mengambil tindakan/keputusan
- d. Berkolaborasi dengan orang lain
- e. Inisiatif dalam gagasan maupun perbuatan

G. Manajemen Strategi Rumah Sakit

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh (integral) dari organisasi sosial dan medis, yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat baik preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumahnya, rumah sakit juga merupakan pusat untuk latihan tenaga kesehatan dan untuk penelitian bio-psiko-sosioekonomi-budaya. Undang-undang No.44 Tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Febri & Stefanus, 2020).

Organisasi rumah sakit merupakan organisasi yang unik dan kompleks. Unik karena di rumah sakit terdapat suatu proses yang menghasilkan jasa medik, perawatan dalam bentuk pelayanan kepada pasien yang melakukan rawat inap maupun rawat jalan. Kompleks karena terdapat permasalahan yang sangat rumit dimana rumah sakit merupakan suatu organisasi padat karya dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, didalanya terdapat berbagai macam fasilitas pengobatan, berbagai macam peralatan dan yang dihadapi adalah orang yang memiliki emosi yang labil, tegang secara emosional karena dalam kondisi sakit termasuk keluarga pasien. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelayanan rumah sakit jauh lebih kompleks daripada hotel (Febri & Stefanus, 2020).

1. Karakteristik rumah sakit

Rumah sakit memiliki beberapa karakteristik antara lain :

- a. Merupakan industri padat modal dan padat karya (padat sumber daya) serta padat teknologi. Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam proses pelayanan
- b. Sifat produk rumah sakit sangat beragam, demikian juga proses layanan yang bervariasi, meskipun input sama. Terkadang sulit memisahkan antara proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*)

- c. Evolusi paradigma rumah sakit yang dinamis, semula nirlaba menjadi just profit atau profit. Semula tidak berlaku adanya persaingan bisnis, tetapi sekarang menjadi kompetitif. Tuntutan pasar, pemilik, lingkungan global yang dinamis dan berubah, dapat mengubah fungsi rumah sakit yang semula berfungsi sosial sekarang menjadi juga mempertimbangkan faktor ekonomi, hukum dan politik. Etika profesi dan etika pelayanan harus menyesuaikan tuntutan yang dinamis tersebut
- d. Pengguna rumah sakit tidak tahu apa yang harus dibeli saat berobat (*consumer ignorance*) dan demand yang sangat tidak elastis
- e. Jenis produk/jasa rumah sakit bisa *private goods* (pelayanan dokter, keperawatan, farmasi, gizi), *public goods* (layanan parkir, *front office*, *customer service*, *cleaning service*, *house keeping*, *laundry*, perbankan, travel, mini market, salon kecantikan layaknya hotel dan *externality* (imunisasi) (Febri & Stefanus, 2020).

H. Kepemimpinan Dalam Manajemen Krisis di Rumah Sakit

Pemimpin dalam sebuah rumah sakit bertanggung jawab untuk menjaga keadaan selama dalam situasi darurat, seperti pandemi atau bencana alam. Pada masa krisis, para profesional dalam peran kepemimpinan rumah sakit harus mengatasi tantangan praktis seperti menambah staf, komunikasi dan akses ke sumber daya serta juga membantu karyawan dan pasien dalam mengelola tantangan emosional berupa stress, kecemasan dan kelelahan. Pemimpin masa depan di bidang Kesehatan dapat membangun pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi krisis (Advent Health University, 2021).

1. Tantangan kepemimpinan rumah sakit selama keadaan krisis

Para pemimpin rumah sakit dapat menghadapi berbagai tantangan selama krisis, yang sering kali muncul dengan cepat dan tidak terduga. Akibatnya para pemimpin rumah sakit mungkin harus membuat keputusan dalam hitungan detik untuk terus menyediakan perawatan yang berkualitas tinggi di tengah kekacauan yang terjadi. Tantangan perawatan Kesehatan umum dalam situasi bencana antara lain :

a. Lonjakan pasien

Krisis dapat menyebabkan peningkatan permintaan perawatan, seperti selama penyebaran virus yang sangat menular atau setelah badai. Masuknya pasien ini dapat menguras sumber daya rumah sakit dan membebani staf layanan kesehatan

b. Kurangnya informasi

Pada saat krisis terjadi, pimpinan rumah sakit mungkin tidak memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat Keputusan cepat. Misalnya mereka mungkin tidak memahami bagaimana virus mematikan menyebar atau seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam

c. Kelangkaan persediaan

Rumah sakit mungkin akan mengalami kekurangan peralatan pelindung, staf, mesin medis dan ruangan yang mereka butuhkan untuk menyediakan perawatan yang berkualitas tinggi

d. Kekacauan emosional

Tenaga Kesehatan mungkin memerlukan dukungan emosional saat mereka bekerja dengan kondisi bencana yang datang secara tiba-tiba sehingga mengharuskan para pemimpin untuk menjaga tim tetap terlibat dan waspada

e. Perubahan dalam penjadwalan

Krisis dapat mengganggu rutinitas dan proses yang biasa, sehingga menantang para pemimpin rumah sakit untuk mengatur ulang jadwal dan menambah jam kerja untuk mengakomodasi kebutuhan pasien

f. Perlunya mitigasi risiko di masa mendatang

Bencana ataupun pandemi tidak selalu dapat diatasi dengan cepat, bencana atau pandemi dapat terus terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Akibatnya para pemimpin rumah sakit harus Bersiap menghadapi tantangan baru dan tak terduga yang muncul dan terus menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (Advent Health University, 2021).

2. Strategi kepemimpinan rumah sakit dalam situasi krisis

Pemimpin rumah sakit dapat menggunakan sejumlah strategi untuk membantu staf dan organisasi dalam mengatasi krisis. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Mengidentifikasi masalah secara jelas

Para profesional dalam peran kepemimpinan rumah sakit dapat menggunakan proses enam langkah yang dikenal dengan akronim POP-DOC untuk menilai kondisi dan merancang solusi yang efektif. Enam langkah tersebut yaitu:

- 1) Pahami situasinya, termasuk semua informasi, perspektif dan variable yang tersedia
- 2) Periksa diri anda dan identifikasi pola saat ini, seperti bagaimana penyakit tertentu dapat menyebar
- 3) Memprediksi apa yang mungkin terjadi, seperti penyebaran penyakit yang berkelanjutan jika orang berkumpul di tempat yang sama

- 4) Putuskan cara melanjutkan berdasarkan prediksi tersebut
 - 5) Operasikan keputusan tersebut dengan memasukkannya ke dalam strategi dan prosedur yang baru
 - 6) Komunikasikan operasi baru kepada semua pihak yang memerlukan.
- b. Memanfaatkan hubungan kepercayaan
- Pemimpin layanan kesehatan tidak harus bertindak sendiri. Mereka dapat mengandalkan penasihat, administrator, kolega dan mitra terpercaya di organisasi lokal untuk menanggapi, membangun solusi dan mendelegasikan tugas selama keadaan darurat atau krisis. Misalnya pimpinan rumah sakit dapat membentuk tim manajemen insiden lokal yang terdiri dari manajer, direktur dan administrator kesehatan masyarakat yang siap sedia selama masa krisis. Pimpinan rumah sakit juga dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan organisasi pemerintah, seperti pusat pengendalian dan pencegahan penyakit dan badan manajemen darurat federal (FEMA). Contohnya pada awal pandemi Covid-19, FEMA memberikan dana darurat kepada banyak rumah sakit yang membantu menutupi biaya peralatan pelindung, perangkat medis dan upah lembur bagi staf.
- c. Berkomunikasi secara transparan dan sering
- Berkomunikasi secara teratur dengan rekan kerja, pasien dan masyarakat dapat membantu rumah sakit memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang cara menangani dalam situasi krisis. Komunikasi melibatkan berbagai strategi kesehatan dan kesejahteraan, menyampaikan prosedur baru dan memberikan informasi terkini secara konsisten.
- Berkomunikasi dengan jelas dan tegas juga dapat membantu meredakan kekhawatiran dalam membangun kepercayaan antara pemimpin dan konstituen. Selama pandemi covid-19, misalnya wakil menteri kesehatan dan kesejahteraan Republik Korea menyelenggarakan pengarah harian, memberi tahu public tentang jumlah kasus di negara tersebut, pedoman untuk menjaga jarak sosial dan prosedur karantina.
- d. Ingat perawatan diri
- Para pemimpin perlu terus memperhatikan diri sendiri beserta tim dalam menghadapi keadaan krisis. Karena jika tidak maka akan beresiko mengalami kelelahan dan merusak kesehatan sendiri, yang dapat mencegah mereka untuk terus memimpin organisasi mereka dan memberikan perawatan kepada orang lain.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin rumah sakit dapat mendorong staf untuk berbicara ketika mereka merasa sakit atau terlalu banyak beban kerja, beristirahat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Contoh yang terjadi

saat covid-19, para tenaga kesehatan yang bekerja diberikan fasilitas di hotel serta diberikan akomodasi gratis bagi yang membutuhkan istirahat dan tempat untuk mengisolasi diri dari keluarga.

3. Keterampilan kepemimpinan rumah sakit yang penting

Para pemimpin rumah sakit harus mengembangkan keterampilan khusus untuk membimbing organisasi mereka melewati masalah krisis dan mengelola timnya di masa krisis. Keterampilan yang penting antara lain:

a. Pengambilan Keputusan

Pemimpin rumah sakit harus mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi krisis, seperti memutuskan sumber daya mana yang harus dialokasikan untuk tanggap darurat

b. Komunikasi

Pemimpin layanan kesehatan harus menjelaskan kebijakan dan prosedur baru secara efektif kepada staf dan pasien, menjaga sikap tenang, percaya diri dan dapat dipercaya di saat krisis. Mereka juga harus menguraikan isu-isu yang rumit dan sensitive, seperti mengukur dan mengelola penyebaran penyakit yang mengancam jiwa

c. Pengorganisasian

Masa krisis dapat menimbulkan kekacauan, sehingga para pemimpin rumah sakit harus siap menjaga ketertiban dan beradaptasi dengan kebutuhan logistik baru

d. Keterampilan sosial-emosional

Pemimpin rumah sakit harus membantu mengurangi rasa takut, stress, serta harus memberikan motivasi kepada staf untuk terus bekerja melalui pengalaman yang sulit dan seringkali berbahaya.

I. Kesimpulan

Permasalahan dalam system kesehatan seperti pandemi, bencana alam seringkali membutuhkan respons manajemen yang cepat dan efektif. Latar belakang ini menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan dalam masa krisis tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari seorang pemimpin dimana pemimpin tersebut harus mampu melakukan inovasi-inovasi sehingga mampu melewati masa krisis di rumah sakit. Seorang pemimpin harus bisa cepat dan tepat dalam menentukan suatu tindakan dan berani mengambil Keputusan yang tepat. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) rumah sakit memfasilitasi pimpinan maupun tenaga kesehatan secara berkala untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar terkait kepemimpinan, sehingga ilmu yang didapat dapat diimplementasikan di layanan kesehatan

J. Referensi

- Advent Health University. (2021). <https://www.ahu.edu/blog/hospital-leadership>. diakses pada tanggal 10 Januari 2025
- Beni Ahmad Saebeni, I.S. (2014). *Kepemimpinan*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- Carliastuti, & Stella, S. (2022). Gaya Kepimpinan Kepala Ruangan dan Motivasi Perawat Pelaksana Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. *Journal of Management Nursing*, 1 (3), 77-86
- Cherie, A dan Brekidan, A.B. (2013). *Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan*. Yogyakarta : Imperium
- Dian Candra Fatihah, Nurul Darmawanti. (2018). Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Pada Kinerja Perawat di RS AMN Subang PTPN VIII. *Jurnal E-Bis 2* (1), 35-52
- Febri Endra Budi Setyawan, Stefanus Supriyanto. (2019). *Manajemen Rumah Sakit*. Sidoarjo : Zifatama Jawara
- Morgan, Gareth. (2016). *Images of Organization*. Updated ed. Thousand Oaks, CA : Sage Publications
- Nur Amaliyah Hanum, Anisah Fithiray, Maisyaroh, Raden Bambang Sumarsono. (2019). Seminar Nasional Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. *Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi Industri 4.0F*
- Tappen, Weiss, S. (2014). *Essential of Nursing Leadership and Management*. Third Edition. Philadelpian : FA Davis Company

BAB 8

MENTORING DAN COACHING UNTUK PERAWAT DI POSISI KEPEMIMPINAN

Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.

A. Pendahuluan

Mentoring dalam konteks kepemimpinan keperawatan adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh seorang perawat berpengalaman (mentor) kepada perawat yang lebih muda atau baru (mentee), dengan tujuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan teknis, dan kompetensi interpersonal yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Mentoring bukan hanya berfokus pada pengembangan keterampilan klinis, tetapi juga pada aspek kepemimpinan yang sangat penting dalam organisasi kesehatan yang kompleks. Melalui mentoring, perawat tidak hanya bisa meningkatkan kualitas praktiknya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya organisasi yang sehat dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.

B. Pengertian Mentoring Dalam Kepemimpinan Keperawatan

Mentoring dalam kepemimpinan keperawatan adalah hubungan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan seorang mentor yang berpengalaman dalam memimpin perawat lain (mentee). Dalam konteks ini, mentoring bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan klinis, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi tim. Mentoring bertujuan untuk mendukung mentee dalam menghadapi tantangan dalam praktik keperawatan, mempersiapkan mereka untuk peran manajerial, serta membantu mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam pelayanan kesehatan (Telford, L., & Lee, L. (2023).

Ragins dan Kram (2007) menyatakan bahwa mentoring adalah sebuah hubungan yang melibatkan interaksi antara individu yang lebih berpengalaman (mentor) dengan individu yang lebih muda atau kurang berpengalaman (mentee) dalam suatu organisasi atau profesi tertentu.

Tujuan Mentoring Dalam Kepemimpinan Keperawatan

Mentoring dalam kepemimpinan keperawatan adalah proses di mana seorang pemimpin yang lebih berpengalaman, seperti kepala perawat atau manajer rumah sakit, memberikan bimbingan dan dukungan kepada perawat yang lebih muda atau

kurang berpengalaman untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan profesional mereka. Tujuan utama dari mentoring ini adalah untuk mempersiapkan perawat masa depan yang mampu mengambil peran kepemimpinan di berbagai tingkat dalam sistem perawatan kesehatan. Beberapa tujuan dari mentoring dalam kepemimpinan keperawatan:

1. Pengembangan kepemimpinan yang efektif

mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif, mentoring memberikan kesempatan kepada mentee (perawat yang dibimbing) untuk belajar dari pengalaman mentor dalam memimpin tim perawatan, mengelola konflik, dan mengambil keputusan strategis. Mentor dapat membimbing mentee untuk memahami tantangan kepemimpinan dalam praktik keperawatan dan bagaimana cara menanganinya dengan efektif.

2. Peningkatan ketrampilan manajerial dalam pengambilan keputusan

Mentoring dalam konteks ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan manajerial perawat melalui pelatihan praktis dan pembelajaran tentang pengelolaan tim, jadwal, dan konflik. Tidak hanya tentang memimpin perawat lain tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi yang penuh tekanan. Mentor membantu mentee untuk belajar membuat keputusan berbasis bukti, berfokus pada efisiensi operasional dan kualitas perawatan pasien (Lowe, G., & McGonigle, D, 2020).

3. Meningkatkan komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif adalah inti dari kepemimpinan keperawatan yang sukses. Mentoring membantu mentee untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, termasuk cara berkomunikasi dengan anggota tim, pasien, keluarga pasien, dan manajemen rumah sakit. Mentor dapat memberikan umpan balik mengenai cara berbicara secara asertif dan persuasif, serta bagaimana menjaga hubungan yang profesional dan empatik (Boyчук Duchscher, 2021)

4. Membangun kepercayaan diri dan pengembangan profesional

Mentoring juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri mentee dalam mengambil peran kepemimpinan. Dengan memberikan dukungan dan dorongan, mentor membantu mentee mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Dalam proses ini, perawat yang dibimbing dapat merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan kepemimpinan yang lebih besar di masa depan. Mentoring juga memberi kesempatan bagi mentee untuk mengeksplorasi peluang pengembangan profesional, seperti pendidikan lanjutan atau sertifikasi kepemimpinan (Mullen, 2022)

5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan tim

Perawat harus mampu mengelola tim multidisiplin, berkoordinasi dengan berbagai profesi, serta menjaga kepuasan kerja dan kinerja tim. Mentoring dalam kepemimpinan keperawatan membantu mentee untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola tim, delegasi tugas, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Mentor dapat mengajarkan tentang pentingnya pemberdayaan staf, serta bagaimana cara menciptakan budaya tim yang kolaboratif.

6. Menghadapi tantangan etika dan profesionalisme

Perawat seringkali harus membuat keputusan yang memengaruhi kualitas perawatan pasien dan kesejahteraan staf. Mentoring membantu mentee memahami kompleksitas dilema etika dalam perawatan kesehatan dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai etika keperawatan, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab profesional

7. Mempersiapkan generasi pemimpin masa depan yang siap menghadapi perubahan besar dalam sistem perawatan kesehatan,

seperti teknologi kesehatan yang berkembang pesat, pergeseran menuju perawatan berbasis tim, dan peningkatan kebutuhan akan perawatan berbasis komunitas. Dengan melalui mentoring, perawat yang lebih muda dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang adaptif dan visioner.

Mentoring dalam kepemimpinan keperawatan memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk perawat yang kompeten, percaya diri, dan siap memimpin. Melalui hubungan mentoring yang efektif, perawat dapat mengembangkan keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan komunikasi yang dibutuhkan untuk mengelola tim, meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta memenuhi tuntutan dinamis dalam dunia kesehatan. Melalui bimbingan dari mentor yang berpengalaman, perawat dapat lebih siap menghadapi tantangan kepemimpinan dan mempersiapkan diri untuk mengambil peran lebih besar dalam sistem perawatan kesehatan yang terus berkembang.

Model-Model Mentoring dalam Kepemimpinan Keperawatan

Mentoring dalam kepemimpinan keperawatan memainkan peran penting terhadap pengembangan kompetensi dan keterampilan perawat, baik yang baru bergabung maupun yang sudah berpengalaman. Model mentoring membantu perawat untuk tumbuh secara profesional, membangun rasa percaya diri, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien. Beberapa model mentoring dalam kepemimpinan keperawatan yang relevan dan terbaru:

1. Model mentoring tradisional (*One to One mentoring*)

Model ini adalah bentuk mentoring yang paling sederhana dan sering digunakan dalam banyak konteks, termasuk keperawatan. Dalam model ini, seorang mentor yang lebih berpengalaman membimbing seorang mentee (perawat yang lebih junior atau baru) dalam aspek klinis, etika, dan pengembangan profesional lainnya.

Karakteristik:

- a. Hubungan langsung dan personal: mentor memberikan panduan langsung kepada mentee terkait keterampilan teknis dan soft skills.
- b. Pendekatan berbasis pengalaman: mentor berbagi pengalaman mereka untuk membantu mentee mengatasi tantangan sehari-hari dalam pekerjaan.

Keunggulan:

- a. Memungkinkan bimbingan yang lebih mendalam dan fokus pada perkembangan individu.
- b. Dapat meningkatkan keterampilan klinis dan pengambilan keputusan.

2. Model mentoring berbasis kelompok.

Model ini, seorang mentor memberikan bimbingan kepada sekelompok perawat atau profesional lainnya. Meskipun kelompok ini lebih besar, interaksi antara mentor dan mentee tetap terjaga. Model ini efektif untuk membangun rasa solidaritas dan bekerja sama dalam tim.

Karakteristik:

- a. Mentor membimbing kelompok kecil: membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi dalam kelompok.
- b. Interaksi lebih banyak: mentees bisa saling belajar dari pengalaman rekan-rekan mereka dalam kelompok.

Keunggulan:

- a. Memperkuat kerja tim dan keterampilan kolaboratif.
- b. Meningkatkan kapasitas untuk menghadapi masalah secara kolektif.

3. Model mentoring berbasis kompetensi

Model ini fokus pada pengembangan kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh perawat dalam pekerjaan klinis dan non-klinis. Kompetensi ini mencakup keterampilan teknis, komunikasi, pengambilan keputusan klinis, serta pemahaman etika profesi.

Karakteristik:

- a. Pengembangan keterampilan praktis: Mentor membantu mentee untuk mengembangkan keterampilan klinis dan kemampuan untuk mengelola pasien.

- b. Penilaian berbasis kompetensi: Proses evaluasi berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dicapai oleh mentee.

Keunggulan:

- a. Membantu mentee untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan sehari-hari
- b. Mempercepat proses adaptasi bagi perawat baru.

4. Model mentoring transformasional

Model ini berfokus pada inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh mentor untuk mengubah pola pikir mentee. Mentor berperan sebagai figur yang menginspirasi, memberikan semangat, dan mendukung perawat untuk mencapai potensi tertinggi mereka dalam perawatan pasien dan kepemimpinan.

Karakteristik:

- a. Mentor sebagai pemimpin inspiratif: Mentor mendorong mentee untuk berpikir lebih besar, mengambil inisiatif, dan melihat perubahan dalam pekerjaan mereka
- b. Pengembangan kepemimpinan: Mentor mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada mentee, dengan fokus pada pembentukan nilai-nilai profesional yang kuat.

Keunggulan:

- a. Meningkatkan kepemimpinan yang kuat di kalangan perawat.
- b. Mendorong perubahan positif dalam praktik perawatan.

Model mentoring dalam kepemimpinan keperawatan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan perawat dan konteks praktik. Setiap model memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengembangan kompetensi teknis, karir, keterampilan kepemimpinan, dan kolaborasi tim. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai model ini, institusi perawatan kesehatan dapat merancang program mentoring yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan karir perawat dan meningkatkan kualitas perawatan pasien.

Tahapan Proses Mentoring

Proses mentoring dalam keperawatan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:

1. Persiapan dan penetapan tujuan

Mentor dan mentee melakukan pertemuan awal untuk mendiskusikan harapan, tujuan dan batasan dari hubungan mentoring. Ini adalah tahap penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara mentor dan mentee.

2. Pemilihan mentor dan mentee

Proses ini melibatkan pemilihan mentor yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang yang relevan, serta mentee yang siap menerima bimbingan dan umpan balik. Hubungan ini harus berdasarkan saling percaya dan komunikasi terbuka.

3. Pendampingan praktis

Mentor memberikan bimbingan langsung kepada mentee dalam praktik sehari-hari. Ini termasuk observasi, demonstrasi, dan diskusi tentang prosedur klinis serta pengambilan keputusan dalam situasi nyata

4. Sesi refleksi

Mentor dan mentee melakukan sesi refleksi secara berkala untuk membahas pengalaman, tantangan, dan kemajuan yang telah dicapai. Ini membantu mentee untuk merenungkan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki

5. Evaluasi berkala

Setiap beberapa bulan, mentor dan mentee melakukan evaluasi terhadap kemajuan mentee. Ini termasuk penilaian keterampilan, umpan balik dari rekan kerja, dan diskusi tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

6. Penutupan hubungan *mentoring*

Setelah periode mentoring berakhir, mentor dan mentee melakukan pertemuan penutup untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui, merayakan pencapaian, dan merencanakan langkah selanjutnya bagi mentee dalam karir keperawatan mereka

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas *Mentoring* dalam Kepemimpinan Keperawatan:

1. Membangun Hubungan yang Kuat dan Terpercaya (*Trust and Relationship Building*).

Hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan antara mentor dan mentee adalah fondasi dari *mentoring* yang efektif. Dalam konteks kepemimpinan keperawatan, ini berarti menciptakan ruang di mana mentee merasa nyaman untuk berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi dan aspirasi mereka. Mentor harus menjadi pendengar yang baik, menunjukkan empati, serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dalam lingkungan kerja.

Aktifitas :

- a. Melakukan pertemuan secara rutin dan menjalin komunikasi terbuka
- b. Menerima dan menghargai perbedaan pendapat serta pandangan dalam *mentoring*.

2. Penyusunan tujuan yang jelas dan terukur (*Clear and Measurable Goal Setting*).

Tujuan yang jelas sangat penting untuk memandu proses mentoring. Dalam kepemimpinan keperawatan, tujuan ini bisa mencakup peningkatan keterampilan manajerial, pengelolaan waktu, pengambilan keputusan yang lebih baik, atau kemampuan dalam menangani kasus klinis yang kompleks. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, mentor dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan evaluasi yang objektif mengenai kemajuan mentee.

Aktifitas:

- a. Menggunakan pendekatan *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) untuk merancang tujuan
- b. Membantu mentee untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan

3. Pemberian umpan balik yang konstruktif (*Constructive Feedback*)

Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah aspek kunci dalam proses mentoring. Umpan balik yang tepat waktu dan spesifik akan membantu mentee mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik juga harus diberikan dengan cara yang mendukung dan membangun rasa percaya diri mentee

Aktifitas :

- a. Memberikan umpan balik segera setelah kejadian atau pertemuan
- b. Menggunakan pendekatan "sandwich," di mana umpan balik positif diberikan terlebih dahulu, diikuti dengan area untuk perbaikan, dan diakhiri dengan motivasi atau penghargaan.

4. Pengembangan keterampilan kepemimpinan (*Leadership Skill Development*)

Mentoring dalam konteks kepemimpinan keperawatan tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan klinis, tetapi juga keterampilan manajerial dan kepemimpinan. *Mentoring* harus memberikan kesempatan bagi mentee untuk terlibat dalam tugas-tugas kepemimpinan, seperti memimpin tim, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik.

Aktifitas:

- a. Melibatkan mentee dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis
- b. Mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan pengelolaan sumber daya manusia

5. Pemanfaatan teknologi dalam mentoring (*Technology Utilization*).

Teknologi dapat meningkatkan efektivitas mentoring, terutama dalam konteks jarak jauh atau dalam lingkungan yang sibuk. Platform digital dapat

digunakan untuk mengatur jadwal pertemuan, berbagi materi pembelajaran, atau memberikan umpan balik secara *real-time*.

Aktifitas:

- a. Menggunakan aplikasi video conferencing untuk pertemuan rutin
- b. Berbagi artikel, video, atau modul pelatihan yang relevan untuk memperkaya proses pembelajaran

6. Mendorong refleksi diri dan pembelajaran berkelanjutan (*Self-Reflection and Continuous Learning*).

Mentoring yang efektif melibatkan proses refleksi diri, di mana mentee merenung dan mengevaluasi perkembangan mereka. Dengan mendorong mentee untuk terus belajar dan reflektif, mentor dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan manajerial dan kepemimpinan mereka.

Aktifitas:

- a. Menggunakan teknik jurnal atau diskusi reflektif untuk mengeksplorasi pengalaman yang telah dijalani
- b. Mendorong mentee untuk mengikuti pelatihan lanjutan atau mendapatkan sertifikasi yang relevan.

7. Program mentoring yang terstruktur (*Structured Mentoring Program*).

Program *mentoring* yang terstruktur memberikan panduan yang jelas mengenai proses dan peran masing-masing pihak. Sebuah struktur yang jelas akan memudahkan mentor dan mentee dalam mengatur waktu, menetapkan tujuan, serta mengevaluasi kemajuan secara objektif.

Aktifitas:

- a. Menyusun kurikulum atau rencana *mentoring* yang mencakup topik-topik tertentu yang harus dibahas selama periode *mentoring*
- b. Menetapkan frekuensi pertemuan dan format evaluasi untuk memantau progres mentee

8. Peningkatan kapasitas mentor (*Mentor Capacity Building*).

Untuk meningkatkan efektivitas *mentoring*, mentor harus terus memperbarui keterampilan mereka dalam hal kepemimpinan, komunikasi, dan *coaching*. Mentor yang terlatih akan lebih mampu memberikan bimbingan yang efektif dan memberi contoh yang baik bagi mentee.

Aktifitas:

- a. Menyediakan pelatihan untuk mentor tentang keterampilan *mentoring* dan kepemimpinan
- b. Mengadakan sesi *feedback* untuk mentor guna meningkatkan keterampilan mereka dalam membimbing mentee

C. Coaching Untuk Perawat

Coaching dalam konteks kepemimpinan merujuk pada pendekatan pengembangan individu yang berfokus pada pemberian dukungan, umpan balik, dan pembelajaran berkelanjutan dengan tujuan membantu seseorang untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam peran kepemimpinan. Untuk perawat, *coaching* menjadi kunci penting dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan yang efektif, karena mereka dihadapkan dengan tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan perawatan pasien, tetapi juga dengan manajemen tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks organisasi kesehatan. *Coaching* adalah proses di mana seorang pemimpin atau mentor membantu individu untuk mencapai potensi penuh mereka melalui dialog, refleksi, dan umpan balik. *Coaching* dapat membantu perawat untuk mengembangkan keterampilan klinis, komunikasi, dan kepemimpinan yang diperlukan dalam praktik sehari-hari.

Coaching dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Peningkatan keterampilan komunikasi: agar perawat dapat memberikan arahan yang jelas kepada staf dan berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan keluarga.
2. Pengembangan keterampilan: membantu perawat dalam meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal
3. Pengembangan kecerdasan emosional: untuk meningkatkan empati, pengelolaan stres, dan hubungan interpersonal yang sehat di dalam tim
4. Manajemen waktu dan keputusan yang lebih baik: agar perawat pemimpin dapat membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan yang sering terjadi dalam lingkungan kesehatan.
5. Membangun kepercayaan diri: memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perawat dalam mengambil keputusan klinis.

D. Model Coaching Yang Digunakan Untuk Perawat Pemimpin

Coaching untuk pengembangan kepemimpinan perawat memainkan peran penting dalam membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola tim, berinteraksi dengan pasien, serta membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang penuh tekanan. Model-model coaching yang digunakan untuk perawat pemimpin dapat memberikan struktur dan proses yang jelas untuk memastikan hasil yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai beberapa model coaching yang relevan:

1. Model GROW

GROW adalah salah satu model coaching yang paling banyak digunakan, karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan mudah dipahami. Model ini dirancang untuk membantu individu mencapai tujuan mereka melalui empat langkah utama:

- a. *Goal* (Tujuan): Langkah pertama adalah mendefinisikan tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh perawat pemimpin. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan realistis. Sebagai contoh, tujuan bisa berupa peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik atau meningkatkan kepuasan kerja tim.
- b. *Reality* (Kenyataan): Setelah tujuan ditetapkan, perawat harus mengevaluasi situasi mereka saat ini. Ini termasuk mengenali tantangan yang ada, kekuatan yang dimiliki, dan hambatan yang mungkin mereka hadapi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi mereka saat ini.
- c. *Options* (Opsi): Di langkah ini, perawat pemimpin bersama coach akan mengeksplorasi berbagai opsi atau strategi untuk mencapai tujuan mereka. Berbagai solusi dan pendekatan dapat dipertimbangkan, seperti pelatihan keterampilan komunikasi atau pembelajaran pengelolaan waktu yang lebih baik.
- d. *Will* (Kemauan): Langkah terakhir adalah komitmen terhadap tindakan yang akan diambil. Ini melibatkan perencanaan konkret tentang langkah-langkah yang harus diambil dan kapan mereka akan dilakukan. Pada tahap ini, perawat harus membuat komitmen untuk bertindak dan terus mengembangkan keterampilan mereka.

Model *GROW* efektif digunakan dalam coaching perawat pemimpin karena sifatnya yang sederhana dan langsung. Ini memungkinkan perawat untuk mengevaluasi diri mereka secara kritis dan secara sistematis mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan dalam peran kepemimpinan mereka.

2. Model OSKAR

Model *OSKAR* merupakan alternatif yang sangat berguna untuk coaching yang berfokus pada kekuatan (*strengths-based*). Model ini memberikan fokus pada hasil dan pencapaian positif, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih solutif.

- a. *Outcome* (Hasil): Seperti dalam model *GROW*, tahap pertama adalah menetapkan hasil yang ingin dicapai. Fokusnya adalah pada pencapaian yang ingin diraih dalam konteks peran kepemimpinan. Sebagai contoh, perawat

pemimpin mungkin ingin meningkatkan kolaborasi tim atau mengurangi kesalahan komunikasi.

- b. *Scaling* (Skala): Dalam tahap ini, perawat bersama coach menilai sejauh mana mereka telah mencapai tujuan tersebut, menggunakan skala, misalnya dari 1 hingga 10. Skala ini membantu mereka melihat progres mereka dan memahami apa yang perlu diperbaiki.
- c. *Affirm + Action* (Penguatan dan Tindakan): Coach memberikan penguatan positif atas kekuatan yang telah diidentifikasi dan merencanakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Tindakan ini berfokus pada langkah-langkah spesifik yang perawat pemimpin harus ambil dalam jangka pendek dan panjang
- d. *Review* (Tinjauan): Pada tahap ini, hasil coaching dievaluasi, dan kemajuan yang dicapai diukur. Tinjauan ini membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan efektif dalam konteks tujuan yang lebih besar.

Model OSKAR sangat bermanfaat dalam konteks kepemimpinan perawat karena lebih berfokus pada pencapaian positif dan kekuatan individu, yang membantu membangun rasa percaya diri dan pemberdayaan di dalam diri perawat pemimpin

3. Model **FUEL**

FUEL adalah model coaching yang lebih berfokus pada pemecahan masalah dan pengembangan keputusan yang praktis, yang sangat penting bagi perawat di posisi kepemimpinan yang sering dihadapkan pada keputusan yang cepat dan kritis.

- a. *Frame* (Kerangka): Langkah pertama dalam model FUEL adalah membantu perawat untuk memahami konteks dari masalah atau tantangan yang dihadapi. Ini termasuk mendefinisikan masalah secara jelas dan memahami dampak yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil.
- b. *Understand* (Pahami): Setelah masalah didefinisikan, perawat bersama coach akan menggali lebih dalam untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Ini termasuk faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perawat dan tim.
- c. *Explore* (Eksplorasi): Dalam langkah ini, perawat pemimpin akan mengeksplorasi berbagai solusi atau opsi yang ada. Fokusnya adalah untuk mencari alternatif terbaik berdasarkan data dan informasi yang ada
- d. *Launch* (Luncurkan): Langkah terakhir adalah perencanaan dan pelaksanaan solusi yang telah dipilih. Ini melibatkan penetapan langkah-langkah aksi

konkret dan memonitor implementasinya untuk memastikan solusi tersebut dapat diterapkan dengan efektif

Model *FUEL* memberikan fokus pada pengambilan keputusan yang informasional dan berbasis bukti, yang sangat penting bagi perawat pemimpin yang harus mengelola tim dan memutuskan tindakan yang tepat dalam situasi yang penuh tekanan.

Model coaching seperti *GROW*, *OSKAR*, dan *FUEL* memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mendukung perawat dalam peran kepemimpinan mereka. Setiap model memiliki kelebihan tersendiri, baik dari sisi tujuan pencapaian, fokus pada kekuatan, maupun pengambilan keputusan berbasis data. Melalui coaching yang terstruktur, perawat pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan lebih efektif, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kesehatan.

Manfaat *Coaching* Untuk Perawat Dalam Kepemimpinan

Coaching memberikan perawat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ini dengan cara yang lebih terstruktur dan terfokus, mengenai manfaat coaching untuk perawat:

1. Peningkatan kemampuan kepemimpinan

Salah satu manfaat utama coaching bagi perawat adalah peningkatan kemampuan kepemimpinan. Perawat yang berperan sebagai pemimpin sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan tim, delegasi tugas, dan pengambilan keputusan. Melalui coaching, perawat dapat belajar bagaimana mengelola dan memotivasi tim mereka dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih inspiratif. *Coaching* membantu perawat untuk lebih memahami gaya kepemimpinan mereka sendiri, kekuatan, dan area yang perlu dikembangkan.

- a. Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan: *coaching* dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Perawat yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang efektif akan lebih mampu mengelola situasi kritis yang sering terjadi dalam dunia kesehatan.
- b. Pengelolaan tim yang efektif: dengan *coaching*, perawat pemimpin dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola tim, mengelola konflik, dan meningkatkan kolaborasi antar anggota tim yang berbeda latar belakang dan keahlian.

2. Peningkatan kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) adalah salah satu kompetensi penting bagi perawat yang memimpin tim. Coaching membantu perawat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain. Perawat yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi lebih mampu berkomunikasi dengan empati, mengelola konflik, dan merespons situasi stres dengan lebih efektif

- a. Mengelola stres: dalam profesi keperawatan, stres dan kelelahan (*burnout*) adalah masalah yang sangat umum. *Coaching* dapat membantu perawat mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan menjaga kesejahteraan mental mereka, yang sangat penting dalam menjaga performa kepemimpinan yang efektif
- b. Meningkatkan komunikasi: kecerdasan emosional juga mendukung kemampuan perawat dalam berkomunikasi secara efektif, yang sangat penting dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak profesional kesehatan

3. Pengembangan keterampilan interpersonal dan kolaborasi

Perawat pemimpin sering kali harus bekerja dengan berbagai tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lainnya. Oleh karena itu, keterampilan interpersonal yang baik sangat diperlukan. Coaching membantu perawat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan orang lain, menyelesaikan konflik, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota tim dan rekan sejawat.

- a. Membangun hubungan yang kuat: melalui *coaching*, perawat dapat belajar bagaimana membangun hubungan yang kuat dan produktif dengan rekan kerja dan staf mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kerja tim dan kinerja organisasi.
- b. Kolaborasi antar tim: *coaching* membantu perawat untuk memahami dinamika kelompok dan cara terbaik untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan.

4. Meningkatkan kepuasan kerja dan retensi

Program *coaching* yang efektif dapat berdampak langsung pada kepuasan kerja perawat. Ketika perawat merasa dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui *coaching*, mereka cenderung merasa lebih terhubung dengan organisasi mereka dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja yang lebih tinggi berhubungan dengan pengurangan *turnover*, yang merupakan masalah besar dalam dunia perawatan kesehatan.

- a. Pemberdayaan dan motivasi: perawat yang mengikuti program coaching merasa lebih diberdayakan dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik

dalam pekerjaan mereka. Mereka merasa bahwa mereka memiliki kontrol lebih besar atas karier dan pengembangan diri mereka.

- b. Mengurangi *turnover*. *Coaching* yang baik dapat meningkatkan retensi perawat di organisasi, karena mereka merasa lebih didukung dalam pekerjaan mereka dan merasa bahwa ada peluang untuk pertumbuhan karier

5. Peningkatan kinerja organisasi

Coaching untuk perawat pemimpin tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga dapat membawa dampak positif bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan meningkatkan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen stres, perawat yang telah dilatih melalui *coaching* dapat memimpin tim dengan lebih efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan dan hasil kesehatan pasien

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pasien: perawat pemimpin yang lebih baik dalam komunikasi dan pengelolaan tim akan lebih mampu mengkoordinasikan perawatan pasien secara efektif dan memberikan kualitas pelayanan yang lebih tinggi
- b. Kinerja tim yang lebih baik: *coaching* membantu perawat untuk menciptakan tim yang lebih solid, yang berfokus pada hasil, meningkatkan efektivitas dalam perawatan pasien dan efisiensi operasional

Coaching untuk perawat pemimpin memberikan berbagai manfaat yang luas, baik untuk individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan program *coaching* yang efektif bagi perawat yang memegang posisi kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan hasil kinerja secara keseluruhan.

Studi Kasus Dan Contoh Penerapan *Coaching* bagi Perawat

Penerapan *coaching* dalam konteks kepemimpinan perawat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efektivitas tim, dan kesejahteraan profesional perawat. *Coaching* menawarkan dukungan terstruktur untuk membantu perawat dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan pengelolaan stres, serta memperkuat kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam peran kepemimpinan mereka. Berikut adalah contoh penerapan *coaching* bagi perawat melalui studi kasus yang menggambarkan bagaimana *coaching* dapat diterapkan secara praktis dan manfaatnya

Studi Kasus 1: Penerapan *Coaching* untuk Meningkatkan Kepemimpinan Perawat dalam Manajemen Tim.

Latar belakang

Seorang perawat senior, "Rina," bekerja sebagai pemimpin tim di unit perawatan intensif (ICU) sebuah rumah sakit besar. Meskipun Rina memiliki pengalaman klinis yang luas, ia sering merasa kesulitan dalam mengelola timnya. Konflik antar anggota tim, kurangnya koordinasi, dan kesulitan dalam memberi arahan yang jelas kepada tim menjadi tantangan besar bagi Rina. Rina merasa bahwa meskipun dia memiliki keterampilan teknis yang sangat baik, kepemimpinannya kurang efektif dan ia tidak dapat memotivasi atau mengarahkan timnya dengan baik.

Pendekatan *Coaching*

Untuk membantu Rina mengatasi tantangan tersebut, manajemen rumah sakit memutuskan untuk menerapkan program coaching berbasis model *GROW* untuk pengembangan kepemimpinan. Coaching dilakukan selama enam bulan, dengan sesi *coaching* dilakukan setiap dua minggu. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil selama *coaching*.

- a. *Goal* (Tujuan): Rina dan coach menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi konflik dalam tim dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan keterampilan kepemimpinan Rina sehingga ia bisa memimpin tim dengan lebih efektif.
- b. *Reality* (Kenyataan): Selama sesi pertama, *coach* membantu Rina menganalisis situasi saat ini. Rina menyadari bahwa komunikasi yang kurang jelas dan kebingungan tentang pembagian tugas adalah akar dari sebagian besar masalah. Ia juga merasa tidak nyaman dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim.
- c. *Options* (Opsi): Rina bersama *coach* mengidentifikasi beberapa opsi untuk mengatasi masalah ini, termasuk pelatihan dalam keterampilan komunikasi efektif, pengaturan pertemuan tim rutin, serta penggunaan metode pemberian umpan balik yang lebih konstruktif dan berbasis solusi.
- d. *Will* (Kemauan): Rina membuat komitmen untuk mengimplementasikan rencana tindakannya. Ia berjanji untuk melakukan pertemuan tim mingguan dan memberikan umpan balik yang lebih terstruktur pada anggota tim. Selain itu, ia juga akan berfokus pada pengelolaan konflik dengan cara yang lebih konstruktif.

Hasil

Setelah enam bulan *coaching*, Rina melaporkan perbaikan signifikan dalam kinerja timnya. Anggota tim merasa lebih terkoordinasi, dan konflik internal berkurang secara drastis. Rina juga merasa lebih percaya diri dalam memimpin dan lebih nyaman dalam memberikan umpan balik yang membangun. Dengan

keterampilan kepemimpinan yang lebih kuat, Rina berhasil meningkatkan atmosfer kerja yang lebih kolaboratif dan efektif.

Manfaat yang diperoleh

- a. Peningkatan komunikasi: Rina berhasil memperbaiki komunikasi antar anggota tim melalui pertemuan rutin dan penyusunan tujuan yang lebih jelas
- b. Pengelolaan konflik yang lebih baik: Rina menjadi lebih terampil dalam menangani konflik, yang berkontribusi pada peningkatan hubungan antar anggota tim.
- c. Peningkatan kepuasan tim: tim merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja bersama secara lebih efisien.

E. Kesimpulan

Konteks kepemimpinan perawat, mentoring maupun coaching adalah pendekatan yang sangat berguna untuk pengembangan profesional, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, proses, dan peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun demikian, keduanya memiliki beberapa persamaan yang memungkinkan keduanya memberikan manfaat yang signifikan bagi perawat yang ingin berkembang dalam peran kepemimpinan mereka. Baik mentoring maupun coaching memberikan nilai yang besar bagi perawat yang berada dalam posisi kepemimpinan, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Mentoring lebih bersifat jangka panjang dan lebih berfokus pada pengembangan karir secara menyeluruh dengan berbagi pengalaman dan panduan dari mentor yang lebih berpengalaman. Sementara itu, coaching lebih terstruktur, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih spesifik dalam waktu yang lebih singkat dan mendukung pengembangan keterampilan tertentu.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi, dan dalam banyak kasus, seorang perawat pemimpin dapat mengambil manfaat dari keduanya untuk berkembang secara profesional dan meningkatkan kemampuannya dalam memimpin tim. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan dan persamaan antara mentoring dan coaching sangat penting untuk memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan individu tersebut.

F. Referensi

Telford, L., & Lee, L. (2023). Mentoring for nursing leadership: Advancing the future of care. *Journal of Nursing Management*, 31(6), 1862-1870. <https://doi.org/10.1111/jonm.13778>

- Ragins, B. R., & Kram, K. E. (2007). *The handbook of mentoring at work: Theory, research, and practice*. Sage Publications.
- Sullivan, E. J., & Decker, P. J. (2021). *Effective leadership in nursing: A practical approach*. Prentice Hall.
- Lowe, G., & McGonigle, D. (2020). Leadership in nursing practice: Changing the landscape of healthcare. *Nursing Leadership*, 33(2), 45-58.
- Boychuk Duchscher, J. E. (2021). Communicative competencies in nursing leadership. *Journal of Nursing Communication*, 15(2), 99-107.
- Mullen, C. A. (2022). Mentoring and leadership development in nursing: Approaches to enhance clinical leadership. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1234-1245.
- Marshall, K., & O'Rourke, S. (2023). Effective team management and collaboration in nursing leadership. *Journal of Nursing Management*, 31(3), 225-233.
- Ulrich, C. M., & Grady, C. (2021). Ethical challenges in nursing leadership: Promoting professional ethics in nursing practice. *Journal of Nursing Ethics*, 28(1), 51-62.
- Gibbons, C., & Grey, J. (2022). The role of mentorship in nursing leadership. *Journal of Nursing Management*, 30(6), 1672-1680.
- Duffy, S. (2023). Competency-based mentoring in nursing practice: Bridging the gap between theory and practice. *Journal of Clinical Nursing*, 32(5), 1068-1077.
- Husebø, S. E., & O'Regan, A. (2020). The role of mentorship in developing nurse leadership. *Nursing Management*, 27(6), 22-28.
<https://doi.org/10.7748/nm.2020.e1753>
- Kase, R., & O'Rourke, S. (2022). Leadership coaching for nurses: The power of a strengths-based approach. *Journal of Nursing Leadership*, 35(1), 12-19.
<https://doi.org/10.1111/jonm.13587>
- Grant, A. M., & Cavanagh, M. J. (2023). Coaching psychology: A practice-based approach. *International Journal of Coaching Psychology*, 18(4), 225-240.
<https://doi.org/10.1080/17521882.2023.1839489>
- Jackson, P., & McKergow, M. (2020). *The solutions focus: Making coaching and change SIMPLE*. Nicholas Brealey Publishing.
- Martin, S., & McCarthy, A. (2022). Coaching and emotional intelligence for nurse leaders. *Journal of Nursing Administration*, 52(4), 208-214.
<https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000001158>
- Taylor, M., & Brown, T. (2021). Developing collaborative skills in nurse leadership through coaching. *Journal of Nursing Management*, 29(5), 1210-1218.
<https://doi.org/10.1111/jonm.13209>

BAB 9

MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN UNTUK PERAWAT MUDA

Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan praktik keperawatan, khususnya dalam mendukung peran perawat sebagai penggerak utama dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sebagai bagian dari generasi profesional baru, perawat muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan. Namun demikian, mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara optimal di lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis.

Selain bertanggung jawab atas pemberian perawatan langsung kepada pasien, perawat juga berperan sebagai pemimpin dalam tim kesehatan. Kepemimpinan yang efektif memungkinkan mereka untuk memengaruhi tim, meningkatkan hasil klinis, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik di sektor keperawatan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan pasien, kepuasan kerja perawat, serta efisiensi organisasi (Wong et al., 2013).

Beberapa tantangan utama yang dihadapi perawat muda dalam mengembangkan peran kepemimpinan mencakup: Kurangnya Pengalaman: Sebagai pendatang baru dalam profesi, banyak perawat muda merasa kurang percaya diri untuk mengambil peran kepemimpinan (Dyess et al., 2016); Tekanan Lingkungan Kerja: Sistem kesehatan yang sering berorientasi pada hierarki dapat membatasi inisiatif kepemimpinan dari perawat muda (Curtis et al., 2011); Tuntutan Kompetensi Multidimensi: Kepemimpinan dalam keperawatan tidak hanya membutuhkan pengetahuan klinis, tetapi juga keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan konflik.

Generasi muda dalam profesi keperawatan memiliki karakteristik unik, seperti keterbukaan terhadap teknologi dan semangat untuk belajar. Berdasarkan laporan *Nursing Times* (2022), perawat muda lebih cenderung memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, mereka juga menghadapi tingkat stres yang tinggi akibat beban kerja yang berat dan kurangnya dukungan dalam pengembangan profesional.

Organisasi kesehatan seperti *World Health Organization* (WHO) dan *International Council of Nurses* (ICN) telah menyoroti pentingnya investasi dalam

program pengembangan kepemimpinan bagi perawat muda. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan tenaga kerja keperawatan yang kompeten dan adaptif terhadap tantangan masa depan (WHO, 2020).

Pengembangan keterampilan kepemimpinan pada perawat muda bertujuan untuk: membantu mereka menjadi agen perubahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja, memperkuat kolaborasi antar-profesi di sektor kesehatan. Dengan mempersiapkan perawat muda sebagai pemimpin masa depan, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif.

B. Konsep Dasar Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keperawatan, hal ini mencakup kemampuan untuk memberikan arahan, membangun kolaborasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian hasil kesehatan yang optimal (Northouse, 2021). Kepemimpinan yang efektif melibatkan perpaduan keterampilan interpersonal, kemampuan analitis, dan penguasaan teknis.

Dalam keperawatan, berbagai gaya kepemimpinan dapat diterapkan, antara lain:

1. Kepemimpinan Transformasional:

Gaya ini memotivasi dan menginspirasi tim untuk melampaui ekspektasi dengan menekankan visi dan inovasi (Bass & Riggio, 2006).

2. Kepemimpinan Servant:

Berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan anggota tim dan pasien sebagai prioritas utama (Greenleaf, 1977).

3. Kepemimpinan Situasional:

Menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi (Hersey & Blanchard, 1982).

Kompetensi kepemimpinan dalam keperawatan meliputi:

1. Komunikasi Efektif:

Kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan membangun hubungan positif dengan tim serta pasien (Curtis et al., 2011).

2. Pengambilan Keputusan:

Keterampilan untuk menganalisis masalah dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti.

3. Pengelolaan Konflik:

Kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat di dalam tim secara konstruktif guna mencapai solusi yang positif.

Kolaborasi antar-profesi menjadi elemen penting dalam kepemimpinan keperawatan. Pemimpin yang efektif mampu mendorong komunikasi terbuka dan kerja sama antara berbagai profesi kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan hasil pasien dan efisiensi layanan kesehatan (Wong et al., 2013).

Pengembangan kepemimpinan memerlukan dukungan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Program pelatihan berbasis praktik telah terbukti meningkatkan kompetensi serta kepercayaan diri perawat muda dalam menjalankan peran kepemimpinan (Dyess et al., 2016).

C. Kompetensi Kepemimpinan dalam Keperawatan

Kompetensi kepemimpinan dalam keperawatan: komunikasi efektif, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, pengelolaan konflik, Kolaborasi antar-profesi.

1. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah fondasi dari kepemimpinan yang sukses. Pemimpin keperawatan harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang membangun. Dalam keperawatan, komunikasi yang baik tidak hanya meningkatkan hubungan interpersonal tetapi juga berkontribusi pada keselamatan pasien dengan meminimalkan risiko kesalahan (Curtis et al., 2011). Seorang pemimpin yang efektif menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti komunikasi verbal, non-verbal, dan tertulis, untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prioritas kerja. Komunikasi yang terbuka dan transparan juga menciptakan kepercayaan dan kolaborasi dalam tim (Northouse, 2021).

2. Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah

Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah secara efektif adalah kompetensi esensial dalam kepemimpinan keperawatan. Pemimpin keperawatan dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan analisis cepat dan keputusan berdasarkan bukti. Mereka harus mampu mengevaluasi berbagai opsi, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang, serta melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan (Huston, 2017). Keputusan yang baik didasarkan pada kombinasi antara data klinis, pengetahuan teoritis, dan masukan dari tim. Dengan pendekatan yang sistematis, pemimpin keperawatan dapat mengatasi tantangan kompleks, seperti alokasi sumber daya yang terbatas atau konflik antara anggota tim.

3. Pengelolaan Konflik

Lingkungan kerja di bidang keperawatan sering kali menghadapi konflik yang disebabkan oleh tekanan kerja, perbedaan pendapat, atau kesenjangan komunikasi. Pengelolaan konflik yang baik menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh pemimpin keperawatan. Konflik yang dikelola secara efektif dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan tim dan meningkatkan inovasi (Almost et al., 2016).

Pendekatan dalam pengelolaan konflik meliputi:

- a. Kolaborasi: Mengidentifikasi solusi bersama yang memenuhi kepentingan semua pihak.
- b. Mediasi: Berperan sebagai fasilitator netral untuk menyelesaikan konflik.
- c. Negosiasi: Menggunakan pendekatan kompromi untuk mencapai kesepakatan.

Pemimpin yang sukses dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan meminimalkan konflik destruktif dan mendorong kerja sama tim.

D. Tantangan Perawat Muda dalam Kepemimpinan

Perawat muda sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan dan menerapkan keterampilan kepemimpinan. Tantangan ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif di lingkungan kerja. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. Hambatan Psikologis

Perawat muda sering kali menghadapi hambatan psikologis yang memengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan peran kepemimpinan. Tantangan ini meliputi: Kurangnya Kepercayaan Diri: Banyak perawat muda merasa tidak siap atau tidak percaya diri dalam mengambil peran sebagai pemimpin, terutama ketika berhadapan dengan kolega yang lebih senior (Dyess et al., 2016). Adaptasi terhadap Peran Baru: Peralihan dari peran klinis ke peran kepemimpinan sering kali membutuhkan waktu dan penyesuaian. Proses ini dapat memicu perasaan cemas atau stres, terutama ketika ekspektasi kerja tidak jelas (Kumaran & Carney, 2014). Mengatasi hambatan psikologis ini memerlukan dukungan dari mentor, pelatihan, dan pengalaman yang memadai untuk membangun kepercayaan diri perawat muda.

2. Hambatan Organisasi

Struktur dan budaya organisasi sering kali menjadi penghalang bagi perawat muda untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Struktur Hierarki: Lingkungan kerja yang terlalu hierarkis dapat membatasi inisiatif dan kreativitas perawat muda. Dalam sistem seperti ini, mereka sering kali merasa suara atau ide mereka tidak dianggap penting (Curtis et al., 2011). Budaya Kerja

yang Tidak Mendukung: Budaya kerja yang kurang kolaboratif atau cenderung kompetitif dapat menghambat perkembangan kepemimpinan. Selain itu, kurangnya akses terhadap program pelatihan atau mentor juga menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan organisasi, diperlukan perubahan budaya kerja yang lebih inklusif serta dukungan manajerial yang kuat terhadap pengembangan perawat muda.

3. Tantangan Teknis dan Non-Teknis

Perawat muda juga dihadapkan pada tantangan teknis dan non-teknis yang memengaruhi kemampuan mereka sebagai pemimpin. Tantangan Teknis: Keterbatasan dalam penguasaan teknologi baru, kurangnya pengalaman klinis yang mendalam, dan kesulitan dalam mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik dapat menjadi penghambat. Padahal, teknologi dan evidence-based practice merupakan elemen penting dalam kepemimpinan modern (Nursing Times, 2022). Tantangan Non-Teknis: Keterampilan seperti komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan yang kompleks, dan pengelolaan konflik sering kali memerlukan pengembangan lebih lanjut. Perawat muda juga harus mampu memahami dinamika tim dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Peningkatan kompetensi ini memerlukan pendidikan yang holistik dan pengalaman langsung di lapangan melalui pembimbingan atau program pengembangan profesional (Wong et al., 2013). Dengan mengenali tantangan-tantangan tersebut, organisasi kesehatan dapat erancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung perawat muda. Hal ini termasuk menyediakan akses ke pelatihan, mentoring, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung pengembangan kepemimpinan mereka.

E. Strategi Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan

Pengembangan keterampilan kepemimpinan pada perawat muda membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan formal, pembelajaran berbasis pengalaman, dan pemanfaatan teknologi. Strategi-strategi berikut dapat diterapkan untuk mendukung perawat muda dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang efektif.

1. Pendidikan Formal dan Informal

Pendidikan merupakan elemen utama dalam membangun dasar kepemimpinan yang kuat. Pendidikan formal dan informal dapat saling melengkapi untuk mendukung pengembangan perawat muda.

a. Pendidikan Formal:

Program pendidikan keperawatan, seperti jenjang S1, Ners, atau spesialisasi, sering kali mencakup materi tentang kepemimpinan, manajemen, dan

pengambilan keputusan. Mata kuliah yang berfokus pada manajemen keperawatan memberikan landasan teoretis yang penting untuk memahami dinamika kepemimpinan dalam konteks kesehatan (Curtis et al., 2011).

b. Pendidikan Informal:

Pelatihan dan program mentoring adalah pendekatan yang efektif untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan. Melalui pelatihan, perawat muda dapat belajar tentang teknik komunikasi, pengelolaan konflik, dan kolaborasi antar-profesi. Mentoring, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi perawat muda untuk mendapatkan panduan dari pemimpin yang lebih berpengalaman, meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan peran kepemimpinan (Dyess et al., 2016).

2. Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Pembelajaran berbasis pengalaman menawarkan peluang untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dalam situasi nyata.

a. Praktik Lapangan:

Perawat muda dapat dilibatkan dalam proyek kepemimpinan kecil di tempat kerja, seperti menjadi koordinator shift atau memimpin diskusi tim. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan praktis dan belajar dari pengalaman langsung.

b. Simulasi:

Penggunaan simulasi dalam pendidikan keperawatan memungkinkan perawat muda untuk melatih keterampilan kepemimpinan, seperti pengambilan keputusan di bawah tekanan atau pengelolaan situasi konflik, dalam lingkungan yang aman dan terkendali (Fowler, 2015). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga membantu perawat muda mengembangkan kepercayaan diri dalam peran kepemimpinan.

3. Penggunaan Teknologi untuk Pembelajaran Kepemimpinan

Teknologi telah menjadi alat yang penting dalam mendukung pembelajaran kepemimpinan. E-Learning dan Webinar: Platform pembelajaran daring memungkinkan perawat muda untuk mengakses modul pelatihan kepemimpinan kapan saja dan di mana saja. Webinar juga memberikan kesempatan untuk belajar dari pemimpin kesehatan global tanpa batasan geografis (Nursing Times, 2022). Aplikasi dan Simulasi Virtual: Teknologi simulasi berbasis realitas virtual (VR) dan aplikasi pembelajaran interaktif memberikan pengalaman yang imersif untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dengan skenario yang realistis, perawat muda dapat berlatih membuat keputusan yang kompleks dalam lingkungan virtual yang menyerupai situasi klinis nyata (Johnson et al., 2020).

Dengan mengintegrasikan pendidikan formal, pembelajaran berbasis pengalaman, dan teknologi, strategi pengembangan keterampilan kepemimpinan ini dapat memberikan dukungan yang komprehensif bagi perawat muda. Upaya ini tidak hanya memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka tetapi juga berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

F. Peran Organisasi Profesi dan Institusi dalam Mendukung Kepemimpinan

Peran organisasi profesi, rumah sakit, dan institusi pendidikan sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan kepemimpinan perawat muda. Dukungan dari program pengembangan karir serta kolaborasi yang erat antara rekan kerja dan manajer turut memperkuat kemampuan kepemimpinan perawat dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

1. Peran Organisasi Profesi, Rumah Sakit, dan Institusi Pendidikan

a. Organisasi Profesi:

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan kepemimpinan. PPNI menyediakan platform bagi perawat muda untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan konferensi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan. Selain itu, PPNI dapat memfasilitasi jaringan profesional untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik (PPNI, 2020).

b. Rumah Sakit:

Sebagai lingkungan kerja utama, rumah sakit bertanggung jawab menciptakan budaya kerja yang mendorong kepemimpinan. Ini termasuk menyediakan peluang bagi perawat muda untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan kecil, seperti menjadi kepala tim dalam proyek tertentu, serta memberikan penghargaan atas inisiatif dan inovasi (Curtis et al., 2011).

c. Institusi Pendidikan:

Institusi pendidikan keperawatan berperan penting dalam menyusun kurikulum yang memasukkan modul kepemimpinan. Program pendidikan berjenjang, seperti spesialisasi keperawatan atau pelatihan pascasarjana, memberikan kesempatan bagi perawat muda untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan (Fowler, 2015).

2. Program Pengembangan Karir untuk Perawat Muda

Program pengembangan karir menjadi alat utama untuk membekali perawat muda dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran kepemimpinan.

a. Program Mentoring:

Pendampingan oleh perawat senior membantu perawat muda mengenali potensi mereka, mengatasi hambatan psikologis, dan mempelajari strategi kepemimpinan yang efektif (Dyess et al., 2016).

b. Pelatihan dan Sertifikasi:

Pelatihan kepemimpinan berbasis kompetensi memberikan perawat muda akses ke sumber daya pembelajaran yang relevan. Beberapa sertifikasi seperti pelatihan manajemen konflik atau pengambilan keputusan berbasis bukti dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas mereka di lingkungan kerja (Johnson et al., 2020).

c. Pengembangan Karir Internal:

Banyak organisasi kesehatan mulai mengembangkan jalur karir internal yang memungkinkan perawat muda untuk naik ke posisi kepemimpinan secara bertahap, dengan dukungan pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan.

3. Dukungan dari Rekan Kerja dan Manajer

a. Kolaborasi Rekan Kerja:

Dukungan dari rekan kerja, baik dalam bentuk dorongan moral maupun kerjasama tim, membantu perawat muda untuk beradaptasi dengan peran kepemimpinan. Lingkungan kerja yang saling mendukung memperkuat rasa percaya diri dan mengurangi stres (Curtis et al., 2011).

b. Manajer dan Supervisor:

Peran manajer atau kepala ruang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan evaluasi. Kepemimpinan yang mendukung, seperti memberi umpan balik konstruktif dan menyediakan peluang pembelajaran, mendorong perawat muda untuk terus berkembang (Wong et al., 2013).

Dengan dukungan yang terstruktur dari organisasi profesi, rumah sakit, institusi pendidikan, serta kolaborasi di tempat kerja, perawat muda memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif. Upaya bersama ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan dan keberlanjutan tenaga kerja keperawatan yang kompeten.

G. Studi Kasus atau Kisah Inspiratif

Perawat muda yang berhasil menjadi pemimpin seringkali memiliki karakteristik seperti keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk bekerja dalam tim, kepemimpinan yang melayani (servant leadership), dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pasien dan rekan kerja. Kisah sukses ini dapat mencakup:

1. Perawat Muda dalam Posisi Kepemimpinan:

Cerita tentang perawat muda yang berhasil mengelola tim, memimpin proyek, atau menjadi kepala perawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Mereka mungkin telah menunjukkan inovasi dalam merancang program pelatihan atau meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Perawat yang Menginspirasi Rekan Kerja:

Kisah tentang perawat muda yang meskipun baru dalam dunia profesional, dapat memotivasi rekan-rekannya melalui etos kerja yang kuat, keterampilan interpersonal, dan kemauan untuk belajar dan berkembang.

3. Perawat yang Membawa Perubahan dalam Pelayanan Kesehatan:

Seorang perawat muda yang menciptakan atau mengimplementasikan prosedur baru yang meningkatkan efektivitas perawatan pasien atau meningkatkan kesejahteraan pasien dan staf.

Pembelajaran dari kisah nyata ini dapat memberikan wawasan berharga bagi perawat muda lainnya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain:

1. Kepemimpinan Dimulai dari Diri Sendiri:

Menjadi pemimpin tidak hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi juga tentang bagaimana perawat muda memimpin dirinya sendiri dalam hal disiplin, pengambilan keputusan, dan etika kerja.

2. Kemampuan Beradaptasi dan Belajar Terus-Menerus:

Seorang perawat muda yang sukses biasanya menunjukkan kesiapan untuk terus belajar, menerima umpan balik, dan beradaptasi dengan tantangan yang ada, baik itu dalam perawatan pasien atau dalam lingkungan kerja yang berubah.

3. Komunikasi yang Efektif:

Sebagai pemimpin, penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik dalam menyampaikan informasi kepada tim maupun mendengarkan kekhawatiran atau saran dari anggota tim lainnya.

4. Kolaborasi dan Teamwork:

Perawat muda yang berhasil menunjukkan pentingnya bekerja sama dengan rekan kerja dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif sering kali melibatkan pembagian tugas yang jelas dan dukungan terhadap satu sama lain.

5. Kemampuan Mengelola Stres dan Tekanan:

Perawat muda yang sukses sebagai pemimpin dapat mengelola stres dan tekanan yang datang dengan tanggung jawab yang besar, baik itu dalam menghadapi situasi darurat medis maupun dalam mengelola beban kerja.

Dengan menyampaikan contoh nyata dan pembelajaran dari pengalaman perawat muda yang sukses menjadi pemimpin, materi ini bertujuan untuk

memotivasi dan menginspirasi perawat muda lainnya untuk percaya pada kemampuan mereka dan terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka.

H. Dampak dari pengembangan kepemimpinan perawat muda

Berikut adalah penjelasan hasil-hasil penelitian tentang dampak dari pengembangan kepemimpinan perawat muda:

1. Peningkatan Kinerja Perawat

Penelitian oleh Garba (2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif pada kinerja perawat muda. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja perawat, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan keperawatan yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kepemimpinan perawat muda penting untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

2. Peningkatan Kepuasan Kerja Perawat

Dalam penelitian oleh Novita dan Kurniawati (2021), ditemukan bahwa gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan dan motivasi anggota tim berhubungan erat dengan kepuasan kerja perawat. Perawat muda yang dipimpin oleh pemimpin transformasional melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka, yang turut meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

3. Peningkatan Budaya Keselamatan Pasien

Penelitian oleh Dewi dan Suryani (2020) menyebutkan bahwa kepemimpinan yang efektif di rumah sakit tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan budaya keselamatan pasien. Perawat muda yang dipimpin oleh kepala ruang dengan keterampilan kepemimpinan yang baik lebih disiplin dalam menerapkan prosedur keselamatan, sehingga menurunkan angka insiden medis dan meningkatkan kualitas perawatan.

4. Peningkatan Soft Skills Perawat

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2022) mengungkapkan bahwa pemimpin yang memberikan dukungan terhadap pengembangan soft skills, seperti komunikasi dan empati, dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Perawat muda yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan cenderung lebih mahir dalam berinteraksi dengan pasien dan tim medis, yang berujung pada peningkatan keseluruhan kualitas perawatan.

I. Kesimpulan

Pengembangan keterampilan kepemimpinan untuk perawat muda sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim. Perawat muda yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kinerja individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan pasien. Pengembangan keterampilan kepemimpinan dapat dilakukan melalui pelatihan, mentoring, dan pengalaman langsung di lapangan, serta dengan membangun sikap proaktif dalam menghadapi tantangan profesional.

J. Referensi

- Almost, J., Wolff, A. C., Stewart-Pyne, A., McCormick, L. G., Strachan, D., & D'Souza, C. (2016). Managing and mitigating conflict in healthcare teams: An integrative review. *Journal of Advanced Nursing*, 72(7), 1490-1505.
- Curtis, E. A., de Vries, J., & Sheerin, F. K. (2011). Developing leadership in nursing: The impact of education and training. *British Journal of Nursing*, 20(6), 344-352.
- Curtis, E. A., Sheerin, F. K., & de Vries, J. (2011). Developing leadership in nursing: Exploring core factors. *British Journal of Nursing*, 20(5), 306-309.
- Dewi, M., & Suryani, I. (2020). *Leadership and Patient Safety Culture in Hospitals: A Case Study on Young Nurses*. *International Journal of Healthcare Leadership*, 15(4), 197-205.
- Dyess, S. M., Sherman, R. O., Pratt, B. A., & Chiang-Hanisko, L. (2016). Growing nurse leaders: Their perspectives on nursing leadership and today's practice environment. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(1).
- Fowler, J. (2015). Leadership and management in nursing: A guide for students and practitioners. *Nursing Management*, 22(5), 24-27.
- Garba, A. (2020). *The Impact of Transformational Leadership on Nurses' Work Performance*. *Journal of Nursing Leadership*, 12(3), 105-112.
- Huston, C. J. (2017). *Professional Issues in Nursing: Challenges and Opportunities*. Wolters Kluwer Health.
- Johnson, M. B., Carr, S. E., & Parker, M. H. (2020). Virtual simulation in nursing education: Current perspectives. *Journal of Nursing Education*, 59(11), 1-7.

- Kumaran, S., & Carney, M. (2014). Role transition from student nurse to staff nurse: Facilitating the transition period. *Nurse Education in Practice*, 14(6), 605-611.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Sage Publications.
- Novita, R., & Kurniawati, D. (2021). *The Role of Transformational Leadership in Enhancing Job Satisfaction among Young Nurses*. *Nursing Management Journal*, 8(2), 22-30.
- Nursing Times. (2022). The role of young nurses in adopting technology in healthcare. Retrieved from <https://www.nursingtimes.net>.
- O'Connell, J., Gardner, G., & Coyer, F. (2014). Beyond competencies: Using a capability framework in developing practice standards for advanced practice nursing. *Journal of Advanced Nursing*, 70(12), 2728-2735.
- PPNI. (2020). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI*. Jakarta: PPNI.
- Rahmat, F. (2022). *The Influence of Leadership Training on Soft Skills Development in Young Nurses*. *Journal of Nursing Practice and Education*, 18(1), 45-52.
- WHO. (2020). *State of the World's Nursing 2020: Investing in education, jobs, and leadership*. World Health Organization.
- Wong, C. A., Cummings, G. G., & Ducharme, L. (2013). The relationship between nursing leadership and patient outcomes: A systematic review update. *Journal of Nursing Management*, 21(5), 709-724.

K. Glosarium

Keterampilan Kepemimpinan:

Kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks profesional maupun pribadi.

Komunikasi Efektif:

Kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian, baik dalam konteks verbal maupun non-verbal.

Mentoring:

Proses pembimbingan di mana seorang profesional berpengalaman memberikan dukungan dan arahan kepada seorang individu yang lebih muda atau kurang berpengalaman untuk membantu perkembangan karier dan keterampilan.

Pemecahan Masalah:

Kemampuan untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang tepat dan efisien.

Pengambilan Keputusan:

Proses memilih tindakan atau pilihan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, terutama dalam situasi yang membutuhkan pertimbangan cepat dan tepat.

Perawat Muda:

Perawat yang baru memulai kariernya dalam dunia keperawatan, umumnya dengan pengalaman kerja yang terbatas namun memiliki potensi besar untuk berkembang.

Proaktif:

Sikap yang menunjukkan inisiatif dan kesiapan untuk bertindak sebelum masalah muncul, serta mencari cara untuk meningkatkan hasil atau menyelesaikan tantangan secara efektif.

PROFIL PENULIS



Rahma Yulis, S.Kep., Ns., M.Kep., Lahir di Soppeng, 04 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun (2012-2014) sebagai perawat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Pengalaman ini membuat penulis menyadari bahwa profesi sebagai perawat rentan mengalami penyakit dan kecelakaan akibat kerja, dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperbaiki manajemen keperawatan. Pengalaman ini mempengaruhi pilihan jurusan studi lanjut dan topik tesis penulis yaitu Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perawat. Saat ini penulis bekerja di Universitas Borneo Tarakan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja pada Perawat serta Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi terkait Manajemen Keperawatan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perawat. Tulisan dalam buku ini pun masih menjadi bagian dari kedua topik besar tersebut. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmayulis@borneo.ac.id



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua., Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS. Telogorejo Semarang. Saat ini penulis bekerja di Stikes Telogorejo Semarang mengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah Satu Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveior Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi : Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui e-mail: rusminippi@gmail.com

Motto: *"Living your life well", "Focus on goals, not obstacles"*

PROFIL PENULIS



Septian Mugi rahayu, Ners., M.Kep., Lahir di Palangka raya, 12 September 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Profesi Ners, Universitas Airlangga tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya, Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Anak serta Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mengajar, melakukan penelitian bersama sejawat dan melakukan pengabdian masyarakat bersama sejawat dan mahasiswa. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septianmugirahayu@gmail.com

Motto: "Respect other people like you want to be respected"



Syaiful, S.Pd., SKep., Ns., M.Pd., M.Kes., Lahir di Bima-NTB, , 23 Mei 1968, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Adibuwana Surabaya dengan gelar M.Pd pada tahun 2009 sedangkan gelar M.Kes diraih pada universitas Badaruddin Lombok Tengah NTB lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 Prodi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB sampai saat ini sudah dikonversi menjadi

Poltekkes Kememkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB mengampu mata kuliah Metodologi penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa dan Keperawatan Keluarga/Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, nara sumber berbagai workshop, dll, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syaiful6823@gmail.com

Motto: "Jangan sedih akibat salah mengambil keputusan, Mulailah mengatasi hal itu dengan membuat keputusan-keputusan yang bagus" Joyce Meyer, (1943)/

PROFIL PENULIS



Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Surabaya pada 15 Mei 1976, merupakan seorang akademisi dan praktisi keperawatan dengan pengalaman yang luas di bidangnya. Saat ini, beliau adalah staf pengajar tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus. Latar belakang pendidikan Ana Fadilah mencerminkan komitmennya terhadap pengembangan keilmuan di bidang keperawatan. Beliau menyelesaikan Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 1999, melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners di Universitas Airlangga

Surabaya pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Magister Manajemen Keperawatan dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016.

Sebagai seorang profesional, Ana Fadilah memiliki pengalaman kerja yang kaya di dunia keperawatan. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dengan penugasan di Bangsal Interna (2006–2007), Instalasi Gawat Darurat (2007), serta menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan (2007–2010). Selain itu, beliau juga mengemban tanggung jawab sebagai Clinical Instructor pada periode yang sama.

Dalam dunia pendidikan, Ana Fadilah pernah menjadi pengajar di AKPER PEMDA Lamongan (2008–2009) dan STIKES Muhammadiyah Lamongan (2007–2010). Sejak tahun 2015, beliau bergabung sebagai dosen tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus, di mana beliau terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pelatihan tenaga keperawatan.

Saat ini, Ana Fadilah sedang menempuh pendidikan lanjut di National Taipei University of Nursing and Health Sciences untuk meraih gelar Doktor (Ph.D.). Sebagai kandidat doktor, beliau fokus pada penelitian di bidang pelayanan perawatan paliatif, yang menjadi salah satu kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik keperawatan di Indonesia dan internasional. Dengan dedikasi dan pengalaman yang luas, Ana Fadilah terus berupaya memberikan dampak positif bagi profesi keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ana.fadilah15@gmail.com

Motto: "Empowering care, inspiring growth, and transforming lives through compassionate leadership."

PROFIL PENULIS



Ns. Viere Allanled Siauta, S.Kep., M.Kep lahir di Ambon, 08 September 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKes Pasapua Ambon lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Ners pada STIKes Immanuel Bandung dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani dan lulus pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Universitas Widya Nusantara Palu. Penulis merupakan dosen S-1 Keperawatan dan Profesi Ners dengan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Konsep Dasar keperawatan, Komunikasi Dasar Keperawatan, Komunikasi Terapeutik, Promosi Kesehatan dan Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, penelitian serta pengabdian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siauta.viere@gmail.com
Motto: "Selesaikan apa yang telah dimulai"



Sondang Tio Helena Manurung S.Kp, M.Kep Lahir di Medan, 13 Agustus 1975. Menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Program Studi Keperawatan Universitas Advent Indonesia tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Keperawatan Ilmu Keperawatan, STIK Sint Caralus dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai CI di institusi pendidikan dan sebagai perawat di Rumah Sakit Swastada sebagai dosen. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan mengampu mata kuliah Keperawatan dasar, Komunitas, Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, peneliti. Penulis dapat dihubungi melalui email sondang@binawan.ac.id

Sinopsis

Buku *Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan* mengajak pembaca untuk mendalami berbagai aspek penting dalam kepemimpinan yang berperan besar dalam manajemen keperawatan dan pengelolaan pelayanan kesehatan. Melalui panduan praktis dan teori yang mendalam, buku ini menggali peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efektivitas tim keperawatan.

Dimulai dengan pembahasan mengenai Kepemimpinan Transformasional dalam Keperawatan, buku ini menekankan pentingnya inovasi dan perubahan positif yang dapat membawa kemajuan dalam praktek keperawatan. Selanjutnya, dibahas pula Peran Kepala Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana kepala perawat dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan yang optimal.

Buku ini juga mengupas Kepemimpinan dalam Peningkatan Keselamatan Pasien, yang berfokus pada strategi untuk memastikan keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan. Selain itu, Peran Kepemimpinan dalam Menanggulangi Krisis Global Kesehatan menjelaskan bagaimana kepemimpinan keperawatan memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan besar seperti pandemi dan krisis kesehatan global.

Model Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan diperkenalkan sebagai pendekatan yang melibatkan seluruh anggota tim perawat dalam proses pengambilan keputusan, sementara Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan: Pembangunan Tim yang Efektif dalam Keperawatan menggambarkan bagaimana membangun dan memelihara tim perawat yang solid dan produktif.

Selain itu, buku ini memberikan wawasan mengenai Kepemimpinan dalam Manajemen Krisis di Rumah Sakit, yang mempersiapkan para pemimpin keperawatan untuk mengelola situasi darurat dan bencana. Mentoring dan Coaching untuk Perawat di Posisi Kepemimpinan juga menjadi topik yang diangkat untuk membimbing pemimpin perawat dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, serta mendidik perawat muda untuk mempersiapkan diri dalam peran kepemimpinan di masa depan.

Secara keseluruhan, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tantangan kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, serta memberikan wawasan yang praktis bagi para perawat yang ingin berkembang dalam profesinya dan memimpin dengan efektif di dunia perawatan kesehatan yang semakin kompleks.

Buku Bunga Rampai: Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan mengajak pembaca untuk mendalami berbagai aspek penting dalam kepemimpinan yang berperan besar dalam manajemen keperawatan dan pengelolaan pelayanan kesehatan. Melalui panduan praktis dan teori yang mendalam, buku ini menggali peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efektivitas tim keperawatan.

Dimulai dengan pembahasan mengenai Kepemimpinan Transformasional dalam Keperawatan, buku ini menekankan pentingnya inovasi dan perubahan positif yang dapat membawa kemajuan dalam praktek keperawatan. Selanjutnya, dibahas pula Peran Kepala Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, yang memberikan pemahaman tentang bagaimana kepala perawat dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan yang optimal.

Buku ini juga mengupas Kepemimpinan dalam Peningkatan Keselamatan Pasien, yang berfokus pada strategi untuk memastikan keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan. Selain itu, Peran Kepemimpinan dalam Menanggulangi Krisis Global Kesehatan menjelaskan bagaimana kepemimpinan keperawatan memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan besar seperti pandemi dan krisis kesehatan global.

Model Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan Keperawatan diperkenalkan sebagai pendekatan yang melibatkan seluruh anggota tim perawat dalam proses pengambilan keputusan, sementara Kepemimpinan dalam Manajemen Keperawatan: Pembangunan Tim yang Efektif dalam Keperawatan menggambarkan bagaimana membangun dan memelihara tim perawat yang solid dan produktif.

Selain itu, buku ini memberikan wawasan mengenai Kepemimpinan dalam Manajemen Krisis di Rumah Sakit, yang mempersiapkan para pemimpin keperawatan untuk mengelola situasi darurat dan bencana. Mentoring dan Coaching untuk Perawat di Posisi Kepemimpinan juga menjadi topik yang diangkat untuk membimbing pemimpin perawat dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, serta mendidik perawat muda untuk mempersiapkan diri dalam peran kepemimpinan di masa depan.

Secara keseluruhan, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tantangan kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, serta memberikan wawasan yang praktis bagi para perawat yang ingin berkembang dalam profesinya dan memimpin dengan efektif di dunia perawat kesehatan yang semakin kompleks.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7139-65-8



9

786347

139658